

EXAMEN ENAM EXTRAORDINARIO

II – 2026

PREGUNTA 1

Varón de 25 años, maratonista aficionado, realiza una carrera de alta intensidad sin calentamiento previo. A los minutos presenta dolor intenso y calambres en las pantorrillas, con gemelos muy contraídos y dolorosos a la palpación, que le impiden continuar el ejercicio. Desde el punto de vista bioquímico. ¿Qué fenómeno se produce en este cuadro?

- A. Disminución de piruvato
- B. Disminución de malonato
- C. Acumulación de oxalacetato
- D. Incremento de producción de lactato

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El músculo en ejercicio de alta intensidad consume oxígeno más rápido de lo que la circulación puede reponerlo, así que la mitocondria se queda corta y la célula tiene que seguir sacando ATP por la vía rápida: la glucólisis anaeróbica. El problema es que esa vía necesita reciclar NAD^+ para no frenarse, y la única forma de regenerarlo sin oxígeno es que el lactato deshidrogenasa tome el piruvato y lo convierta en lactato. Por eso, cuando el gemelo trabaja al límite sin haber calentado, el piruvato no baja: al contrario, se desvía masivamente hacia lactato, que se acumula, baja el pH intracelular y dispara el calambre doloroso. Que el piruvato disminuya no encaja porque justamente la glucólisis acelerada lo está produciendo en exceso; lo que cambia es su destino, no su cantidad. El malonato no es un metabolito que se mueva con el ejercicio: es un inhibidor de la succinato deshidrogenasa que se usa en el laboratorio, no algo que el músculo acumule al correr. El oxalacetato tampoco se acumula porque pertenece al ciclo de Krebs, que precisamente está frenado por falta de oxígeno, no sobrecargado.

VILLAPEPA ENAM: Ejercicio intenso sin oxígeno suficiente = glucólisis anaeróbica que regenera NAD^+ convirtiendo piruvato en lactato. El calambre por acidosis láctica no baja el piruvato, incrementa el lactato.

PREGUNTA 2

Secundigesta de 29 semanas, acude por pérdida de líquido claro por vagina desde hace 3 días. Examen: PA 110/70 mmHg, FC 86, T 36,8 °C; Abdomen: AU: 29 cm, SPP: LCI, LCF 150 x', útero indoloro, sin dinámica uterina. Tacto vaginal: D 0 cm, B 0%, M: rotas, líquido amniótico claro. Se inicia antibiótico profilaxis y maduración pulmonar. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- A. Cesárea de emergencia
- B. Cesárea a las 35 semanas
- C. Inducir labor de parto
- D. Manejo expectante

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Lo que define la conducta acá es la edad gestacional cruzada con la ausencia de infección y de trabajo de parto. Tienes una rotura prematura de membranas a las 29 semanas, es decir un pretérmino lejano del término, con útero indoloro, sin fiebre, sin taquicardia materna ni fetal que hagan pensar en corioamnionitis, y con líquido claro. En ese escenario el mayor enemigo del feto no es seguir dentro, sino nacer demasiado prematuro: cada día que se gane madurando el pulmón y ganando peso mejora el pronóstico. Por eso, una vez cubierta con antibiótico para prolongar el periodo de latencia y con corticoide para acelerar la madurez pulmonar, lo correcto es vigilar de cerca y prolongar el embarazo hasta que aparezca infección, sufrimiento fetal o se alcance la ventana de las 34 semanas. Terminar el embarazo de urgencia por cesárea solo se justificaría si hubiera corioamnionitis, desprendimiento o compromiso fetal, y nada de eso está presente. Poner fecha fija de cesárea a las 35 semanas ignora que la conducta se define por vigilancia diaria, no por un calendario rígido. Inducir el parto ahora sería empujar a un pretérmino de 29 semanas a nacer sin necesidad, exponiéndolo a las complicaciones de la prematuridad extrema cuando el cuadro todavía permite ganar tiempo.

VILLAPEPA ENAM: RPM pretérmino (29 sem) sin corioamnionitis ni trabajo de parto, ya con antibiótico y corticoide = manejo expectante con vigilancia estrecha. Se interrumpe solo si hay infección, compromiso fetal o se llega a la ventana de 34 semanas.

PREGUNTA 3

Mujer de 45 años, con antecedente de episodios recurrentes de dolor en hipocondrio derecho tipo cólico, relacionados a ingesta de comidas grasosas y que cedían con hioscina IV, acude a emergencia por dolor intenso continuo en epigastrio de 4 horas de evolución, que se irradia en banda hacia la región dorsal, asociado a vómitos biliosos repetidos. A diferencia de episodios previos, el dolor actual no mejora con hioscina IV. Abdomen: dolor predominantemente epigástrico sin defensa localizada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Pancreatitis aguda de origen biliar
- B. Gastritis aguda erosiva
- C. Enfermedad úlcero péptica no complicada
- D. Colecistitis aguda calculosa

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El pivote diagnóstico está en el cambio de patrón del dolor. Esta paciente venía teniendo cólicos biliares clásicos: dolor en hipocondrio derecho tras comidas grasosas, que cedían con un antiespasmódico porque eran contracciones de una vesícula litiasica. Ahora el dolor cambió de carácter: se hizo continuo en lugar de cólico, se mudó al epigastrio, se irradia en banda hacia la espalda y ya no responde a la hioscina. Ese giro es la firma de que un cálculo migró y se impactó en la vía biliopancreática, disparando la activación de las enzimas del páncreas dentro del propio órgano. El dolor en banda irradiado al dorso y los vómitos que no alivian son el sello de la pancreatitis, y el antecedente de litiasis explica el origen biliar, que es la primera causa en mujeres. La gastritis erosiva da ardor epigástrico, no un dolor transfixiante en banda, y no explica que un cuadro biliar previo se transforme así. La enfermedad ulcerosa no complicada tiene dolor epigástrico que suele calmar o modificarse con la comida, no irradiación dorsal ni vómito bilioso persistente. La colecistitis aguda mantendría el dolor anclado en hipocondrio derecho con signo de Murphy y fiebre, mientras acá el dolor se corrió al epigastrio y a la espalda, que es territorio pancreático.

VILLAPEPA ENAM: Cólico biliar de repetición que cambia a dolor epigástrico continuo, en banda hacia el dorso, con vómito que no alivia y que ya no cede al antiespasmódico = pancreatitis aguda biliar por migración de cálculo. El giro del patrón del dolor es la clave.

PREGUNTA 4

Recién nacido de 4 horas de vida, hijo de madre con diabetes mellitus mal controlada, nacido por cesárea a las 38 semanas, con peso adecuado. Presenta letargia, hipotonía, dificultad para alimentarse y rubicundez cutánea generalizada. Examen: FR 50 x', FC 140 x', SO 96% al aire ambiente, hemodinamia estable. El hematocrito es de 70% (valor previo 66% a la 1ª hora de vida). ¿Cuál es el manejo inicial más indicado?

- A. Aumento de líquidos IV
- B. Fototerapia intensiva
- C. Exanguinotransfusión parcial
- D. Eritropoyetina recombinante

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Fíjate en que este recién nacido junta dos cosas: un hematocrito venoso central de 70%, que ya está por encima del umbral que define policitemia neonatal, y síntomas claros de que esa sangre demasiado espesa no está circulando bien. La rubicundez es el reflejo del exceso de glóbulos rojos, y la letargia, la hipotonía y el rechazo al alimento indican que la hiperviscosidad está comprometiendo la perfusión cerebral. El hijo de madre diabética mal controlada es el candidato típico: la hiperglucemia materna dispara eritropoyesis fetal y el neonato nace con exceso de masa roja. Cuando la policitemia es sintomática y el hematocrito central supera el umbral crítico, la conducta es bajar la viscosidad retirando volumen de sangre y reponiéndolo con solución isotónica, que es exactamente lo que hace la exanguinotransfusión parcial: diluye el hematocrito sin descompensar la volemia. Aumentar líquidos por vía intravenosa hidrata, pero es una medida lenta y no retira la masa de glóbulos rojos que está causando el problema en un niño ya sintomático. La fototerapia trata la hiperbilirrubinemia, que puede venir después como consecuencia, pero no resuelve la hiperviscosidad actual. La eritropoyetina hace justo lo contrario de lo que se necesita: estimula producir más glóbulos rojos cuando el problema es que sobran.

VILLAPEPA ENAM: Hijo de madre diabética + hematocrito central mayor de 65% + síntomas de hiperviscosidad (letargia, hipotonía, rubicundez) = policitemia neonatal sintomática. Se trata con exanguinotransfusión parcial isovolumétrica para bajar la viscosidad, no con eritropoyetina ni solo líquidos.

PREGUNTA 5

Gestante de 24 años, previamente sana, consulta por infección respiratoria alta, niega síntomas urinarios. Examen: PA 110/70 mmHg, T 38,5 °C, no edemas. Lab: Examen de orina: proteinuria 1+ en tira reactiva, sedimento normal. La paciente se preocupa porque asocia "proteínas en la orina" con enfermedad renal grave. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A. Repetir examen de orina, explicar que la proteinuria aislada puede ser transitoria
- B. Indicar restricción proteica estricta y reposo absoluto
- C. Iniciar tratamiento inmunosupresor por sospecha de glomerulonefritis crónica
- D. Hospitalizar de inmediato por síndrome nefrótico en gestante

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Lo que hay que reconocer acá es que una proteinuria mínima, en tira reactiva, aislada y en el contexto de fiebre, casi siempre es transitoria y no significa enfermedad renal. La fiebre por sí sola puede hacer que la tira marque una cruz de proteínas, y esta gestante tiene presión normal, no tiene edemas, el sedimento urinario es normal y no hay ningún otro dato que apunte a daño glomerular. En una embarazada, la preeclampsia recién se plantea

con proteinuria significativa acompañada de hipertensión después de las 20 semanas, y nada de eso está presente. Entonces lo correcto y lo más sensato es no alarmar: se explica a la paciente que ese hallazgo puede ser pasajero, se trata la infección que motivó la consulta y se repite el examen de orina cuando esté afebril para confirmar que la proteinuria desaparece. Indicar restricción proteica y reposo absoluto no tiene ningún sustento y solo genera ansiedad y desnutrición proteica en una etapa donde el feto necesita aporte. Iniciar inmunosupresores por una glomerulonefritis que nadie ha demostrado sería tratar a ciegas una enfermedad inexistente, con riesgo real para la gestación. Hospitalizar por síndrome nefrótico es desproporcionado cuando falta lo esencial de ese síndrome: no hay proteinuria masiva, ni edemas, ni hipoalbuminemia.

VILLAPEPA ENAM: Proteinuria 1+ aislada, con sedimento normal, sin hipertensión ni edemas y en contexto febril = proteinuria transitoria benigna. La conducta es tranquilizar, tratar la infección y repetir el examen sin fiebre, no inmunosuprimir ni hospitalizar.

PREGUNTA 6

Recién nacido a término, 1 hora de vida, parto vaginal sin complicaciones, Apgar 8 y 9. Presenta cianosis central persistente con saturación de O_2 de 85% que no mejora tras 10 minutos de oxigenoterapia al 100% por mascarilla con reservorio. Se auscultan ruidos respiratorios bilaterales simétricos sin crepitantes ni sibilancias, frecuencia respiratoria 50 rpm, sin aleteo nasal ni quejido espiratorio. Frecuencia cardíaca 150 x', soplo cardíaco tenue y pulsos periféricos palpables. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Tetralogía de Fallot clásica
- B. Transposición de grandes vasos
- C. Síndrome de aspiración meconial moderado
- D. Neumonía congénita precoz

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El dato que decide todo es que la cianosis no mejora aunque le des oxígeno al 100%. Eso es un test de hiperoxia negativo, y significa que la sangre no se está oxigenando en el pulmón porque el problema no es pulmonar sino una mezcla anómala de circulaciones: hay sangre que llega al cuerpo sin haber pasado nunca por el intercambio gaseoso. Cuando esto ocurre en un recién nacido de horas de vida, a término, con pulmones que se auscultan limpios y simétricos y sin ningún signo de dificultad respiratoria, la causa más frecuente es la transposición de grandes vasos: la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar del izquierdo, de modo que quedan dos circuitos en paralelo y la sangre oxigenada nunca alcanza la aorta salvo por los cortocircuitos que van cerrándose. Por eso el niño está profundamente cianótico pese al oxígeno, pero sin lucha respiratoria. La tetralogía de Fallot también es cianótica, pero su presentación clásica no suele ser cianosis severa refractaria en la primera hora de vida, sino crisis más tardías que dependen del grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. La aspiración meconial daría pulmones sucios, con crepitantes, taquipnea marcada y antecedente de líquido meconial, nada de lo cual aparece acá. La neumonía congénita cursa con signos de dificultad respiratoria, quejido y alteración auscultatoria, mientras este niño tiene el pulmón limpio y solo destaca la cianosis que no responde al oxígeno.

VILLAPEPA ENAM: Cianosis central que no mejora con oxígeno al 100% (test de hiperoxia negativo) en un recién nacido con pulmones limpios y sin dificultad respiratoria = cardiopatía cianótica, y la más frecuente al nacer con este patrón es la transposición de grandes vasos.

PREGUNTA 7

En un hospital regional del Perú, un programa de vigilancia detecta que el 20 % de lactantes menores de 1 año hospitalizados por primera infección urinaria febril presentan cicatrices renales en el control con gammagrafía renal a los 6 meses. En la mayoría, la cistouretrografía miccional muestra una misma anomalía de la vía urinaria. Desde el punto de vista fisiopatológico y de salud pública, ¿cuál es la anomalía cuya detección y manejo oportuno tiene mayor impacto en reducir el riesgo de cicatrización renal y futuras complicaciones como hipertensión y enfermedad renal crónica en esta población?

- A. Estenosis de la unión pieloureteral
- B. Valvas de uretra posterior
- C. Doble sistema pielocalicial
- D. Reflujo vésicoureteral

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La pista está en unir tres cosas: infección urinaria febril, cicatrices renales en la gammagrafía y una misma anomalía que aparece en la cistouretrografía de la mayoría. Ese trío describe el mecanismo de la nefropatía por reflujo. Normalmente la unión del uréter con la vejiga funciona como una válvula que impide que la orina suba; cuando esa válvula es incompetente, la orina infectada de la vejiga refluye con presión hacia el riñón durante la micción, lleva bacterias al parénquima y desencadena pielonefritis repetidas que van dejando cicatrices. Esas cicatrices, acumuladas en un riñón que todavía está creciendo, son las que años después producen hipertensión y enfermedad renal crónica. Por eso detectar y manejar a tiempo el reflujo vesicoureteral es lo que más impacto tiene en cortar esa cadena. La cistouretrografía miccional es justamente el estudio que lo diagnostica, lo que encaja con que sea el hallazgo común. La estenosis de la unión pieloureteral produce hidronefrosis por obstrucción alta, pero no es lo que se ve típicamente en la cistografía tras una infección febril ni es el patrón de cicatrización por reflujo. Las valvas de uretra posterior son una obstrucción baja que afecta casi exclusivamente a varones y se manifiesta de forma más severa y precoz, no como el hallazgo mayoritario de una cohorte general de lactantes. El doble sistema pielocalicial puede asociarse a reflujo, pero por sí mismo es una variante anatómica que no explica el grueso del daño en esta población.

VILLAPEPA ENAM: Infección urinaria febril del lactante + cicatrices renales en gammagrafía + hallazgo repetido en la cistouretrografía = reflujo vesicoureteral. Es la anomalía cuyo diagnóstico y manejo oportuno más reduce la nefropatía por reflujo, la hipertensión y la enfermedad renal crónica futura.

PREGUNTA 8

Varón de 70 años con diagnóstico reciente de adenocarcinoma gástrico cuerpo-antral, estadio clínico IV por metástasis múltiples en hígado. Refiere baja de peso y anorexia, sin vómitos ni hemorragia digestiva. Hemodinamia estable. Sin comorbilidades graves. El servicio de cirugía descarta posibilidad de resección con intención curativa. ¿Cuál es la conducta terapéutica inicial más apropiada?

- A. Quimioterapia sistémica para controlar síntomas
- B. Gastrectomía total para reducir la carga tumoral
- C. Inmunoterapia en monoterapia como tratamiento de primera línea
- D. Resección parcial gástrica con bypass gastroentérico

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Lo que ordena la decisión es que se trata de un cáncer gástrico ya diseminado al hígado, estadio IV, donde la cirugía descartó cualquier intención curativa. En ese punto el objetivo del tratamiento deja de ser extirpar el

tumor y pasa a ser prolongar la supervivencia y controlar los síntomas con el menor daño posible, y eso lo cumple la quimioterapia sistémica, que actúa sobre la enfermedad en todos los sitios donde está, no solo en el estómago. En un paciente que además está estable, sin obstrucción ni sangrado que obliguen a intervenir, empezar por el tratamiento sistémico es lo que da mejor balance entre beneficio y riesgo. Quitar todo el estómago en un enfermo con metástasis hepáticas múltiples no cambia el curso de la enfermedad y lo somete a una cirugía mayor de la que difícilmente se recupera para ganar tiempo útil; la cirugía en estadio IV se reserva para complicaciones concretas como sangrado incontrolable u obstrucción, no como conducta inicial. La inmunoterapia sola no es el punto de partida estándar en esta situación, sino que se integra según las características del tumor y habitualmente acompañando a la quimioterapia, no reemplazándola de entrada. La resección parcial con bypass es una medida paliativa para desobstruir cuando el tumor cierra el paso de los alimentos, y este paciente no tiene vómitos ni obstrucción que la justifiquen ahora.

VILLAPEPA ENAM: Adenocarcinoma gástrico estadio IV con metástasis hepáticas, irresecable y sin complicación obstructiva ni hemorrágica = quimioterapia sistémica paliativa como conducta inicial. La cirugía en estadio IV solo se plantea para complicaciones puntuales, no para reducir carga tumoral.

PREGUNTA 9

En una comunidad rural andina, un niño de 2 años con dieta deficiente en carnes rojas y legumbres es llevado al centro de salud por palidez progresiva y taquicardia. El hemograma muestra: Hb 8 g/dL, VCM 65 fL, HCM disminuida y leucocitos y plaquetas en rangos normales. ¿Cuál es la causa más probable de su anemia?

- A. Hemolítica autoinmune
- B. Deficiencia de hierro
- C. Enfermedad crónica
- D. Deficiencia de vitamina B12

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Acá el patrón del hemograma cuenta la historia completa. El niño tiene una anemia con VCM bajo, es decir microcítica, y con hemoglobina corpuscular media también disminuida, o sea hipocrómica, mientras las otras dos series, blancos y plaquetas, están normales. Ese perfil de glóbulos rojos pequeños y pálidos, sin compromiso de las otras líneas, es la firma de la anemia por falta de hierro, y el contexto lo confirma: un niño de dos años en zona andina con dieta pobre en carnes rojas y legumbres tiene exactamente la carencia del mineral que se necesita para fabricar hemoglobina. Sin hierro suficiente, el eritrocito se produce chico y con poca hemoglobina, que es lo que miden el VCM y la HCM bajos. La anemia hemolítica autoinmune destruye glóbulos rojos y se acompaña de signos de hemólisis y suele ser normocítica o macrocítica por la reticulocitosis, no microcítica. La anemia de enfermedad crónica puede ser microcítica, pero requiere una enfermedad inflamatoria o infecciosa de fondo que aquí no existe, y el cuadro se explica sobradamente por la dieta. El déficit de vitamina B12 produce lo contrario en el tamaño: una anemia macrocítica, con VCM alto, así que un VCM de 65 lo descarta de entrada.

VILLAPEPA ENAM: Niño pequeño + dieta pobre en hierro + anemia microcítica hipocrómica (VCM y HCM bajos) con leucocitos y plaquetas normales = anemia ferropénica. El VCM bajo separa de entrada la ferropenia (micro) del déficit de B12 (macro).

PREGUNTA 10

Varón de 25 años acude por ictericia de inicio súbito posterior a dolor abdominal tipo cólico. Examen: vesícula biliar palpable. Bilirrubina directa sérica elevada. ¿Cuál es el marcador bioquímico sérico que espera encontrar elevado?

- A. Aspartato aminotransferasa
- B. Alanina aminotransferasa
- C. Glucuronosiltransferasa
- D. Fosfatasa alcalina

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El cuadro apunta a una ictericia obstructiva. Tienes ictericia de aparición brusca tras un cólico, con vesícula palpable y una bilirrubina que sube a expensas de la fracción directa, es decir la ya conjugada por el hígado. Que sea directa la que se eleva significa que el hígado sí procesó la bilirrubina pero esta no puede salir hacia el intestino porque la vía biliar está obstruida, y refluye a la sangre. En ese escenario de colestasis, la enzima que se dispara es la que vive en el epitelio de los conductos biliares y que la obstrucción induce a liberar: la fosfatasa alcalina. Por eso el marcador que esperas encontrar elevado, coherente con el patrón obstructivo, es ese. Las aminotransferasas, tanto la aspartato como la alanina, marcan daño del hepatocito, es decir un patrón de lesión celular hepática; pueden subir algo en una obstrucción, pero no son el marcador que define la colestasis ni el que se pide como característico de este patrón. La glucuronosiltransferasa es la enzima intracelular que conjuga la bilirrubina dentro del hepatocito, no es un marcador sérico que uno dose para evaluar obstrucción; además, si estuviera fallando esa conjugación, la bilirrubina que subiría sería la indirecta, justo lo contrario de lo que muestra este paciente.

VILLAPEPA ENAM: Ictericia obstructiva (bilirrubina directa elevada, vesícula palpable tras cólico) = patrón colestásico con fosfatasa alcalina elevada. Las transaminasas marcan daño del hepatocito; la fosfatasa alcalina marca obstrucción de la vía biliar.

PREGUNTA 11

En una clínica, el administrador desea medir la productividad del médico en consulta externa, definida como el número de atenciones realizadas en relación con el recurso médico utilizado por unidad de tiempo. ¿Qué indicador describe mejor este concepto?

- A. Relación entre número de consultas y número de egresos
- B. Porcentaje de internamiento a través de consulta externa
- C. Porcentaje de consultas programadas atendidas
- D. Rendimiento hora médico en consulta externa

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La pregunta te da la definición exacta del indicador y te pide ponerle nombre: atenciones producidas por recurso médico y por unidad de tiempo. Eso es literalmente un cociente entre producto (consultas) e insumo por tiempo (horas de médico), y ese cociente tiene un nombre en gestión: rendimiento hora médico. Mide cuántas atenciones genera cada hora de trabajo médico, que es la definición pura de productividad. Cuando un indicador junta producción sobre recurso sobre tiempo, estás midiendo eficiencia productiva, y ninguno de los otros lo hace. Relacionar consultas con egresos mezcla la actividad ambulatoria con la hospitalaria y sirve para estimar cuántas consultas terminan en internamiento, no la productividad por hora. El porcentaje de internamiento a través de consulta externa mide una proporción de derivación, es decir qué fracción de los que consultan

terminan hospitalizados, que es un dato de flujo, no de productividad. El porcentaje de consultas programadas atendidas mide cumplimiento de agenda o inasistencia, o sea si el paciente vino o no, pero no relaciona la producción con el recurso médico invertido por tiempo.

VILLAPEPA ENAM: Producción (atenciones) sobre recurso médico y por unidad de tiempo = rendimiento hora médico. Es el indicador puro de productividad. Los que mezclan egresos o internamiento miden flujo o derivación, no productividad.

PREGUNTA 12

Niño de 9 años evaluado en consulta ambulatoria por aumento progresivo de peso en el último año. Para el tamizaje y el seguimiento inicial de su estado nutricional, ¿Cuál es la medida antropométrica más útil y estandarizada?

- A. Pliegue cutáneo tricipital exclusivamente
- B. Circunferencia cintura únicamente
- C. Índice de Masa Corporal
- D. Bioimpedancia eléctrica portátil

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Para tamizar y seguir el estado nutricional de un niño necesitas una medida que sea barata, reproducible, comparable contra referencias por edad y sexo, y que cualquier consultorio pueda repetir en cada control. El índice de masa corporal cumple todo eso: se calcula con peso y talla, se ubica en las curvas de percentiles o puntaje Z para la edad, y permite ver la tendencia a lo largo del tiempo, que es justo lo que se necesita en un niño que está ganando peso progresivamente. Por eso es la herramienta estandarizada de tamizaje y seguimiento. El pliegue cutáneo tricipital estima grasa subcutánea, pero depende mucho de quién y cómo lo mida, tiene alta variabilidad entre observadores y no es la medida de primera línea para tamizar. La circunferencia de cintura aporta información sobre distribución de grasa abdominal y riesgo metabólico, pero es complementaria: no reemplaza al IMC como cribado inicial del estado nutricional global. La bioimpedancia estima composición corporal, pero requiere equipo, se afecta por el estado de hidratación y no es la medida estandarizada de tamizaje en atención primaria pediátrica.

VILLAPEPA ENAM: Tamizaje y seguimiento nutricional de un niño = índice de masa corporal para la edad y sexo, por barato, reproducible y comparable en el tiempo. Pliegues, cintura y bioimpedancia son complementarios, no el cribado inicial.

PREGUNTA 13

Mujer de 24 años, con amenorrea de 6 semanas, acude a emergencia por dolor pélvico intenso en fosa iliaca izquierda, diaforética y pálida. Examen: PA 90/60 mmHg, FC 118 x', Especuloscopia: sangrado escaso transorifical, fondo de saco de Douglas doloroso y abombado. Tacto vaginal: útero 7 cm con dolor intenso a la movilización y en anexo izquierdo. ¿Cuál es el diagnostico más probable?

- A. Embarazo ectópico
- B. Enfermedad molar
- C. Amenaza de aborto
- D. Quiste a pedículo torcido

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Junta las piezas: una mujer en edad fértil con amenorrea de seis semanas, es decir muy probablemente embarazada, que llega con dolor pélvico intenso lateralizado, pálida, diaforética, hipotensa y taquicárdica. Ese estado de shock incipiente en una gestante temprana con dolor anexial habla de sangre en la cavidad, y el examen lo confirma: el fondo de saco de Douglas está doloroso y abombado, que es el signo de hemoperitoneo, y hay dolor intenso a la movilización cervical y en el anexo izquierdo. Todo eso arma el cuadro de un embarazo ectópico complicado: el embrión implantado fuera del útero, casi siempre en la trompa, que se rompe y sangra a la cavidad. El sangrado vaginal escaso a pesar del compromiso hemodinámico es típico, porque la mayor parte de la sangre va al abdomen, no sale por vagina. La enfermedad molar cursa con útero mayor al esperado para la edad gestacional, sangrado más abundante y elevación desproporcionada de la gonadotropina, no con abdomen agudo por hemoperitoneo. La amenaza de aborto da sangrado con dolor cólico central y cuello cerrado, pero no produce shock ni Douglas abombado ni dolor anexial lateralizado. El quiste ovárico torcido sí da dolor anexial agudo, pero no explica la amenorrea con prueba de embarazo positiva ni el hemoperitoneo con inestabilidad; el contexto de gestación temprana con shock apunta a la trompa rota.

VILLAPEPA ENAM: Amenorrea + dolor anexial + shock con sangrado vaginal escaso + Douglas doloroso y abombado (hemoperitoneo) = embarazo ectópico complicado. La sangre va al abdomen, no a la vagina; por eso el sangrado externo es mínimo pese a la inestabilidad.

PREGUNTA 14

Pedro, de 11 meses de edad, desde hace 2 días presenta heces líquidas 4 episodios por día de mediano volumen e irritabilidad, ha presentado 2 vómitos de escaso volumen. Examen: eutrófico, mucosas secas, llora con escasas lágrimas, signo del pliegue mayor de 2 segundos, abdomen: distendido, RHA ausentes, doloroso a la palpación. ¿Cuál es la terapia de rehidratación indicada?

- A. Solución Polielectrolítica (SPE) IV
- B. Suero fisiológico IV
- C. Dextrosa 5% IV
- D. Solución de Rehidratación Oral (SRO) por gastroclisis

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Acá hay dos decisiones encadenadas. La primera es reconocer que el niño tiene deshidratación con signos claros: mucosas secas, llanto sin lágrimas y pliegue que tarda más de dos segundos en volver. La segunda, y la que define la respuesta, es que el abdomen está distendido, doloroso y con ruidos hidroaéreos ausentes, es decir hay íleo. Cuando el intestino está paralizado, la vía digestiva no funciona: cualquier líquido que metas por sonda no se va a absorber y encima puedes empeorar la distensión, así que la rehidratación oral o por gastroclisis queda descartada por el propio cuadro abdominal. Eso obliga a rehidratar por vía intravenosa. Y entre las soluciones intravenosas, la que corrige la deshidratación por diarrea es una solución polielectrolítica, porque repone agua junto con los electrolitos que se están perdiendo en las heces, que es lo que el niño necesita. El suero fisiológico solo aporta sodio y cloro, sin el potasio ni el resto de electrolitos que la diarrea depleta, así que corrige volumen pero no la pérdida electrolítica completa. La dextrosa al 5% es agua con glucosa, prácticamente sin electrolitos, y usada sola en un deshidratado por diarrea puede agravar el desequilibrio. La rehidratación oral por gastroclisis sería la elección si el intestino funcionara, pero con íleo y ruidos ausentes la vía enteral está contraindicada.

VILLAPEPA ENAM: Deshidratación por diarrea + abdomen distendido con ruidos ausentes (íleo) = la vía oral

o gastroclisis queda contraindicada, se rehidrata por vía intravenosa con solución polielectrolítica, que repone agua y el conjunto de electrolitos perdidos.

PREGUNTA 15

Mujer de 40 años con enfermedad de Graves diagnosticada hace 12 meses, en tratamiento con metimazol 30 mg/día y propranolol 40 mg cada 8 horas. A pesar de buena adherencia, persisten síntomas de hipertiroidismo y sensación de ahogo al decúbito. Examen: bocio difuso grado III con signos de compresión traqueal y exoftalmos marcado con oftalmopatía activa. Laboratorio: TSH suprimida y T4 libre elevada. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A. Agregar propiltiouracilo al esquema
- B. Aumentar la dosis de metimazol
- C. Indicar tiroidectomía total
- D. Yodo radiactivo (I-131)

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Dos datos convierten este caso en quirúrgico. El primero es que el hipertiroidismo sigue activo pese a un año de antitiroideo bien tomado, o sea es refractario al tratamiento médico. El segundo, y el más pesado, es que el bocio ya es grande y comprime la tráquea, con ahogo al acostarse; ese componente mecánico no lo resuelve ninguna pastilla ni ninguna dosis de yodo, solo sacar la glándula. A eso se suma que tiene oftalmopatía activa marcada. La suma de bocio compresivo más enfermedad refractaria más oftalmopatía activa apunta directo a la tiroidectomía total, que corrige de un golpe el exceso hormonal y el efecto de masa sobre la vía aérea. Agregar propiltiouracilo o subir la dosis de metimazol es insistir en la misma vía que ya fracasó y, aunque bajaran la hormona, seguirías con la tráquea comprimida sin resolver. El yodo radiactivo está desaconsejado justamente cuando la oftalmopatía está activa porque tiende a empeorarla, y además hace efecto de forma lenta, provocando incluso una inflamación transitoria de la glándula que en un bocio que ya aprieta la tráquea es peligroso; no sirve para una compresión que necesita solución inmediata.

VILLAPEPA ENAM: Graves refractario a antitiroideos + bocio con compresión traqueal + oftalmopatía activa = tiroidectomía total. El yodo radiactivo se evita con oftalmopatía activa (la empeora) y no descomprime la tráquea; subir antitiroideos no resuelve el efecto de masa.

PREGUNTA 16

Un médico del primer nivel de atención en una zona rural del Perú identifica un aumento inusual de casos de diarrea aguda en los últimos 7 días, sospechando un brote de enfermedad transmitida por agua. Para cumplir con la función esencial de vigilancia epidemiológica, ¿Cuál es la acción inmediata que debe realizar?

- A. Notificar los casos sospechosos al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) y coordinar la toma de muestras de agua y heces para su análisis
- B. Organizar charlas de educación sanitaria en escuelas sobre higiene de manos y manipulación de alimentos
- C. Distribuir de forma masiva medicamentos antidiarreicos a la población afectada sin esperar evaluación clínica individual
- D. Gestionar con las autoridades locales la construcción de nuevos pozos de agua para la comunidad

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La pregunta te ancla en una función concreta: vigilancia epidemiológica ante un brote. Y lo primero que exige la vigilancia frente a un aumento inusual de casos es doble y simultáneo: avisar al sistema para que se active la respuesta organizada, y confirmar la causa recogiendo muestras del presunto vehículo, que aquí es el agua, y de los enfermos, es decir las heces. Notificar sin investigar dejaría el brote sin explicación; investigar sin notificar aislaría al médico de la maquinaria de salud pública que puede intervenir a escala. Por eso la acción inmediata correcta une ambas cosas. Las charlas de educación sanitaria son valiosas como prevención sostenida, pero no son la acción inmediata frente a un brote en curso: no cortan la transmisión que ya está ocurriendo. Repartir antidiarreicos de forma masiva sin evaluar a cada paciente es directamente peligroso, porque en una diarrea infecciosa esos fármacos pueden retener el patógeno y agravar cuadros, y además no ataca la fuente. Construir nuevos pozos es una medida estructural correcta a mediano plazo para el saneamiento, pero toma tiempo y no resuelve la emergencia del brote que hay que contener ahora.

VILLAPEPA ENAM: Brote sospechoso frente a la función de vigilancia = notificar al sistema y tomar muestras del vehículo (agua) y de los enfermos (heces) de inmediato. Educación y saneamiento son medidas de fondo, no la respuesta inmediata al brote en curso.

PREGUNTA 17

Los anestésicos locales inyectados accidentalmente en el torrente sanguíneo pueden producir colapso cardiovascular. ¿Cuál de los siguientes anestésicos presenta las complicaciones cardiovasculares más severas?

- A. Bupivacaína
- B. Levocaína
- C. Ropivacaína
- D. Lidocaína

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La clave está en cuál de estos anestésicos se queda pegado más tiempo al canal de sodio del corazón, porque de eso depende su toxicidad cardíaca. La bupivacaína es la más liposoluble y la que se une con más fuerza y se suelta más lento de esos canales, así que cuando llega en exceso a la sangre bloquea la conducción cardíaca de forma prolongada y produce arritmias graves y colapso que son notoriamente difíciles de revertir, incluso resistentes a la reanimación habitual. Por eso es el anestésico local con la cardiotoxicidad más severa y el que más respeto exige al calcular dosis y al aspirar antes de inyectar. La lidocaína también es cardiotoxica si se sobredosifica, pero se une y se suelta rápido del canal, así que su toxicidad es más manejable y de hecho a dosis controladas se usa como antiarrítmico. La ropivacaína se diseñó precisamente para conservar la potencia anestésica de la bupivacaína pero con menor afinidad cardíaca, de modo que es bastante menos cardiotoxica. La levocaína no es un anestésico local de uso reconocido en este grupo, así que no compete como respuesta; el patrón de cardiotoxicidad severa lo define la bupivacaína.

VILLAPEPA ENAM: El anestésico local más cardiotoxico es la bupivacaína: se une fuerte y se suelta lento del canal de sodio cardíaco, produciendo colapso difícil de revertir. La ropivacaína nació para ser menos cardiotoxica y la lidocaína se suelta rápido del canal.

PREGUNTA 18

Un estudiante realiza la búsqueda de antecedentes de su investigación empleando revisiones sistemáticas. ¿A qué tipo de fuente ha accedido?

- A. Secundaria
- B. Primaria
- C. Terciaria
- D. Cuaternaria

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Lo que hay que distinguir es quién genera el dato y quién lo procesa. Una fuente primaria es la que produce conocimiento nuevo de primera mano: el estudio original, el ensayo clínico, el artículo donde se reportan los resultados por primera vez. Una revisión sistemática no genera datos nuevos, sino que rastrea, selecciona y sintetiza muchos estudios primarios ya publicados para dar una respuesta integrada; ese acto de recopilar y resumir lo ya producido es exactamente lo que define a una fuente secundaria. Por eso el estudiante que se apoya en revisiones sistemáticas está usando fuente secundaria. Llamarla primaria confundiría el resumen con el estudio original, que es justo lo que la revisión no es. Las fuentes terciarias son las que organizan e indexan las secundarias y primarias para facilitar su localización, como las enciclopedias, los directorios o las bases de datos que apuntan a otros trabajos, no una síntesis analítica de resultados. La categoría cuaternaria no forma parte de la clasificación estándar de fuentes de información en investigación, así que no aplica.

VILLAPEPA ENAM: Revisión sistemática = fuente secundaria: recopila y sintetiza estudios primarios ya publicados, no genera datos nuevos. La primaria es el estudio original; la terciaria indexa y organiza (enciclopedias, bases de datos).

PREGUNTA 19

Varón de 50 años con cirrosis hepática alcohólica, acude por hematemesis abundante y melena de 6 horas de evolución. Hemodinamia estable tras carga inicial de cristaloides. La endoscopia digestiva alta urgente muestra várices esofágicas con sangrado activo. ¿Cuál es la conducta terapéutica de elección a seguir?

- A. Mantener hidratación y administrar omeprazol IV en infusión continua
- B. Indicar ácido tranexámico en bolo y evitar endoscopia
- C. Indicar ligadura endoscópica de las várices e iniciar vasoconstrictor esplácnico (octreótido)
- D. Administrar antibióticos profilácticos por riesgo de infección bacteriana

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El sangrado ya tiene nombre y apellido: várices esofágicas rotas en un cirrótico, confirmadas con sangrado activo en la endoscopia. En ese escenario el tratamiento definitivo ataca la várice por dos frentes a la vez. Por un lado, la ligadura endoscópica pone bandas que estrangulan y ocluyen la várice sangrante, controlando la hemorragia en el mismo acto en que se la ve. Por otro, el vasoconstrictor esplácnico, como el octreótido, baja el flujo y la presión en el sistema portal, que es la fuerza que está empujando la sangre por esas várices; al reducir esa presión disminuye el resangrado y se ayuda a la hemostasia. Por eso la combinación de ligadura más droga vasoactiva es la conducta de elección. El omeprazol en infusión es el tratamiento de la úlcera péptica sangrante, no de la várice, cuyo mecanismo es la hipertensión portal y no el ácido; sirve como acompañante pero nunca como conducta principal aquí. El ácido tranexámico con la orden de evitar la endoscopia va en

B. Beneficencia

C. Autonomía

D. Justicia

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El detalle que orienta el principio es que el paciente, competente y consciente, manifiesta expresamente su deseo de recibir todas las medidas disponibles. Cuando la decisión se fundamenta en respetar la voluntad declarada del propio paciente sobre su tratamiento, el principio que se está honrando es la autonomía: el derecho de la persona a decidir sobre su cuerpo y su atención una vez informada. El médico solicita la UCI precisamente para dar cumplimiento a esa voluntad, y por eso lo que sostiene la decisión es la autonomía. La beneficencia también está presente de fondo, porque ingresar a UCI busca su bien, pero ese principio se centra en el juicio del médico sobre lo que conviene al paciente, no en el deseo que el paciente acaba de expresar, que es lo que la pregunta subraya. La no maleficencia se refiere a no causar daño, y aquí no se está evitando un daño sino respondiendo a una petición de tratamiento. La justicia entra en juego cuando hay que repartir un recurso escaso entre varios, pero el enunciado aclara que hay cama disponible, así que no hay conflicto de asignación que resolver.

VILLAPEPA ENAM: La decisión se apoya en el deseo expresado por el paciente competente = autonomía. La beneficencia parte del juicio del médico, no del deseo del paciente; la justicia entraría solo si el recurso fuera escaso, y aquí hay cama disponible.

PREGUNTA 22

Primigesta de 39 semanas, acude a control prenatal. Examen: AU: 30 SPP: LCI, LCF: 144 x'. Ecografía: ponderado fetal en percentil 8, líquido amniótico disminuido, doppler de arteria umbilical y cerebral media normal. ¿Cuál es la conducta obstétrica más adecuada?

A. Inducción de trabajo de parto

B. Esperar hasta las 41 semanas

C. Programar cesárea inmediata

D. Control ecográfico semanal

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que pesar tres datos juntos: la gestación ya está a término con 39 semanas, el feto está pequeño con un peso en percentil 8, y el líquido amniótico está disminuido. El oligohidramnios en un feto pequeño a término es la señal de que el ambiente intrauterino ya no es óptimo y que prolongar el embarazo no aporta beneficio y sí riesgo. Por eso la conducta es terminar la gestación ahora. Como el doppler de la arteria umbilical y de la cerebral media está normal, el feto todavía no muestra signos de descompensación circulatoria, lo que indica que tolera el trabajo de parto y permite intentar la vía vaginal: de ahí que la inducción del trabajo de parto sea lo más adecuado. Esperar hasta las 41 semanas es lo contrario de lo que pide el cuadro: alargar la exposición de un feto ya comprometido por el oligohidramnios. La cesárea inmediata sería la opción si el doppler estuviera alterado o hubiera sufrimiento fetal, pero con estudios de flujo normales no se justifica saltar directo a cirugía. El control ecográfico semanal es la conducta de vigilancia para un feto pequeño pretérmino con bienestar conservado, no para uno que ya llegó al término y además tiene el líquido bajo.

VILLAPEPA ENAM: Feto pequeño (percentil 8) + oligohidramnios a término (39 sem) con doppler normal =

terminar la gestación por inducción. El doppler conservado permite intentar vía vaginal; se reserva cesárea para flujos alterados o compromiso fetal.

PREGUNTA 23

Varón de 34 años, técnico electricista, sufre una descarga eléctrica de alto voltaje con punto de entrada en la mano derecha y punto de salida en el pie izquierdo. La piel en ambos sitios muestra solo lesiones superficiales iniciales. Desde el punto de vista de la fisiopatología de la quemadura eléctrica, ¿Qué tejido es el que probablemente ha sufrido el mayor daño estructural profundo a lo largo del trayecto de la corriente?

- A. Tejido óseo cortical del segmento atravesado por la corriente eléctrica
- B. Músculo en contacto íntimo con el hueso a lo largo del trayecto de la corriente
- C. Piel de la mano derecha en el punto ingreso de la descarga eléctrica
- D. Tejido graso subcutáneo próximo al punto de salida de la corriente

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La trampa de la quemadura eléctrica es que engaña por fuera: la piel de entrada y salida puede verse casi intacta mientras por dentro el daño es enorme, y por eso se la llama la lesión del iceberg. Para entender qué tejido sufre más hay que pensar en resistencia y calor. El hueso es el tejido de mayor resistencia al paso de la corriente, así que se calienta muchísimo y actúa como una estufa interna. Ese calor acumulado en el hueso se irradia hacia lo que tiene pegado, y lo que está en contacto íntimo con el hueso es el músculo profundo, que termina cocinándose por ese calor retenido y sufre la necrosis más extensa a lo largo del trayecto. Por eso el tejido con mayor daño estructural profundo es el músculo peri-óseo, y esa necrosis muscular masiva es la que libera mioglobina y amenaza el riñón. Decir que el máximo daño es el hueso cortical confunde al que genera el calor con el que más se destruye: el hueso resiste y se calienta, pero el que se necrosa masivamente es el músculo vecino. La piel de la mano solo muestra la lesión superficial de entrada, que es la punta visible del problema, no el daño profundo. La grasa subcutánea tiene baja conducción y no es el asiento principal de la destrucción a lo largo del trayecto.

VILLAPEPA ENAM: En la quemadura eléctrica el hueso tiene la mayor resistencia y se calienta como una estufa interna; el que más se necrosa es el músculo en contacto con el hueso. Piel casi intacta con daño profundo masivo: lesión del iceberg, con riesgo de mioglobinuria.

PREGUNTA 24

Varón de 25 años agredido con arma blanca, presenta herida penetrante de 2,5 cm en el tercio medio del hemitórax derecho, con entrada y salida de aire con cada respiración. Examen: consciente, ansioso, FR 32 x', FC 118 x', PA 100/60 mmHg, SO 88% al aire ambiente, MV disminuido ipsilateral, no ingurgitación yugular. El establecimiento solo cuenta con material básico de curaciones, oxígeno por cánula nasal y un resucitador manual (AMBU) (no dispone de tubos de tórax ni ventilador mecánico). ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada que el médico debe realizar, respetando el principio ético de no maleficencia?

- A. Aplicar oxígeno suplementario y no manipular la herida para evitar complicaciones y priorizar únicamente la referencia inmediata al hospital de mayor complejidad
- B. Ventilaciones con AMBU y ocluir completamente la herida con un vendaje hermético en cuatro lados para evitar toda entrada de aire desde el exterior antes de la referencia

C. Aplicar oxígeno suplementario y colocar un vendaje oclusivo sobre la herida, fijado en tres lados, improvisándolo con material disponible, mientras organiza referencia urgente

D. Ventilaciones con AMBU y colocar gasas estériles húmedas sobre la herida sin fijarlas firmemente y administrar únicamente analgesia, postergando otras intervenciones hasta llegar al hospital

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La herida que entra y sale aire con cada respiración describe un neumotórax abierto: el aire ambiente se cuela por el defecto de la pared en la inspiración y colapsa el pulmón. El manejo inicial con recursos limitados tiene una lógica muy fina que se apoya justo en el principio de no dañar. Se coloca un apósito oclusivo pero fijado solo por tres de sus cuatro lados, de modo que funcione como una válvula: durante la espiración el lado libre se abre y deja escapar el aire acumulado, y durante la inspiración se pega contra la herida e impide que entre aire nuevo. Así se corrige el neumotórax abierto sin crear uno peor. Sellar la herida por los cuatro lados es precisamente el error que la pregunta castiga: si tapas herméticamente, el aire que sigue entrando al tórax por otras vías ya no tiene por dónde salir y se convierte en un neumotórax a tensión, que comprime el corazón y mata; eso sería causar daño. No tocar la herida y solo referir deja el neumotórax abierto activo durante todo el traslado, con el pulmón colapsándose. Poner gasas húmedas sin fijar y solo dar analgesia no controla la entrada de aire ni construye la válvula, así que tampoco resuelve el mecanismo.

VILLAPEPA ENAM: Neumotórax abierto (herida torácica soplante) con recursos básicos = apósito oclusivo fijado en tres lados, que hace de válvula: deja salir aire en espiración e impide su entrada en inspiración. Sellar en cuatro lados provoca neumotórax a tensión.

PREGUNTA 25

Mujer de 88 años con antecedente de EPOC con oxígeno domiciliario e insuficiencia cardíaca, en tratamiento de gonartrosis con AINES. Presenta desde hace 12 horas dolor abdominal intenso, sin signos de peritonitis. TC abdominal: neumoperitoneo escaso, sin colección. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- A. Anastomosis gastroyeyunal de derivación
- B. Tratamiento con ATB, omeprazol y aspiración SNG
- C. Observación ambulatoria sin antibióticos y omeprazol
- D. Gastrectomía total inmediata y esófago yeyuno anastomosis

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El escenario junta una úlcera perforada por consumo de antiinflamatorios, evidenciada por el neumoperitoneo, con dos matices que cambian la conducta. El primero es que la perforación parece sellada y contenida: el aire libre es escaso, no hay colección y, sobre todo, no hay signos de peritonitis, es decir el contenido no se está derramando libremente. El segundo es que la paciente tiene 88 años con EPOC oxígeno-dependiente e insuficiencia cardíaca, un riesgo quirúrgico altísimo en quien una laparotomía puede ser letal. Cuando una perforación está sellada y el paciente es demasiado frágil para operar, existe una vía no quirúrgica que consiste en poner al tubo digestivo en reposo y dejar que la perforación cierre sola: nada por boca, aspiración por sonda nasogástrica para descomprimir el estómago, inhibidor de la bomba de protones para frenar el ácido y antibióticos para cubrir la contaminación. Eso es exactamente lo que ofrece esa alternativa. Las cirugías mayores, tanto la derivación gastroyeyunal como la gastrectomía total con reconstrucción, son desproporcionadas para una perforación sellada y temerarias en una anciana con esa comorbilidad respiratoria y cardíaca. La observación ambulatoria sin antibióticos ni protección gástrica es imprudente: hay contaminación

peritoneal por el neumoperitoneo que exige cobertura, y mandarla a casa sin tratamiento la deja expuesta a que evolucione a peritonitis franca.

VILLAPEPA ENAM: Úlcera perforada por AINE, sellada (neumoperitoneo escaso, sin peritonitis) en anciana de altísimo riesgo quirúrgico = manejo conservador: nada por boca, aspiración por sonda, inhibidor de bomba y antibióticos. La cirugía mayor es temeraria si la perforación está contenida.

PREGUNTA 26

Mujer de 60 años, sexualmente activa, acude por sensación de bulto en vagina. Tiene antecedente de histerectomía abdominal total hace 15 años por miomatosis uterina. Examen: Prolapso estadio IV, cúpula vaginal +7 cm. ¿Cuál es la conducta quirúrgica más adecuada?

- A. Colpocleisis total
- B. Colpoperineoplastia anterior
- C. Colposacropexia laparoscópica
- D. Colporrafia anterior y posterior

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Dos datos mandan en la decisión: es un prolapso de cúpula vaginal, o sea el fondo de la vagina descendió tras haberle quitado el útero años atrás, y es una mujer de 60 años sexualmente activa que quiere conservar una vagina funcional. La reparación que resuelve un prolapso de cúpula severo y a la vez mantiene la profundidad y el eje de la vagina para permitir las relaciones es la fijación del ápice vaginal al promontorio sacro mediante una malla, que es lo que hace la colposacropexia; por eso es la conducta más adecuada aquí. La colpocleisis total es la trampa que hay que evitar: cierra y oblitera el canal vaginal, lo que la vuelve una excelente opción en ancianas sin actividad sexual, pero es inaceptable en una paciente que sí tiene vida sexual, porque le anularía la vagina. La colpoperineoplastia anterior y la colporrafia anterior y posterior corrigen defectos de las paredes vaginales, el cistocele o el rectocele, pero no suspenden el ápice descendido, que es el problema central de un prolapso de cúpula estadio IV; usarlas solas dejaría la cúpula sin fijar y el prolapso recidivaría.

VILLAPEPA ENAM: Prolapso de cúpula vaginal severo en mujer sexualmente activa = colposacropexia, que suspende el ápice al sacro y conserva la vagina funcional. La colpocleisis cierra la vagina y solo sirve en mujeres sin actividad sexual; las colporrafias reparan paredes, no el ápice.

PREGUNTA 27

Varón de 25 años acude a consulta porque hace 1 mes nota aumento del tamaño del testículo derecho sin dolor. No otros síntomas. No antecedentes contributivos. Examen: testículo derecho con masa firme y no transiluminable. Ecografía: masa sólida intratesticular derecha. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- A. Marcadores tumorales y orquiectomía radical inguinal
- B. Realizar una biopsia testicular con aguja fina
- C. Set de Brucella y tratamiento antibiótico
- D. Iniciar tratamiento con antibióticos y reevaluación

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

En un varón joven, una masa testicular firme, indolora, que no transilumina y que la ecografía confirma como sólida e intratesticular es un tumor de células germinales hasta que se demuestre lo contrario; ese es el cáncer sólido más frecuente a esta edad. La conducta tiene dos pasos que van juntos: sacar sangre para los marcadores tumorales, que sirven para el diagnóstico, el pronóstico y el seguimiento posterior, y extirpar el testículo completo por vía inguinal, la orquiectomía radical, que es a la vez el tratamiento y la forma correcta de obtener el tejido para el análisis. La biopsia con aguja del testículo está formalmente proscrita en la sospecha de tumor: puncionar por el escroto abre una vía por donde el tumor puede sembrarse y cambia el drenaje linfático, empeorando el pronóstico; por eso jamás se biopsia, se extirpa entero por la ingle. Pedir serología de Brucella y dar antibióticos, o iniciar antibióticos y reevaluar, es tratar el cuadro como si fuera una orquiepididimitis infecciosa, pero eso daría dolor, fiebre y una masa que sí transilumina o inflamatoria, nada que ver con una masa sólida indolora; perder tiempo en antibióticos retrasa el diagnóstico de un cáncer que es muy curable si se trata pronto.

VILLAPEPA ENAM: Masa testicular sólida, firme, indolora y no transiluminable en varón joven = tumor germinal: marcadores tumorales + orquiectomía radical inguinal. Nunca biopsia transescrotal (siembra tumoral); no perder tiempo con antibióticos.

PREGUNTA 28

Varón de 32 años acude a emergencia tras caída de motocicleta. Se encuentra consciente, orientado, con respiración espontánea. Examen: palidez, diaforesis, llenado capilar > 2 seg., FC 130 x', FR 26 x', PA 70/50 mmHg, diuresis: 15 ml/h. Presenta dolor y defensa en hipocondrio izquierdo. No hay sangrado externo evidente. Se le clasifica como shock hemorrágico clase y se administra

- A. II, soluciones cristaloides isotónicas hasta normalizar presión arterial
- B. I, solución glucosada al 5% en bolo rápido
- C. IV, expansores plasmáticos sintéticos en infusión rápida
- D. III, cristaloides balanceados y transfusión de concentrado de hematíes

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que graduar el shock por lo que muestran los signos. Este paciente ya cruzó el umbral en el que la presión arterial cae: tiene hipotensión franca con 70/50, taquicardia marcada de 130, respiración acelerada y, muy importante, la diuresis desplomada a 15 mililitros por hora, que refleja que el riñón ya no se está perfundiendo. Esa combinación de hipotensión con taquicardia intensa y oliguria corresponde a una pérdida de alrededor del 30 a 40 % de la volemia, que es la clase III. Y el dolor con defensa en hipocondrio izquierdo tras el trauma apunta al bazo como la fuente del sangrado oculto. En la clase III ya no basta con líquidos: se reponen cristaloides balanceados para recuperar volumen pero, como la sangre perdida es significativa, se necesita además transfundir concentrado de hematíes para restaurar la capacidad de transportar oxígeno; por eso esa es la conducta correcta. Clasificarlo como clase II subestima el cuadro, porque en la clase II todavía se mantiene la presión y aquí ya está caída. La clase I es una pérdida mínima sin repercusión, incompatible con este paciente en shock, y además reanimar con glucosa al 5% es un error porque es agua que no se queda en el vaso. La clase IV describe un colapso aún más profundo, casi preterminal, y reanimar solo con expansores sintéticos sin sangre no corrige la pérdida de hematíes que este paciente ya tiene.

VILLAPEPA ENAM: Hipotensión + taquicardia marcada + oliguria (15 mL/h) tras trauma esplénico = shock hemorrágico clase III (pérdida del 30-40% de la volemia). Se maneja con cristaloides balanceados MÁS transfusión de hematíes; los líquidos solos ya no alcanzan.

PREGUNTA 29

Mujer de 85 años, con prolapso uterino estadio IV de larga evolución y sin relaciones sexuales desde hace más de 10 años. Consulta por sangrado genital de inicio reciente. Examen: útero prolapsado fuera de la vulva, con cérvix expuesto que presenta una lesión ulcerada y friable. ¿Cuál es la secuencia diagnóstica y terapéutica más adecuada?

- A. Histerectomía vaginal urgente sin biopsia
- B. Biopsia dirigida de la lesión y colpocleisis si es benigna
- C. Colporrafia anterior con cierre vaginal primario
- D. Uso de estrógenos y pesario hasta nueva evaluación

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El dato de alarma es la lesión: un cérvix con una úlcera friable que sangra no se puede asumir como una simple irritación del prolapso, porque esa descripción es idéntica a la de un cáncer de cuello. La regla es inquebrantable: ante una lesión sospechosa, primero se sabe qué es y luego se decide qué hacer, nunca al revés. Por eso la secuencia correcta empieza por una biopsia dirigida de la lesión para tener el diagnóstico histológico, y solo después, si el resultado confirma que es benigna, se procede a la cirugía del prolapso; y como está paciente tiene 85 años y no tiene actividad sexual desde hace más de una década, la colpocleisis, que cierra la vagina, es una reparación definitiva perfectamente adecuada para ella. Operar de entrada con una histerectomía vaginal urgente sin biopsia es el error grave: si esa lesión fuera un cáncer, una cirugía a ciegas dispersaría el tumor y comprometería el tratamiento oncológico correcto. La colporrafia con cierre primario aborda el prolapso, pero ignora por completo la lesión sangrante que hay que estudiar antes. Dar estrógenos y colocar un pesario trata el prolapso como si el sangrado fuera solo por atrofia, sin descartar la malignidad, y además meter un pesario sobre una lesión ulcerada y friable la irritaría aún más.

VILLAPEPA ENAM: Prolapso con lesión cervical ulcerada y friable que sangra = biopsiar primero para descartar cáncer, y recién después reparar (colpocleisis, adecuada en anciana sin actividad sexual). Operar sin biopsia una lesión sospechosa es el error a evitar.

PREGUNTA 30

Varón de 40 años, inicia hace pocas horas desviación dolorosa e involuntaria del cuello hacia un lado, con limitación marcada del movimiento cervical. Tres días antes empezó tratamiento con haloperidol por alucinaciones auditivas y delirio persecutorio. Examen: afebril, consciente y sin compromiso de la vía aérea con desviación dolorosa e involuntaria del cuello y de los ojos hacia arriba, dificultad para hablar por protrusión de la lengua y gran ansiedad. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera elección para este cuadro?

- A. Clonazepam
- B. Levodopa
- C. Orfenadrina
- D. Biperideno

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El cuadro es inconfundible una vez que unes el fármaco con los signos. Empezó haloperidol hace tres días, un neuroléptico potente, y ahora tiene el cuello torcido de forma dolorosa e involuntaria, los ojos desviados hacia

arriba y la lengua protruyendo con dificultad para hablar. Esa tríada de tortícolis, crisis oculógira y afectación de la lengua es una distonía aguda, una reacción extrapiramidal precoz que aparece porque el bloqueo brusco de la dopamina deja al sistema colinérgico del cerebro sin contrapeso, y ese exceso relativo de acetilcolina desencadena las contracciones distónicas. La lógica del tratamiento se cae por su propio peso: si el problema es un predominio colinérgico, la solución es un anticolinérgico que restablezca el equilibrio, y el de elección para esto es el biperideno, que corta la distonía en minutos. La levodopa hace lo contrario de lo necesario en salud mental: aporta más dopamina y en un paciente psicótico puede reactivar las alucinaciones y el delirio, así que no se usa aquí. El clonazepam es una benzodiacepina que puede servir como coadyuvante para la ansiedad o en distonías refractarias, pero no es el tratamiento de primera línea porque no corrige el desequilibrio dopamina-acetilcolina que causa el cuadro. La orfenadrina también tiene acción anticolinérgica, pero el fármaco de primera elección disponible y estandarizado para la distonía aguda por neurolepticos es el biperideno.

VILLAPEPA ENAM: Tortícolis + crisis oculógira + protrusión lingual poco después de iniciar haloperidol = distonía aguda por bloqueo dopaminérgico con predominio colinérgico. Se trata con un anticolinérgico, el biperideno, de primera elección; la levodopa reactivaría la psicosis.

PREGUNTA 31

Varón de 38 años con SIDA (CD4: 120 células/mm³) y tuberculosis pulmonar bacilífera inicia tratamiento combinado anti SIDA y anti TB. A los dos meses mantiene carga viral elevada y recuento de CD4 bajo, pese a buena adherencia. ¿Cuál es la intervención más adecuada para optimizar el control del VIH?

- A. Suspender la rifampicina y reemplazarla por etambutol en dosis altas, manteniendo esquema antirretroviral
- B. Retrasar el tratamiento antirretroviral hasta completar la fase intensiva del tratamiento antituberculoso
- C. Reconocer la inducción enzimática por rifampicina y cambiar el esquema antirretroviral a uno compatible
- D. Indicar profilaxis primaria a los contactos y mantener ambos esquemas sin cambios

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El punto que resuelve el caso es una interacción farmacológica. La rifampicina, pilar del tratamiento antituberculoso, es uno de los inductores enzimáticos hepáticos más potentes que existen: acelera el metabolismo de muchos antirretrovirales y les baja las concentraciones en sangre por debajo del nivel eficaz. Por eso este paciente, aunque toma todo bien, mantiene la carga viral alta y los CD4 bajos: no es falta de adherencia, es que la rifampicina le está desactivando el antirretroviral. La intervención correcta es reconocer esa inducción y cambiar el esquema antirretroviral por uno que sea compatible con la rifampicina, ajustando fármaco o dosis para que alcance niveles útiles pese a la inducción. Suspender la rifampicina y reemplazarla por etambutol debilitaría el tratamiento de una tuberculosis bacilífera, que es contagiosa y potencialmente mortal, para acomodar el antirretroviral, cuando el problema se arregla ajustando este último. Retrasar el antirretroviral en un paciente con CD4 tan bajos es peligroso, porque en inmunosupresión avanzada la tardanza aumenta el riesgo de infecciones oportunistas y muerte; en un paciente ya en tratamiento no se justifica suspenderlo ni retrasarlo. Dar profilaxis a los contactos y no cambiar nada ignora la causa real del fracaso virológico y deja al paciente sin control del VIH.

VILLAPEPA ENAM: Fracaso virológico con buena adherencia en un coinfectado que recibe rifampicina = la rifampicina, inductor enzimático potente, baja los niveles del antirretroviral. La solución es ajustar el esquema antirretroviral a uno compatible, no retirar la rifampicina ni retrasar el tratamiento del VIH.

PREGUNTA 32

En un hospital, el comité de gestión de riesgos revisa trimestralmente indicadores de su programa de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos. ¿Cuál es el principal aporte de este monitoreo periódico a la reducción de incidentes y a la eficiencia operativa?

- A. Se enfoca en los costos de reparación de equipos para incorporar en el presupuesto
- B. Registra eventos adversos graves sin modificar la programación de mantenimiento
- C. Eliminar por completo los riesgos asociados a los equipos biomédicos
- D. Previene fallas recurrentes, disminuye tiempos de inactividad y evita interrupciones de la atención

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El sentido del mantenimiento preventivo, y de monitorear sus indicadores cada trimestre, es anticiparse a la falla en lugar de esperar a que el equipo se rompa. Revisar de forma periódica permite detectar patrones, corregir a tiempo y programar las intervenciones antes de que un equipo se caiga en plena atención. Ese enfoque proactivo es el que genera el triple beneficio que describe la respuesta: evita que las mismas fallas se repitan, reduce el tiempo en que los equipos están fuera de servicio y, sobre todo, impide que la atención al paciente se interrumpa por un aparato averiado. Enfocarse solo en los costos de reparación mira el gasto una vez que el daño ya ocurrió, que es justo lo contrario de prevenir. Registrar eventos adversos sin cambiar la programación de mantenimiento sería recoger datos sin usarlos, un monitoreo estéril que no mejora nada. Y prometer eliminar por completo los riesgos es un absoluto que ningún programa puede cumplir: el mantenimiento reduce y controla el riesgo, pero no lo lleva a cero, porque siempre queda margen de fallo imprevisto; las respuestas con palabras como por completo o totalmente casi siempre son trampas.

VILLAPEPA ENAM: El monitoreo del mantenimiento preventivo previene fallas recurrentes, reduce inactividad de equipos y evita interrupciones de la atención. Prometer eliminar por completo el riesgo es un absoluto falso: se reduce y controla, nunca se lleva a cero.

PREGUNTA 33

Lactante de 2 meses, nacida de parto vaginal, la madre presentó leucorrea en el III trimestre. Desde hace 6 días presenta tos esporádica, que se exacerba progresivamente; los últimos 2 días tiene cansancio para respirar. Niega rinorrea, estornudos o fiebre. Examen: FR: 70 x', FC: 120 x', SO 92% con oxígeno ambiental, despierta, con retracciones intercostales y subcostales. A la auscultación pulmonar: crépitos y subcrépitos en bases pulmonares. ¿Cuál es el medicamento de elección?

- A. Ribavirina inhalatoria
- B. Ampicilina IV
- C. Gentamicina IM
- D. Azitromicina VO

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Fíjate en el conjunto: una lactante de dos meses cuya madre tuvo flujo vaginal en el último trimestre, que hace una neumonía de instalación lenta, con tos que empeora de a poco y dificultad respiratoria, pero sin fiebre y sin cuadro catarral previo. Esa neumonía afebril del lactante pequeño, con antecedente de infección genital materna transmitida durante el parto vaginal, es el retrato de la infección por *Chlamydia trachomatis* adquirida al pasar por el canal. Como el germen es una bacteria intracelular, el fármaco que la alcanza es un macrólido, y el de elección para esta neumonía es la azitromicina. La ribavirina inhalada es un antiviral de uso muy restringido para bronquiolitis grave por virus sincitial, y aquí el patrón afebril con antecedente materno apunta a

chlamydia, no a un virus. La ampicilina cubre bacterias típicas de la neumonía febril del lactante, pero no penetra en las bacterias intracelulares como la chlamydia, así que no resolvería este cuadro. La gentamicina es un aminoglucósido para gramnegativos que tampoco actúa sobre chlamydia y añade toxicidad innecesaria; el blanco es intracelular y solo el macrólido llega ahí.

VILLAPEPA ENAM: Lactante pequeño + neumonía afebril de instalación progresiva + madre con infección genital en el embarazo = neumonía por Chlamydia trachomatis adquirida en el parto. El tratamiento es un macrólido, la azitromicina; los betalactámicos y aminoglucósidos no alcanzan la bacteria

PREGUNTA 34

Mujer de 55 años con prolapso hemorroidal que requiere reducción manual, sangrado ocasional y molestias persistentes que no responden al tratamiento higiénico-dietético. ¿Cuál es el tratamiento mínimamente invasivo?

- A. Esfinteromía lateral interna
- B. Escleroterapia con polidocanol
- C. Hemorroidectomía cerrada
- D. Ligadura con banda elástica

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El dato que gradúa la hemorroide es que el prolapso necesita reducción manual: eso la ubica en un grado avanzado, el que se sale con el esfuerzo y no vuelve solo, hay que empujarlo de regreso. Y como ya fracasó el manejo higiénico-dietético pero se pide una opción mínimamente invasiva, la técnica indicada es la ligadura con banda elástica: se coloca una banda en la base del paquete hemorroidal que corta su irrigación, el tejido se necrosa y se desprende en unos días, todo sin cirugía formal ni anestesia mayor. Es el procedimiento de consultorio de elección para este grado. La escleroterapia con un agente esclerosante sirve para hemorroides de grados más tempranos, las que sangran pero apenas prolapsan; en un prolapso que exige reducción manual se queda corta. La hemorroidectomía cerrada sí resuelve el problema, pero es cirugía en quirófano con anestesia, es decir el extremo opuesto a mínimamente invasivo, y se reserva para los grados más severos o los que fallan a las técnicas de consultorio. La esfinterotomía lateral interna ni siquiera trata hemorroides: es la operación de la fisura anal, corta parte del esfínter para relajarlo, así que no viene al caso.

VILLAPEPA ENAM: Hemorroide que prolapsa y requiere reducción manual (grado avanzado) sin respuesta a medidas higiénico-dietéticas, buscando lo mínimamente invasivo = ligadura con banda elástica. La escleroterapia es para grados tempranos y la hemorroidectomía es cirugía formal, no mínimamente invasiva.

PREGUNTA 35

Mujer de 30 años que, después de esfuerzo, presenta en región perianal dolor continuo e intenso con sensación de bulto que imposibilita sentarse. Examen: nódulo violáceo, tenso y doloroso en margen anal. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A. Fisura anal
- B. Absceso perianal
- C. Trombosis hemorroidal
- D. Fistula perianal

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La imagen clínica es muy característica: tras un esfuerzo aparece de golpe un nódulo en el borde del ano, tenso, de color violáceo y muy doloroso, que impide hasta sentarse. Ese color violáceo es la firma de un coágulo dentro de una vena hemorroidal externa, es decir una hemorroide externa trombosada. El esfuerzo aumentó la presión venosa, la sangre se estancó y coaguló, y ese trombo bajo la piel perianal es lo que se palpa como el bulto duro y azulado que duele tanto. La fisura anal produce un dolor intenso pero de tipo cortante que aparece con la defecación y deja una úlcera lineal en el canal, no un nódulo violáceo. El absceso perianal daría una tumoración pero caliente, roja, fluctuante y habitualmente con fiebre, porque es una colección de pus, mientras que aquí el nódulo es violáceo y tenso por sangre coagulada, no por infección. La fistula perianal se manifiesta como un orificio que drena secreción de forma crónica, no como un bulto agudo, tenso y doloroso de aparición súbita tras el esfuerzo.

VILLAPEPA ENAM: Nódulo perianal violáceo, tenso y muy doloroso de aparición súbita tras esfuerzo = trombosis hemorroidal externa (coágulo en vena hemorroidal). El color violáceo la distingue del absceso (rojo, caliente, fluctuante) y de la fisura (dolor cortante con úlcera lineal).

PREGUNTA 36

Varón de 30 años, diabético tipo 1, es traído inconsciente a emergencia. Sus familiares refieren que dejó de usar insulina desde hace una semana. Examen: PA 110/70 mmHg, FC 70 x', FR 28 x'. AGA: pH 6.81, PaCO_2 9.3 mmHg, HCO_3^- 6.5 mmol/L, anión gap 29.7 mmol/L. Lab: glucosa 894 mg/dL, Na^+ 137 mmol/L, K^+ 2.7 mmol/L, Cl^- 107 mmol/L, lactato 12.8 mmol/L. Se ha asegurado vía aérea permeable, respiración y circulación, y se ha iniciado reposición con solución salina isotónica. Antes de comenzar la infusión de insulina intravenosa. ¿Qué alteración debe corregirse en primer lugar?

- A. Hipopotasemia
- B. Acidosis metabólica
- C. Hiponatremia
- D. Hiperglicemia

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Este es un cetoacidótico severo, pero el peligro inmediato no es el que salta a la vista. La glucosa está altísima y la acidosis es profunda, sí, pero el dato que cambia el orden de las cosas es el potasio de 2,7, que es una hipopotasemia grave. Y acá está la lógica fina: la insulina, además de bajar el azúcar, empuja el potasio hacia adentro de las células. Si tú inicias la insulina con un potasio ya en 2,7, ese potasio va a desplomarse todavía más y puede desencadenar una arritmia cardíaca fatal o una parálisis respiratoria. Por eso la regla es clara: antes de tocar la insulina hay que reponer potasio hasta llevarlo a un nivel seguro. Primero se corrige la hipopotasemia, y recién entonces entra la insulina. La acidosis metabólica es intensa, pero se corrige sola en gran parte al reponer volumen y al frenar la producción de cetonas con la propia insulina; no se ataca de entrada con bicarbonato salvo casos extremos, y no es lo primero que amenaza la vida en este orden. La hiperglicemia es la que uno querría bajar, pero justamente la herramienta para bajarla, la insulina, es la que no se puede dar hasta corregir el potasio, así que no puede ir primero. Y el sodio de 137 es normal, no hay hiponatremia real que corregir.

VILLAPEPA ENAM: En cetoacidosis con potasio bajo (2,7), primero se repone el potasio y recién después se inicia la insulina. La insulina mete potasio a la célula y un potasio ya bajo se desplomaría a nivel de arritmia fatal; con K menor de 3,3 no se inicia insulina sin corregirlo antes.

PREGUNTA 37

Un lactante de 4 meses es llevado a su control de CRED, en donde le realizan su tamizaje de hemoglobina para descartar anemia. Esta actividad corresponde a una acción de:

- A. Promoción
- B. Rehabilitación
- C. Recuperativa
- D. Prevención

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La clave es entender qué se está haciendo con ese tamizaje: buscar la anemia en un niño que todavía no tiene síntomas, para detectarla temprano y actuar antes de que haga daño. Detectar precozmente una enfermedad en fase temprana, mediante una prueba de cribado, es una acción de prevención, concretamente del nivel que se anticipa a las complicaciones identificando el problema apenas empieza. Por eso el tamizaje de hemoglobina es prevención. La promoción de la salud es distinta: apunta a fomentar hábitos y entornos saludables en toda la población sana, como enseñar alimentación adecuada, no a buscar una enfermedad concreta en un individuo con una prueba. La rehabilitación actúa cuando el daño ya se instaló y hay que recuperar función perdida, que no es el caso de un niño al que recién se le hace el descarte. Lo recuperativo o asistencial es tratar la enfermedad ya establecida, y aquí no se está tratando una anemia diagnosticada, se la está buscando; ese acto de búsqueda anticipada es prevención, no recuperación.

VILLAPEPA ENAM: El tamizaje busca la enfermedad antes de que dé síntomas = acción de prevención (detección precoz). La promoción fomenta hábitos saludables en la población sana; lo recuperativo trata la enfermedad ya establecida; la rehabilitación recupera función perdida.

PREGUNTA 38

Un niño de 3 años presenta estatus convulsivo generalizado que requiere manejo en UCI pediátrica. Luego de su estabilización, se discute los posibles desenlaces neurológicos a mediano plazo. ¿Cuál es el factor que tiene mayor peso para determinar el pronóstico neurológico?

- A. Tipo específico de anticonvulsivo utilizado
- B. Etiología subyacente del estatus convulsivo
- C. Duración del tratamiento hospitalario
- D. Edad del niño al momento del episodio

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Para pronosticar cómo quedará el cerebro de este niño, lo que más pesa no es cómo se trató la convulsión sino qué la causó. La causa de fondo del estatus es el determinante principal del desenlace neurológico: no es lo mismo un estatus desencadenado por una fiebre en un niño previamente sano, que tiene buen pronóstico, que uno provocado por una meningoencefalitis, una lesión cerebral aguda o un trastorno metabólico grave, donde el daño lo produce la enfermedad de base y el pronóstico es mucho peor. Por eso la etiología subyacente manda sobre todo lo demás. El tipo específico de anticonvulsivo utilizado importa para cortar la crisis rápido, pero no define el destino neurológico: dos fármacos distintos que detienen el estatus dejan un pronóstico marcado por la causa, no por cuál se eligió. La duración del tratamiento hospitalario es una consecuencia de la gravedad, no una causa del pronóstico; refleja cuán enfermo estaba, pero no es el factor que lo determina. La

edad puede modular en algo la vulnerabilidad del cerebro, pero frente a una etiología grave, es esta la que impone el resultado, muy por encima de la edad.

VILLAPEPA ENAM: Lo que más determina el pronóstico neurológico tras un estatus convulsivo es la etiología subyacente. Una crisis por fiebre en niño sano evoluciona bien; una por lesión cerebral aguda o infección deja secuelas por la enfermedad de base, no por el fármaco elegido.

PREGUNTA 39

Varón de 55 años, con fibrilación auricular no anticoagulado, presenta hace 10 horas en forma súbita dificultad para ver el lado derecho de su campo visual. Al examen neurológico se evidencia hemianopsia homónima derecha, dificultad para orientarse en el espacio del hemicampo derecho y dificultad para reconocer caras familiares, sin otros déficits motores ni sensitivos. ¿Cuál es el territorio vascular más probable?

- A. Corteza parietal posterior
- B. Corteza parietal
- C. Talámico y occipital profundo
- D. Cortical occípito temporal

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que traducir los síntomas a mapa cerebral. Una fibrilación auricular sin anticoagular lanzó un émbolo, y los déficits dicen dónde impactó. La hemianopsia homónima derecha señala daño de la vía visual detrás del quiasma, en la corteza occipital del lado izquierdo, donde se procesa el campo visual derecho. A eso se suma que no reconoce caras familiares, una prosopagnosia, que localiza el problema en la corteza occípito-temporal, la zona donde el cerebro identifica rostros. Y lo que no tiene es tan revelador como lo que tiene: no hay ninguna debilidad ni pérdida de sensibilidad, es decir la corteza motora y la sensitiva están intactas. Ese patrón de déficit puramente visual y de reconocimiento, sin compromiso motor ni sensitivo, dibuja una lesión cortical occípito-temporal, el territorio irrigado por la arteria cerebral posterior en su porción cortical. La corteza parietal posterior y la parietal en general producirían más bien negligencia espacial junto con alteraciones sensitivas o de la orientación corporal, y no explican la prosopagnosia, que es un fenómeno occípito-temporal. La opción talámica y occipital profunda añade el tálamo, pero un infarto talámico daría hemianestesia o dolor talámico, síntomas sensitivos que este paciente no tiene; su cuadro es cortical puro, sin sello talámico.

VILLAPEPA ENAM: Hemianopsia homónima + prosopagnosia (no reconoce caras) sin déficit motor ni sensitivo = lesión cortical occípito-temporal, territorio de la arteria cerebral posterior. El tálamo daría síntomas sensitivos (hemianestesia, dolor talámico) que aquí no existen.

PREGUNTA 40

Mujer de 70 años, hospitalizada desde hace 7 días por insuficiencia cardíaca descompensada, presenta en las últimas 24 horas somnolencia, desorientación, fiebre de 38,5 °C y tos con esputo purulento. Examen: crépitos en la base del hemitórax izquierdo. No tiene antecedentes de EPOC ni enfermedad hepática crónica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Neumonía adquirida en la comunidad
- B. Neumonía intrahospitalaria
- C. Neumonía atípica

D. Tromboembolismo pulmonar

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El dato que define la categoría es el tiempo: esta paciente lleva siete días internada y la neumonía apareció recién en las últimas veinticuatro horas, es decir mucho después de las cuarenta y ocho horas de ingreso. Una neumonía que se instala tras ese lapso dentro del hospital, con fiebre, tos purulenta y crépitos nuevos, se clasifica como neumonía intrahospitalaria o nosocomial, y esa distinción no es un tecnicismo: cambia por completo qué gérmenes se sospechan, más resistentes, y qué antibiótico se elige. Llamarla neumonía adquirida en la comunidad sería incorrecto porque no la trajo de la calle, se le desarrolló estando internada; el origen hospitalario es justamente lo que la diferencia. La neumonía atípica describe un patrón clínico y radiológico particular, con síntomas más larvados y gérmenes intracelulares, que no encaja con este cuadro agudo de esputo purulento y consolidación basal en una paciente hospitalizada. El tromboembolismo pulmonar puede complicar a un encamado y hay que tenerlo en mente, pero cursa típicamente con disnea súbita e hipoxemia sin esputo purulento ni fiebre alta con crépitos localizados, mientras que aquí el conjunto de fiebre, tos con pus y foco auscultatorio apunta claramente a una infección del parénquima adquirida en el hospital.

VILLAPEPA ENAM: Neumonía que aparece después de 48 horas de hospitalización (aquí al 7º día) = neumonía intrahospitalaria, no comunitaria. El momento de aparición define la categoría y cambia los gérmenes sospechados y el antibiótico hacia cobertura de resistentes.

PREGUNTA 41

Mujer de 34 años de edad, que tiene un hijo de 6 años producto de un parto eutócico a las 38 semanas. Además, presentó una evacuación molar hace 2 años. Actualmente tiene una gestación de 36 semanas, que culmina mediante cesárea de emergencia por presentar cuadro de eclampsia obteniéndose un recién nacido vivo. ¿Cuál es la fórmula obstétrica de la paciente?

A. G3 P2012

B. G3 P1112

C. G2 P1112

D. G2 P2012

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que contar con cuidado cada casilla. Las gestaciones son todas las veces que estuvo embarazada, sin importar cómo terminaron: el hijo de hace seis años, la mola de hace dos años y el embarazo actual suman tres, así que es G3. La paridad se desglosa en cuatro números que van en orden: partos a término, partos pretérmino, abortos y número de hijos vivos. A término, es decir a partir de las 37 semanas, tuvo uno solo, el parto eutócico a las 38 semanas, así que el primer número es 1. Pretérmino, o sea antes de las 37 semanas, tiene la cesárea actual a las 36 semanas, que cuenta como uno, y ese es el segundo número. La mola es un embarazo que no llegó a feto viable, así que se cuenta como aborto, y ese es el tercer número, un 1. Los hijos vivos son dos: el niño de seis años y el recién nacido que se acaba de obtener vivo, así que el cuarto número es 2. Todo junto da G3 P1112. Confundirlo con G2 sería olvidar que la mola también fue una gestación. Poner un 2 en los partos a término desconocería que las 36 semanas son pretérmino, no término. Y las variantes que no reflejan la mola como aborto o que no cuadran los vivos en dos se descartan al hacer el conteo casilla por casilla.

VILLAPEPA ENAM: Gestaciones = todos los embarazos, incluida la mola = 3. Paridad (a término, pretérmino,

abortos, vivos): parto de 38 sem (1 término), cesárea de 36 sem (1 pretérmino), mola (1 aborto), dos hijos vivos = P1112. Resultado: G3 P1112. 36 semanas es pretérmino, no término.

PREGUNTA 42

Mujer de 35 años, previamente sana, presenta desde hace 4 meses dolor e inflamación en articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, muñecas, tobillos y metatarsfalángicas, de forma simétrica, con rigidez matutina mayor de 2 horas. Examen: sinovitis en las articulaciones mencionadas. ¿Qué examen de anticuerpos es el más útil para confirmar el diagnóstico?

- A. Anti-topoisomerasa I (anti-Scl-70)
- B. Anti-U1 ribonucleoproteína (anti-U1-RNP)
- C. Antinucleares (ANA) por inmunofluorescencia indirecta
- D. Anti-péptidos citrulinados cíclicos (anti-CCP)

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El cuadro clínico es de artritis reumatoide de manual: poliartritis simétrica de las pequeñas articulaciones de las manos, con compromiso de metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, sumado a muñecas y articulaciones de los pies, más una rigidez matutina que dura más de dos horas, que es el sello del componente inflamatorio. Para confirmar esa sospecha, el anticuerpo más útil es el anti-péptido citrulinado cíclico, porque es el más específico para la enfermedad: cuando sale positivo, la probabilidad de que sea artritis reumatoide es muy alta, y además marca a los pacientes con enfermedad más erosiva y agresiva. Los anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia son muy sensibles, pero poco específicos: salen positivos en muchísimas enfermedades autoinmunes y hasta en personas sanas, así que sirven para tamizar lupus, no para confirmar artritis reumatoide. El anti-Scl-70 es el anticuerpo de la esclerodermia, ligado a la afectación cutánea y pulmonar de esa enfermedad, no a esta poliartritis. El anti-U1-RNP es característico de la enfermedad mixta del tejido conectivo, un cuadro distinto que combina rasgos de varias collagenopatías; no es el que confirma la artritis reumatoide.

VILLAPEPA ENAM: Poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones con rigidez matutina mayor de 2 horas = artritis reumatoide, que se confirma con el anti-CCP por su alta especificidad. Los ANA son sensibles pero inespecíficos (tamizan lupus); anti-Scl-70 es de esclerodermia y anti-U1-RNP de enfermedad mixta del tejido conectivo.

PREGUNTA 43

Varón de 72 años con fibrosis pulmonar idiopática en oxigenoterapia domiciliar a 2 L/min por cánula nasal, en las últimas semanas ha requerido aumentar el flujo a 4 L/min por empeoramiento de la disnea, no fiebre ni síntomas de infección. Examen: crepitantes bibasales y SO 88% con 4 L/min. AGA: pH 7.43, PaCO₂ 38 mmHg, PaO₂ 50 mmHg, HCO₃⁻ 28 mEq/L. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria presenta actualmente y cuál es el estudio más adecuado para evaluar la extensión y progresión de la fibrosis pulmonar?

- A. I; prueba de caminata de 6 minutos
- B. II; ecocardiograma transtorácico
- C. I; TC de tórax de alta resolución
- D. II; espirometría

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que resolver dos cosas. Primero, clasificar la insuficiencia respiratoria mirando la gasometría: la oxigenación está claramente baja, con una presión de oxígeno de 50, mientras que el dióxido de carbono está normal, en 38. Cuando falla el oxígeno pero el dióxido de carbono no se retiene, se trata de una insuficiencia respiratoria tipo uno, la puramente hipoxémica, que es justo lo que produce la fibrosis: el pulmón engrosado no deja pasar el oxígeno a la sangre, pero el dióxido de carbono, que difunde mucho mejor, todavía se elimina bien. Segundo, elegir el estudio para ver cuánta fibrosis hay y cómo progresa: la herramienta que muestra el patrón, la extensión y los cambios estructurales del pulmón fibrótico es la tomografía de tórax de alta resolución, que retrata en detalle el panal de abejas y las zonas afectadas. Por eso la respuesta es tipo uno con esa tomografía. La prueba de caminata de seis minutos mide la capacidad funcional y la desaturación con el esfuerzo, útil para seguir la tolerancia, pero no dibuja la extensión anatómica de la fibrosis. El ecocardiograma evalúa el corazón y la presión pulmonar, una complicación de la fibrosis, no la fibrosis en sí. La espirometría cuantifica el patrón restrictivo con números de volumen, pero tampoco muestra la extensión estructural que sí revela la tomografía; y además ambas opciones que hablan de tipo dos son incorrectas porque no hay retención de dióxido de carbono.

VILLAPEPA ENAM: Hipoxemia (PaO_2 50) con dióxido de carbono normal = insuficiencia respiratoria tipo I (hipoxémica pura), típica de la fibrosis por bloqueo de la difusión. La extensión y progresión de la fibrosis se evalúa con TC de tórax de alta resolución; no hay tipo II porque no retiene CO_2 .

PREGUNTA 44

Varón de 23 años, hace 3 horas se golpeó el lado derecho de la cabeza contra una roca y perdió el conocimiento durante aproximadamente 2 minutos. Una hora después, comenzó a quejarse de cefalea intensa y progresiva, náuseas y vómitos. Durante el traslado en la ambulancia, el paciente presenta un deterioro marcado del estado de alerta, llegando a urgencias en estupor profundo. Examen: anisocoria con la pupila derecha de 5 mm, no reactiva a la luz y hemiparesia izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Hemorragia intracerebral
- B. Hematoma subdural
- C. Hematoma epidural
- D. Hemorragia subaracnoidea

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La secuencia temporal es la firma del cuadro. Hubo un golpe en la región lateral de la cabeza con pérdida breve de conciencia, luego el paciente estuvo relativamente bien durante una hora, el llamado intervalo lúcido, y después se deterioró de forma rápida y progresiva hasta el estupor. Ese patrón de golpe, mejoría transitoria y deterioro acelerado es el clásico del hematoma epidural, que se produce cuando el traumatismo temporal rompe la arteria meníngea media y la sangre arterial, a alta presión, se acumula veloz entre el cráneo y la duramadre. A medida que ese hematoma crece, empuja el cerebro y hernia el lóbulo temporal, que comprime el tercer par craneal del mismo lado: por eso aparece la pupila derecha dilatada y sin respuesta a la luz. Y la compresión del tronco y de la vía motora provoca la debilidad del lado contrario, la hemiparesia izquierda. El hematoma subdural, en cambio, suele ser venoso y de evolución más lenta o insidiosa, sin ese intervalo lúcido tan neto ni un deterioro tan explosivo en horas. La hemorragia intracerebral daría déficit desde el inicio según la zona sangrante, sin la fase de mejoría intermedia. La hemorragia subaracnoidea se presenta como una cefalea súbita

en trueno, a menudo espontánea por aneurisma, no con este intervalo lúcido tras un golpe seguido de anisocoria y hemiparesia.

VILLAPEPA ENAM: Traumatismo temporal + pérdida de conciencia + intervalo lúcido + deterioro rápido con pupila dilatada del lado del golpe y hemiparesia contralateral = hematoma epidural por rotura de la arteria menígea media. El subdural es venoso, más lento y sin intervalo lúcido tan neto.

PREGUNTA 45

Mujer de 25 años, acude por dolor súbito e intenso en fosa iliaca izquierda de 4 horas de evolución, que no se irradia y empeora con la movilización. Refiere FUR hace 7 días, con ciclo menstrual regular de 28 días. Examen: abdomen blando, dolor selectivo en fosa iliaca izquierda sin defensa ni rebote. Tacto vaginal: útero de 7 cm, masa anexial izquierda con dolor marcado a la palpación, sin sangrado activo por cérvix. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Embarazo ectópico tubárico
- B. Quiste a pedículo torcido
- C. Cuerpo lúteo hemorrágico
- D. Aborto incompleto

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Dos datos ordenan el diagnóstico: el momento del ciclo y el carácter del dolor. La última menstruación fue hace apenas siete días en una mujer con ciclos regulares de veintiocho, así que está en la primera mitad del ciclo y menstruó normal hace poco, lo que hace muy improbable un embarazo. A eso se suma un dolor de aparición súbita, muy intenso, localizado en una fosa iliaca, que empeora con el movimiento y se acompaña de una masa anexial exquisitamente dolorosa a la palpación. Ese conjunto, dolor brusco que aumenta con la movilización más masa anexial dolorosa, es el retrato de una torsión anexial, es decir un quiste que giró sobre su pedículo y estranguló su propia irrigación; por eso duele tanto y de golpe. El embarazo ectópico se descarta porque tuvo una menstruación normal hace una semana y no hay signos de gestación ni sangrado; sería forzar el diagnóstico. El cuerpo lúteo hemorrágico ocurre en la segunda mitad del ciclo, después de la ovulación, cuando ya se formó el cuerpo lúteo, y a día siete todavía no existe esa estructura, así que el momento del ciclo no cuadra. El aborto incompleto exige un embarazo previo con expulsión parcial y sangrado con cuello abierto, nada de lo cual está presente en una mujer que no está embarazada.

VILLAPEPA ENAM: Dolor pélvico súbito e intenso que empeora con la movilización + masa anexial muy dolorosa, en fase folicular temprana (menstruó hace 7 días) = torsión anexial. El cuerpo lúteo aparece recién en la segunda mitad del ciclo, y sin embarazo se descartan ectópico y aborto.

PREGUNTA 46

Mujer de 42 años, G3 P3003, consulta por presentar menstruaciones abundantes, usa 6 toallas al día durante 8 días. Refiere además dismenorrea progresiva en los últimos años. Antecedente: 3 cesáreas. Examen: Útero 12 cm, bordes regulares, globuloso y de consistencia blanda, sin masas anexiales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Leiomiomatosis uterina
- B. Pólipo endometrial
- C. Adenomiosis

D. Cáncer de endometrio

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Las características del útero deciden el diagnóstico. En una multipara de mediana edad aparece un útero aumentado de tamaño de forma uniforme, globuloso, de bordes regulares y consistencia blanda, acompañado de dos síntomas que van de la mano: sangrado menstrual muy abundante y prolongado, y una dismenorrea que ha ido empeorando con los años. Ese cuadro, útero grande pero simétrico y blando, con menorragia y dismenorrea progresiva, es el de la adenomiosis, donde el tejido del endometrio invade el músculo de la pared uterina y engruesa el útero de manera difusa, sin formar tumores localizados. La leiomiomatosis, en cambio, agranda el útero de forma irregular y nodular, con bordes que se palpan abollonados por los miomas, y una consistencia más firme, no un útero blando y liso. El pólipo endometrial puede dar sangrado anómalo, pero es una lesión pequeña dentro de la cavidad que no agranda de forma global el útero ni lo vuelve blando y globuloso. El cáncer de endometrio se plantearía sobre todo por sangrado en la posmenopausia o con factores de riesgo, y no explica el útero blando y agrandado de manera simétrica con dismenorrea progresiva; el patrón de este caso apunta a la invasión difusa de la adenomiosis.

VILLAPEPA ENAM: Útero agrandado de forma uniforme, globuloso, blando y de bordes regulares + menorragia + dismenorrea progresiva en multipara = adenomiosis (endometrio que invade el miometrio de forma difusa). Los miomas dan útero irregular, nodular y firme, no blando y simétrico.

PREGUNTA 47

Agricultor de 70 años, hipertenso con obesidad mórbida, viajó 12 horas en bus y durante el viaje presentó disnea súbita, dolor torácico y síncope. Llega a la emergencia de un hospital nivel II con PA 80/50 mmHg, FC 125 x', FR 30 x' y SO 82% al aire ambiente. EKG muestra taquicardia sinusal y desviación del eje a la derecha. Ecografía muestra ventrículo derecho dilatado e hipertensión pulmonar moderada. No hay signos de sangrado activo ni antecedentes de hemorragia intracraneal. Se sospecha tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál es la conducta más adecuada de acuerdo con las recomendaciones actuales?

- A. Anticoagulación con heparina IV y derivar de inmediato al paciente a un centro para embolectomía quirúrgica, sin considerar trombolisis local
- B. Trombolisis sistémica si no se logró controlar la PA con fluido y/o vasopresor, seguido de anticoagulación y traslado a centro de mayor complejidad
- C. Soporte con oxígeno y líquidos intravenosos, derivando primero al paciente para confirmar diagnóstico por angiotomografía en un centro de referencia
- D. Esperar la disponibilidad de un estudio de imagen confirmatorio (angiotomografía) gestionado por el hospital con un tercero antes de cualquier tratamiento específico

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Lo que convierte este embolismo pulmonar en una emergencia que no espera es la inestabilidad: hay hipotensión franca, taquicardia, hipoxemia severa y, en los estudios, un ventrículo derecho dilatado que está claudicando por la sobrecarga. Eso es un tromboembolismo de alto riesgo, y en ese escenario el coágulo hay que disolverlo ya. Como el paciente además no tiene contraindicaciones para trombólisis, no sangra ni tiene antecedente de hemorragia cerebral, la conducta correcta es dar trombólisis sistémica cuando la presión no se recupera con líquidos y vasopresores, y recién después continuar con anticoagulación y trasladar a un centro de mayor complejidad. La trombólisis es el tratamiento que salva la vida en el embolismo con shock, y se administra donde está el paciente, sin diferirla. Anticoagular con heparina y mandarlo a embolectomía quirúrgica

descartando de plano la trombólisis desconoce que la trombólisis, no la cirugía, es la primera línea en el paciente inestable sin contraindicaciones; la embolectomía se reserva para cuando la trombólisis falla o está contraindicada. Dar solo oxígeno y líquidos y derivarlo para confirmar el diagnóstico con angiotomografía pone la imagen por delante de la vida: en un paciente en shock con embolismo evidente por la clínica y la ecografía, esperar la tomografía retrasa el tratamiento que lo salva. Y aguardar el estudio confirmatorio antes de cualquier tratamiento es directamente peligroso, porque el paciente puede morir mientras se gestiona la imagen.

VILLAPEPA ENAM: Tromboembolismo pulmonar con shock (hipotensión + ventrículo derecho dilatado) y sin contraindicaciones = trombólisis sistémica de inmediato si no responde a fluidos y vasopresor, luego anticoagulación y traslado. En el paciente inestable no se demora el tratamiento esperando la angiotomografía.

PREGUNTA 48

Mujer de 34 años, desde hace 3 semanas presenta palpitaciones, pérdida de peso e irritabilidad. Examen: bocio difuso grado II, piel caliente y sudorosa, FC 110 x'. Lab: TSH <0,01 mUI/L, T4 libre 2,8 ng/dL (0,8–1,8 ng/dL), T3 total 260 ng/dL (80–180 ng/dL). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Tiroiditis subaguda con tirotoxicosis transitoria
- B. Adenoma tóxico de tiroides con hipertiroidismo clínico
- C. Enfermedad de Graves con hipertiroidismo clínico
- D. Bocio multinodular tóxico con hipertiroidismo clínico

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El diagnóstico se apoya en cómo es el bocio y en el conjunto clínico. La paciente es una mujer joven con un hipertiroidismo florido y sostenido, palpitaciones, baja de peso, irritabilidad, piel caliente y taquicardia, con la hormona tiroidea alta y la TSH suprimida. Y el dato que inclina la balanza es que el bocio es difuso, es decir la glándula está agrandada de manera homogénea, no por nódulos. Un hipertiroidismo con bocio difuso en una mujer joven es, con gran diferencia, enfermedad de Graves, el trastorno autoinmune en el que un anticuerpo estimula el receptor de TSH y hace que toda la glándula produzca hormona en exceso. La tiroiditis subaguda también da tirotoxicosis, pero es dolorosa, la glándula duele al tacto, suele seguir a un cuadro viral y es transitoria porque libera hormona preformada; nada de eso figura aquí, donde el cuadro lleva tres semanas de síntomas hipermetabólicos sin dolor. El adenoma tóxico produce el exceso hormonal desde un único nódulo hiperfuncionante, así que se palparía un nódulo solitario, no un bocio difuso. El bocio multinodular tóxico agranda la glándula pero a expensas de múltiples nódulos, típico de personas mayores con bocio de larga data, no el agrandamiento difuso y homogéneo de una mujer de treinta y cuatro años.

VILLAPEPA ENAM: Hipertiroidismo clínico sostenido + bocio difuso en mujer joven = enfermedad de Graves (autoinmune, anticuerpo que estimula el receptor de TSH). La tiroiditis subaguda es dolorosa y transitoria; el adenoma tóxico es un nódulo único y el bocio multinodular tiene múltiples nódulos en personas mayores.

PREGUNTA 49

En una campaña de tamizaje cardiovascular, se evalúa a una mujer de 55 años, no fumadora, niega diabetes e hipertensión, sin antecedentes personales de enfermedad cardiovascular. Refiere dieta rica en frituras y sedentarismo. Examen: PA 120/70 mmHg, IMC 29 kg/m². Lab: colesterol total 260 mg/dL, LDL 195 mg/dL, HDL 28 mg/dL, triglicéridos 140 mg/dL, glucosa 90 mg/dL, creatinina normal. Refiere que madre tuvo "colesterol muy alto" y un infarto a los 48 años. ¿Cuál es la conducta terapéutica inicial más adecuada?

- A. Recomendar suplementos naturales (omega-3, fitosteroles) como única estrategia inicial
- B. Indicar solo dieta y ejercicio, reevaluando en 6 meses antes de iniciar fármacos
- C. Iniciar estatina de alta intensidad + cambios en estilo de vida y educación sobre la enfermedad
- D. Prescribir fibratos como primera línea para reducir el colesterol LDL

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Dos cosas obligan a tratar con fármaco desde el inicio y no a esperar. La primera es el nivel de colesterol malo: un LDL de 195 es una cifra tan alta que por sí sola, sin necesidad de calcular ningún puntaje de riesgo, ya indica iniciar una estatina de alta intensidad; a partir de ese umbral el beneficio de bajar el colesterol es indiscutible. La segunda es el contexto familiar: una madre con colesterol muy alto y un infarto a los cuarenta y ocho años, sumado a un LDL tan elevado y un HDL muy bajo en la propia paciente, dibuja un hipercolesterolemia familiar, una condición hereditaria que carga el riesgo desde joven y que exige tratamiento potente y precoz. Por eso la conducta es arrancar la estatina de alta intensidad junto con los cambios de estilo de vida y educar a la paciente sobre su enfermedad. Confiar solo en suplementos como omega-3 o fitosteroles es insuficiente frente a un LDL de esa magnitud: bajan poco y no reemplazan a la estatina. Indicar solo dieta y ejercicio y reevaluar en seis meses posterga el tratamiento en alguien que ya tiene indicación farmacológica clara, perdiendo tiempo valioso. Y los fibratos no son la primera línea para bajar el LDL: su terreno son los triglicéridos altos, que aquí están casi normales, así que no atacan el problema principal.

VILLAPEPA ENAM: LDL de 195 (mayor o igual a 190) indica estatina de alta intensidad por sí solo, sin calcular riesgo, más aún con antecedente familiar de infarto precoz que sugiere hipercolesterolemia familiar. Los fibratos son para triglicéridos, no para bajar el LDL; los suplementos y solo dieta se quedan cortos.

PREGUNTA 50

Mujer de 22 años, nuligesta, acude por consejería en planificación familiar. Refiere tres parejas sexuales en el último año y antecedente de infección por *Chlamydia trachomatis*. Usa preservativos de manera intermitente y ha tenido dos abortos inducidos. Señala que le preocupa "volver a quedar embarazada" y manifiesta dificultad para tomar pastillas todos los días. ¿Qué método anticonceptivo le recomendaría?

- A. Píldoras de solo progestágeno
- B. Dispositivo intrauterino
- C. Diafragma vaginal
- D. Implante subdérmico

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que cruzar lo que la paciente necesita con lo que su historia permite. Ella quiere máxima protección frente al embarazo, ya tuvo dos abortos y, sobre todo, dice que no logra tomar una pastilla todos los días, así que cualquier método que dependa de la disciplina diaria está condenado a fallarle. Eso empuja hacia un método de larga duración que no exija acordarse cada día. Además tiene un perfil de riesgo para infecciones de transmisión sexual: varias parejas, uso intermitente de preservativo y un antecedente de clamidia. Juntando ambos factores, el implante subdérmico es la mejor recomendación: es altamente eficaz, dura años, no requiere ninguna acción diaria y, al colocarse bajo la piel del brazo, no implica manipular el cuello del útero. Las píldoras de solo progestágeno se descartan justo por lo que ella misma advierte: son de toma diaria estricta y ella no puede sostenerla. El dispositivo intrauterino es muy eficaz y de larga duración, pero su inserción atraviesa el

canal cervical y, en una mujer con antecedente de clamidia y alto riesgo de nuevas infecciones, se prefiere evitar esa vía por el riesgo de facilitar una enfermedad inflamatoria pélvica, así que no es la primera opción en este perfil. El diafragma depende de colocarlo correctamente en cada relación y tiene una eficacia mucho menor, incompatible con alguien que necesita la máxima protección y tiene dificultad para la constancia.

VILLAPEPA ENAM: Necesita máxima eficacia sin depender de la toma diaria y tiene riesgo alto de infección de transmisión sexual (antecedente de clamidia, varias parejas) = implante subdérmico: larga duración, sin acción diaria y sin manipular el cuello. El dispositivo intrauterino se evita por la vía cervical en este perfil, y las píldoras diarias fallarían por la dificultad de constancia.

PREGUNTA 51

Mujer de 19 años, nulípara, acude por sangrado vaginal. Refiere amenorrea de 10 semanas. Examen: Útero de 15 cm. Lab: β -hCG 132 000 ul/Dl. Ecografía transvaginal: Útero de 15 cm con endometrio ocupado por imagen en "copos de nieve" sin embrión visible. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

- A. Inducción con misoprostol por vía vaginal
- B. Histerectomía abdominal total
- C. Conducta expectante con control ecográfico y de β -hCG
- D. Evacuación uterina mediante aspiración al vacío

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Todo el cuadro dibuja una mola hidatiforme completa: amenorrea con sangrado, un útero mucho más grande de lo que corresponde a diez semanas, una gonadotropina coriónica altísima y, el dato que confirma, la ecografía con la imagen en copos de nieve o tormenta de nieve sin embrión, que es el aspecto de las vellosidades hinchadas que llenan la cavidad. Ante esto, el manejo inicial es vaciar el útero, y la técnica de elección es la evacuación por aspiración al vacío, porque succiona de forma controlada el tejido molar minimizando el sangrado y el riesgo de perforación, y permite obtener material para confirmar el diagnóstico y luego seguir a la paciente con la gonadotropina. La inducción con misoprostol se usa para expulsar un embarazo no molar, pero en la mola se prefiere evitar los uterotónicos de inducción antes de vaciar, porque las contracciones intensas pueden favorecer la diseminación de tejido trofoblástico; la aspiración es más segura. La histerectomía es una opción demasiado radical para una mujer de diecinueve años nulípara que desea conservar la fertilidad; se reserva para casos seleccionados con paridad cumplida o complicaciones, no como manejo inicial de rutina. La conducta expectante es inaceptable: una mola es una enfermedad trofoblástica con potencial de malignizar, no se puede simplemente observar; hay que evacuarla y vigilar la gonadotropina después.

VILLAPEPA ENAM: Útero mayor que la edad gestacional + gonadotropina muy elevada + imagen en copos de nieve sin embrión = mola hidatiforme completa. El manejo inicial es la evacuación por aspiración al vacío, seguida de control de la gonadotropina; no se observa ni se induce con misoprostol.

PREGUNTA 52

Puérpera de 24 horas, tras parto vaginal de recién nacido de 4200 g con analgesia epidural, consulta por dolor intenso en la región púbica y lumbar, con irradiación a ambos muslos, que le impide deambular. Examen: PA 100/60 mmHg, FC: 72 x'. Refiere dolor muy intenso a la palpación sobre la sínfisis del pubis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Luxación sacrocoxígea secundaria al paso del feto

- B. Fractura del acetábulo por esfuerzo del trabajo de parto
- C. Diástasis de la sínfisis del pubis
- D. Bloqueo motor secundario a analgesia epidural

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Los ingredientes están todos: un bebé grande, de más de cuatro kilos, que forzó el paso por la pelvis, y una puerpera que a las veinticuatro horas no puede caminar por un dolor intenso justo sobre la sínfisis del pubis, con irradiación a los muslos. El punto doloroso exactamente sobre la sínfisis es la pista central. Durante el embarazo, las hormonas relajan los ligamentos de la pelvis para facilitar el parto, y cuando pasa un feto macrosómico esa unión de los dos huesos púbicos por delante puede separarse más de la cuenta y hasta desgarrarse: eso es la diástasis de la sínfisis del pubis, que produce un dolor púbico severo que impide la marcha, tal como aquí. La luxación sacrococcígea afecta la parte posterior de la pelvis, el cóccix, y daría dolor en la región del sacro y el coxis al sentarse, no un dolor exquisito sobre el pubis por delante. La fractura de acetábulo no ocurre por el esfuerzo de un parto normal, requiere un traumatismo de alta energía sobre la cadera. El bloqueo motor de la epidural sería una debilidad de las piernas por el anestésico, sin dolor localizado en la sínfisis, y además a las veinticuatro horas ya debería haberse resuelto el efecto del bloqueo; lo que tiene esta paciente es dolor púbico focal, no parálisis por anestesia.

VILLAPEPA ENAM: Parto de feto macrosómico + dolor púbico intenso que impide caminar y punto exquisito sobre la sínfisis = diástasis de la sínfisis del pubis (separación de los huesos púbicos favorecida por la laxitud hormonal). El punto doloroso sobre el pubis la distingue del dolor coccígeo o del bloqueo epidural.

PREGUNTA 53

Varón de 70 años, con tres meses de pérdida de peso, anemia y mareos. Examen: adelgazado y pálido, abdomen ruidos intestinales presentes, se palpa masa de 10 × 10 cm en flanco derecho, no dolorosa. Colonoscopia: masa ulcerada en colon ascendente. Bx: adenocarcinoma. TC de abdomen y tórax: lesión localizada en colon ascendente, sin metástasis a distancia. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- A. Radioterapia preoperatoria dirigida al segmento de colon ascendente comprometido
- B. Quimioterapia neoadyuvante sistémica seguida de resección diferida del tumor
- C. Laparoscopia previa para confirmar la extensión intrabdominal de la neoplasia
- D. Hemicolectomía derecha con linfadenectomía regional y anastomosis ileocólica

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El diagnóstico ya está cerrado: un adenocarcinoma de colon ascendente, confirmado por biopsia, que la tomografía muestra localizado y sin metástasis. En el cáncer de colon localizado y resecable, el tratamiento es directamente quirúrgico, y para un tumor del colon derecho la operación correcta es la hemicolectomía derecha, que extirpa el segmento afectado junto con su territorio de drenaje linfático y luego une el íleon con el colon restante. Quitar los ganglios regionales es parte esencial porque permite estadificar bien y retirar la posible extensión ganglionar. La radioterapia preoperatoria no es la conducta en el cáncer de colon; su papel está en el cáncer de recto, que por su ubicación en la pelvis sí se beneficia de irradiación antes de operar, mientras que el colon, móvil dentro del abdomen, no se irradia de rutina. La quimioterapia neoadyuvante antes de operar tampoco es el estándar en el cáncer de colon localizado; la quimioterapia se plantea después de la cirugía, como adyuvante, según lo que revele el estudio de la pieza y los ganglios, no para achicar el tumor antes. Hacer una laparoscopia solo para confirmar extensión es innecesario cuando la tomografía ya mostró enfermedad localizada sin metástasis; agregaría un procedimiento sin cambiar la indicación, que es operar.

VILLAPEPA ENAM: Adenocarcinoma de colon ascendente localizado y resecable = hemicolectomía derecha con linfadenectomía y anastomosis ileocólica de entrada. La radioterapia y la neoadyuvancia son del cáncer de recto, no de colon; la quimioterapia del colon va después de operar, como adyuvante.

PREGUNTA 54

¿Cuál es el proceso que permite describir y explicar el estado de salud y sus determinantes sociales en una población definida?

- A. Plan de gestión institucional
- B. Análisis situacional de salud
- C. Plan operativo institucional
- D. Análisis estratégico multisectorial

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La pregunta describe con precisión una herramienta concreta de salud pública: un proceso cuyo objetivo es retratar el estado de salud de una población y explicar por qué está así, analizando sus determinantes sociales. Ese proceso tiene un nombre propio, el análisis situacional de salud, que es el diagnóstico integral que caracteriza los problemas sanitarios de un territorio, cómo se distribuyen y qué factores sociales, económicos y ambientales los condicionan, para servir de base a la planificación. Por eso es la respuesta. El plan de gestión institucional y el plan operativo institucional son documentos de planificación y ejecución de una institución: dicen qué se va a hacer, con qué recursos y en qué plazos, pero no son el diagnóstico que describe y explica la salud de la población; de hecho, se construyen a partir del análisis situacional, no lo reemplazan. El análisis estratégico multisectorial suena parecido, pero apunta a coordinar a distintos sectores para una estrategia común, no es el proceso específico de caracterizar el estado de salud y sus determinantes en una población definida, que es exactamente lo que define al análisis situacional de salud.

VILLAPEPA ENAM: Describir y explicar el estado de salud de una población y sus determinantes sociales = análisis situacional de salud, el diagnóstico que fundamenta la planificación. Los planes de gestión u operativos ejecutan acciones; se construyen a partir del análisis, no lo sustituyen.

PREGUNTA 55

En un distrito con incremento de casos de enfermedad diarreica aguda, el equipo de la red de salud visita periódicamente los establecimientos de salud y revisa activamente los registros de atención, además de llamar a los responsables de estadísticas para identificar nuevos casos y notificarlos de inmediato. ¿Qué tipo de vigilancia epidemiológica están realizando principalmente?

- A. Centinela
- B. Activa
- C. Pasiva
- D. Sindrómica

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La clave está en quién da el primer paso para encontrar los casos. Aquí el equipo de salud no se queda esperando a que los establecimientos reporten: sale a buscar, visita periódicamente los servicios, revisa por su cuenta los registros de atención y llama a los encargados de estadística para detectar casos nuevos. Ese comportamiento de ir tras el dato, de rastrearlo activamente en las fuentes, es la definición de la vigilancia activa, en la que el sistema de salud toma la iniciativa de buscar los casos en lugar de aguardar la notificación espontánea. Precisamente por contraste, la vigilancia pasiva es lo opuesto: el nivel central espera y recibe los reportes que los establecimientos envían por rutina, sin salir a buscarlos, así que no describe lo que hace este equipo. La vigilancia centinela se basa en unos pocos establecimientos seleccionados que monitorizan de forma intensiva un evento específico para estimar tendencias, no en visitar y revisar activamente todos los registros del distrito. La vigilancia sindrómica clasifica los casos por conjuntos de síntomas para detectar brotes de forma precoz, un enfoque distinto que se refiere a qué se vigila, no a la búsqueda activa que caracteriza a este operativo.

VILLAPEPA ENAM: Cuando el equipo sale a buscar los casos, visita servicios y revisa registros por iniciativa propia = vigilancia activa. La pasiva espera que lleguen los reportes; la centinela usa pocos establecimientos selectos; la sindrómica agrupa por síntomas.

PREGUNTA 56

Recién nacida de 3 días, producto de parto podálico, sana y hemodinamia estable. En el examen físico se encuentra signo de Ortolani positivo en la cadera izquierda. ¿Cuál es la indicación inicial más apropiada?

- A. Mantener cadera en abducción
- B. Observación y control mensual
- C. Administrar vitamina D y controles CRED
- D. Solicitar radiografía de cadera

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El signo de Ortolani positivo significa que la cabeza del fémur está fuera de su sitio y, al abrir la cadera, entra al acetábulo con un resalto palpable: es decir, hay una cadera luxada que se puede reducir, el hallazgo cardinal de la displasia del desarrollo de la cadera. Y el parto podálico es justamente uno de los principales factores de riesgo. Frente a un Ortolani positivo en un recién nacido, la conducta inicial es mantener la cadera reducida y estable en abducción, que es lo que hace el arnés de Pavlik: sostiene las caderas flexionadas y abiertas para que la cabeza femoral se mantenga dentro del acetábulo y este termine de formarse correctamente. Por eso la indicación es la abducción. Observar y controlar cada mes sería dejar pasar el tiempo en una cadera que ya está luxada y que necesita tratamiento ahora; cuanto antes se reduce y se estabiliza, mejor se desarrolla la articulación. Dar vitamina D y seguir los controles habituales trata la displasia como si fuera un problema nutricional del hueso, que no es el caso: aquí el problema es mecánico, de posición articular. Pedir una radiografía de cadera en un recién nacido es poco útil porque a esa edad la cabeza femoral todavía es cartílago y no se ve bien en la radiografía; el estudio de imagen apropiado en el lactante pequeño es la ecografía, pero con un Ortolani claramente positivo la indicación inmediata es tratar con abducción.

VILLAPEPA ENAM: Ortolani positivo (cadera luxada reductible) en recién nacido, más aún con parto podálico = displasia del desarrollo de la cadera. La conducta inicial es mantener la cadera en abducción (arnés de Pavlik); la radiografía es poco útil en el neonato porque la cabeza femoral aún es cartílago.

PREGUNTA 57

Varón de 25 años sufre atropello y de inmediato es trasladado a emergencia. Examen: PA: 60/40 mmHg, disnea intensa, ingurgitación yugular. Tórax: ausencia de MV en HTD, timpanismo a la percusión y desviación de la tráquea hacia el lado contralateral. ¿Cuál es la medida inmediata más adecuada?

- A. Rx de tórax urgente y tubo de drenaje en 7° EIC en línea axilar anterior
- B. Ventilación con presión positiva de inmediato y traslado a hospital de referencia
- C. Intubación orotraqueal inmediata y observación en unidad de cuidados intensivos
- D. Descompresión con aguja gruesa en 5° EIC en línea axilar media

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El cuadro es un neumotórax a tensión y hay que reconocerlo en segundos, porque mata rápido. Todos los signos apuntan a lo mismo: tras el atropello, el paciente está en shock con presión de sesenta, con las yugulares ingurgitadas, sin murmullo vesicular y con timpanismo en un hemitórax, y la tráquea desviada hacia el lado sano. Eso significa que el aire está entrando al tórax y no puede salir, se acumula a presión, colapsa el pulmón y empuja el mediastino hacia el otro lado, estrangulando el retorno de sangre al corazón, lo que explica la hipotensión y las yugulares llenas. Es un diagnóstico clínico y una emergencia que no espera ningún estudio: la medida inmediata es descomprimir el tórax con una aguja gruesa para convertir la tensión en un neumotórax simple y aliviar la presión sobre el corazón, y luego colocar el tubo definitivo. Pedir una radiografía antes de actuar es un error mortal: perder minutos en la imagen mientras el paciente se muere de un cuadro que ya es evidente por la clínica. Ventilar con presión positiva sin descomprimir empeora la tensión, porque mete todavía más aire al espacio pleural. Intubar y observar en cuidados intensivos tampoco resuelve la compresión mecánica: por más que asegures la vía aérea, si no sacas el aire a presión el paciente sigue colapsado. Primero la aguja, después todo lo demás.

VILLAPEPA ENAM: Trauma + shock + ingurgitación yugular + ausencia de murmullo, timpanismo y tráquea desviada al lado contrario = neumotórax a tensión, diagnóstico clínico. La medida inmediata es descompresión con aguja gruesa; jamás pedir radiografía antes ni ventilar a presión positiva sin descomprimir.

PREGUNTA 58

Mujer de 58 años, diabética e hipertensa, que ingresa a la unidad de cuidados intensivos por un shock séptico de origen urinario. A pesar de la reanimación con fluidos y vasopresores, su estado se deteriora y es colocada en ventilación mecánica con FiO2 90%. Considerando el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) como causa de su falla respiratoria. ¿Cuál de los siguientes hallazgos histopatológicos se esperaría encontrar en esta fase de la enfermedad?

- A. Hiperplasia de células caliciformes con engrosamiento muscular bronquial difuso
- B. Necrosis caseosa central rodeada de granulomas epitelioides y células gigante
- C. Destrucción de tabiques alveolares con espacios aéreos agrandados y escasa fibrosis
- D. Daño alveolar difuso con membranas hialinas y edema intersticial y alveolar

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El síndrome de dificultad respiratoria aguda tiene un correlato microscópico con nombre propio: el daño alveolar difuso. En su fase aguda o exudativa, que es la que corresponde a esta paciente recién colapsada por la sepsis, la inflamación destruye la barrera entre el alvéolo y el capilar, se vuelve permeable y deja escapar líquido rico en proteínas hacia el intersticio y el propio alvéolo, produciendo edema. Además, sobre las paredes alveolares dañadas se depositan las membranas hialinas, unas láminas de material proteináceo que son el sello histológico

de esta fase. Por eso lo que se espera encontrar es precisamente daño alveolar difuso con membranas hialinas y edema intersticial y alveolar. La hiperplasia de células caliciformes con engrosamiento del músculo bronquial describe las vías aéreas del asma o la bronquitis crónica, no el daño del parénquima alveolar del síndrome. La necrosis caseosa rodeada de granulomas con células gigantes es la lesión de la tuberculosis, una respuesta granulomatosa que nada tiene que ver con el edema y las membranas hialinas de este cuadro agudo. La destrucción de los tabiques alveolares con espacios agrandados y poca fibrosis es la descripción del enfisema, una enfermedad crónica y destructiva por tabaco, opuesta al proceso exudativo agudo que ocurre aquí.

VILLAPEPA ENAM: El correlato histológico del SDRA es el daño alveolar difuso: en la fase aguda, membranas hialinas sobre las paredes alveolares y edema intersticial y alveolar por rotura de la barrera alvéolo-capilar. La hiperplasia caliciforme es del asma, el granuloma caseoso de la tuberculosis y la destrucción de tabiques del enfisema.

PREGUNTA 59

Neonato de 3 semanas de vida, nacido por parto vaginal, acude por tos de varios días, taquipnea y conjuntivitis bilateral purulenta. Se encuentra afebril, Rx de tórax: infiltrado intersticial difuso. ¿Cuál es el agente causal más probable?

- A. *Mycoplasma pneumoniae*
- B. *Chlamydia trachomatis*
- C. *Escherichia coli*
- D. *Streptococcus agalactiae*

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La combinación es muy sugerente: un neonato de tres semanas, nacido por vía vaginal, que junta en un mismo cuadro conjuntivitis de ambos ojos y una neumonía con tos, taquipnea y un infiltrado difuso en el pulmón, todo esto sin fiebre. Esa dupla de conjuntivitis más neumonía afebril en las primeras semanas de vida, en un niño que nació por parto vaginal, es la marca de la *Chlamydia trachomatis* adquirida al pasar por el canal del parto de una madre con la infección genital. El germen coloniza primero la conjuntiva y luego el pulmón, y produce esta neumonía característicamente sin fiebre. El *Mycoplasma pneumoniae* causa neumonía atípica, pero en niños mayores y escolares, no en un neonato de pocas semanas, y no da este síndrome con conjuntivitis. La *Escherichia coli* y el *Streptococcus agalactiae* son agentes de la sepsis y la neumonía neonatal precoz, de los primeros días de vida, y típicamente cursan con un niño febril o hipotérmico y de aspecto séptico, no con este cuadro afebril de conjuntivitis y neumonía intersticial a las tres semanas; el patrón afebril con conjuntivitis apunta directo a la chlamydia.

VILLAPEPA ENAM: Neonato con conjuntivitis bilateral + neumonía afebril de infiltrado intersticial, nacido por parto vaginal = *Chlamydia trachomatis* adquirida en el canal del parto. El estreptococo del grupo B y la *E. coli* dan sepsis neonatal febril precoz; el *Mycoplasma* afecta a niños mayores.

PREGUNTA 60

Mujer de 28 años consulta por fatiga progresiva e ictericia. Examen: esplenomegalia. Hemoglobina: 8 g/dL. Frotis: esferocitos. CHCM: 38 g/dL. Prueba de Coombs directo: negativa. Prueba de fragilidad osmótica: positiva. ¿Cuál es la terapia adecuada en este paciente?

- A. Extirpación quirúrgica del bazo
- B. Transfusión de concentrados de eritrocitos

- C. Suplementación con ácido fólico de por vida
- D. Terapia Inmunosupresora con glucocorticoides

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El laboratorio arma el diagnóstico pieza por pieza. Hay una anemia hemolítica, con ictericia y esplenomegalia, y el frotis muestra esferocitos, glóbulos rojos que perdieron su forma de disco y se volvieron esferas. La concentración de hemoglobina dentro del eritrocito está alta, coherente con esas células deshidratadas y densas, y la prueba de fragilidad osmótica es positiva, lo que confirma que esos hematíes se rompen con facilidad. El dato que descarta la causa autoinmune es el Coombs directo negativo: no hay anticuerpos pegados a los glóbulos rojos. Todo junto es una esferocitosis hereditaria, un defecto de las proteínas de la membrana del eritrocito que lo hace esférico y frágil. Y el punto central del tratamiento es entender dónde se destruyen esos esferocitos: en el bazo, que los atrapa por su forma anómala. Por eso la terapia definitiva es la esplenectomía, quitar el bazo, que corta el sitio de destrucción y resuelve la hemólisis, elevando la hemoglobina. El ácido fólico se da como apoyo porque la producción acelerada de glóbulos rojos consume folato, pero es un coadyuvante, no la terapia que cura la hemólisis. La transfusión alivia una anemia severa puntual, pero no soluciona el problema de fondo, que es la destrucción esplénica continua. Los glucocorticoides serían el tratamiento si esto fuera una anemia hemolítica autoinmune, pero el Coombs negativo descarta ese mecanismo, así que los corticoides no tienen lugar aquí.

VILLAPEPA ENAM: Anemia hemolítica + esferocitos + concentración de hemoglobina elevada + fragilidad osmótica positiva + Coombs negativo = esferocitosis hereditaria. La terapia definitiva es la esplenectomía, porque el bazo es donde se destruyen los esferocitos; los corticoides son para la hemólisis autoinmune (Coombs positivo).

PREGUNTA 61

Respecto al uso de antiepilépticos en mujeres embarazadas. ¿Cuál fármaco se asocia de manera más consistente con un alto riesgo teratogénico?

- A. Lamotrigina
- B. Levetiracetam
- C. Fenobarbital
- D. Ácido valproico

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Entre todos los antiepilépticos, el que carga la peor reputación en el embarazo, y de manera más consistente, es el ácido valproico. Es el que más se asocia a malformaciones graves, en especial los defectos de cierre del tubo neural como la espina bífida, pero también cardiopatías y anomalías faciales, y a algo que va más allá del nacimiento: un mayor riesgo de menor coeficiente intelectual y de trastornos del neurodesarrollo en el niño expuesto dentro del útero. Ese daño combinado, estructural y del desarrollo cognitivo, es lo que lo convierte en el fármaco a evitar cuando se puede en una mujer que planea embarazarse. El fenobarbital también es teratogénico, pertenece a los antiepilépticos clásicos con riesgo, pero el valproico lo supera de forma clara y consistente en la evidencia. La lamotrigina es, al contrario, uno de los antiepilépticos considerados más seguros durante la gestación, de los preferidos cuando hay que mantener el tratamiento en una embarazada. El levetiracetam es igualmente de los de menor riesgo teratogénico conocido, otra de las opciones que se eligen en el embarazo justamente para huir del valproico.

VILLAPEPA ENAM: El antiepiléptico más teratogénico de forma consistente es el ácido valproico: defectos del tubo neural, malformaciones y daño del neurodesarrollo con menor coeficiente intelectual. Lamotrigina y levetiracetam son de los más seguros en el embarazo.

PREGUNTA 62

En un laboratorio de enseñanza, se analiza la coagulación de una muestra de sangre normal colocada en un tubo de vidrio sin anticoagulante. Se observa que la coagulación se inicia por activación de la vía intrínseca a través del contacto con la superficie cargada del vidrio. ¿Cuál es el principal factor responsable de la activación por contacto?

- A. X
- B. VII
- C. XII
- D. VII

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La pista está en las palabras vía intrínseca y activación por contacto. La cascada de la coagulación tiene dos entradas: la vía extrínseca, que arranca con el factor tisular liberado por el daño, y la vía intrínseca, que puede dispararse cuando la sangre toca una superficie cargada negativamente, como el vidrio del tubo. El factor que detecta ese contacto y enciende la vía intrínseca es el factor doce, también llamado factor de Hageman: al pegarse a la superficie de vidrio se activa y pone en marcha toda la cascada intrínseca. Por eso es el responsable de la activación por contacto. El factor siete es el iniciador de la otra vía, la extrínseca, junto con el factor tisular, así que no corresponde a la activación por vidrio. El factor ocho actúa más adelante dentro de la vía intrínseca, como cofactor amplificador, pero no es el que inicia el contacto con la superficie; es un eslabón posterior. El factor diez es el punto donde ambas vías confluyen, la vía común, así que tampoco es el iniciador del contacto, sino un paso posterior compartido; el que enciende la mecha en el vidrio es el factor doce.

VILLAPEPA ENAM: La activación por contacto con una superficie cargada (vidrio) inicia la vía intrínseca a través del factor XII (de Hageman). El factor VII inicia la vía extrínseca con el factor tisular; el X es el punto de confluencia de la vía común.

PREGUNTA 63

Niño de 15 meses, previamente sano, es llevado a consulta por una lesión dolorosa en la cara anterior de la rodilla izquierda de 7 días de evolución. El cuadro comenzó con tres pústulas alrededor de folículos pilosos, que progresaron hasta formar una placa eritematosa, caliente, indurada y muy dolorosa, con varios puntos de supuración en la superficie. Presenta fiebre de hasta 39 °C y adenopatía inguinal ipsilateral dolorosa. Recibió amoxicilina-ácido clavulánico por 5 días sin mejoría. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Forúnculo
- B. Impétigo
- C. Ectima
- D. Ántrax

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que seguir la evolución de la lesión. Empezó como varias pústulas alrededor de folículos del pelo, es decir varias foliculitis profundas, y esas lesiones no quedaron aisladas sino que se fusionaron en una sola placa grande, indurada, caliente, muy dolorosa y, el dato decisivo, con varios puntos de supuración en su superficie. Cuando varios forúnculos vecinos coalescen en una única masa inflamatoria que drena por múltiples bocas, eso es un ántrax, entendido en el sentido del español médico como carbúnculo, no como la enfermedad por *Bacillus anthracis*. Los múltiples orificios de drenaje son la marca que lo distingue. El forúnculo simple es una sola unidad, un folículo infectado que forma un nódulo con un único punto de pus, no una placa con varias bocas de supuración; aquí ya se pasó de un forúnculo a la confluencia de varios. El impétigo es una infección superficial de la piel, con costras color miel, sin la induración profunda, el dolor intenso ni los múltiples trayectos supurativos de este cuadro. El ectima es una úlcera con costra que penetra más que el impétigo, pero es una lesión ulcerada única y bien delimitada, no la placa con múltiples puntos de drenaje que resulta de fusionar varios forúnculos; el conjunto de forúnculos coalescentes con varias bocas es lo que define al ántrax.

VILLAPEPA ENAM: Varios forúnculos que se fusionan en una placa indurada, dolorosa y con múltiples bocas de supuración = ántrax (carbúnculo en español, no la enfermedad por *Bacillus anthracis*). El forúnculo es una sola unidad con un punto de pus; el impétigo es superficial con costra melicérica.

PREGUNTA 64

Varón de 30 años sufre una herida punzo-penetrante por arma blanca en el quinto espacio intercostal anterior izquierdo. Minutos después presenta disnea intensa y palidez. Examen: PA 80/60 mmHg, ansioso, ingurgitación yugular. RC disminuidos. Pulmones: MV pasa en ACP, sin ruidos agregados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Taponamiento cardíaco traumático
- B. Neumomediastino traumático agudo
- C. Neumotórax a tensión en hemitórax izquierdo
- D. Hemotórax masivo en hemitórax izquierdo

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La localización de la herida y los signos dibujan el cuadro. Una puñalada en el quinto espacio intercostal anterior izquierdo cae sobre el área del corazón, y a los minutos aparece la tríada clásica del taponamiento cardíaco: hipotensión, ingurgitación de las venas del cuello y ruidos cardíacos apagados o disminuidos. Eso ocurre porque la sangre se acumula rápido en el saco pericárdico, que es poco distensible, y comprime el corazón por fuera impidiendo que se llene; el corazón no puede recibir sangre, cae el gasto y sube la presión venosa, de ahí las yugulares ingurgitadas. El dato que sella el diagnóstico y lo separa de las otras opciones es que los pulmones están limpios: el murmullo vesicular pasa bien en ambos campos, sin ruidos agregados. El neumotórax a tensión también da hipotensión y yugulares ingurgitadas, pero cursaría con ausencia de murmullo vesicular y timpanismo en el lado afectado, y aquí el pulmón ventila normal, así que se descarta. El hemotórax masivo daría matidez y ausencia de murmullo en la base por la sangre que llena la pleura, junto con el shock, pero de nuevo el examen pulmonar es normal, incompatible con un tórax lleno de sangre. El neumomediastino no produce esta tríada de compresión cardíaca con colapso hemodinámico. Pulmones limpios más tríada de compresión cardíaca igual a taponamiento.

VILLAPEPA ENAM: Herida en el área precordial (5º espacio anterior izquierdo) + hipotensión + ingurgitación yugular + ruidos cardíacos disminuidos, con pulmones limpios = taponamiento cardíaco (tríada de Beck). Los pulmones limpios descartan el neumotórax a tensión y el hemotórax, que abolirían el murmullo vesicular.

PREGUNTA 65

En una región de la selva peruana, la mortalidad infantil es de 40 por 1 000 nacidos vivos en comunidades rurales pobres con limitado acceso a agua segura y servicios de salud, mientras que en las áreas urbanas es de 15 por 1 000 nacidos vivos, con mejor cobertura de servicios básicos y de salud. Desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud. ¿Cómo se denomina este tipo de diferencia en mortalidad infantil?

- A. Inequidad en salud
- B. Variación biológica
- C. Desigualdad en salud
- D. Diferencia en salud

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El matiz que decide la respuesta es que esta diferencia de mortalidad no es azarosa ni biológica: está determinada por condiciones sociales, la pobreza, la falta de agua segura y el peor acceso a servicios, y por eso es evitable e injusta. Cuando una diferencia en salud se origina en circunstancias sociales desfavorables, es innecesaria y podría corregirse, deja de ser una simple desigualdad numérica y pasa a llamarse inequidad en salud. Ese componente de injusticia y evitabilidad es lo que la define, y es lo que la pregunta subraya al enmarcarla en los determinantes sociales. La desigualdad en salud es el término más neutro, describe que existe una diferencia medible entre grupos, pero no incorpora el juicio de que sea injusta; toda inequidad es una desigualdad, pero no toda desigualdad es inequidad. La variación biológica se refiere a diferencias naturales entre individuos por edad, sexo o genética, que no son evitables ni injustas, lo contrario de lo que ocurre aquí, donde el origen es social. Diferencia en salud es una expresión demasiado genérica que solo constata la brecha sin nombrar su carácter injusto; el término preciso para una brecha originada en desventajas sociales, evitable e injusta, es inequidad.

VILLAPEPA ENAM: Diferencia de mortalidad originada en condiciones sociales injustas y evitables (pobreza, acceso desigual) = inequidad en salud. La desigualdad solo constata la brecha sin juzgarla; la variación biológica es natural e inevitable, no social.

66. Varón de 64 años, fumador crónico, desde hace 2 meses presenta edema maleolar bilateral, astenia y pérdida de peso de 4 kg. Examen: PA 135/80 mmHg, IMC 23. Lab: Orina: proteinuria >3,5 g/24 h, sin hematuria. Albúmina 2,2 g/dL, colesterol 310 mg/dL. Biopsia renal: compatible con nefropatía membranosa. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A. Iniciar glucocorticoides a altas dosis
- B. Manejo conservador
- C. Buscar neoplasia sólida oculta
- D. Tratar como glomerulonefritis posinfecciosa

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Lo que cambia la conducta es el perfil del paciente. La biopsia confirma una nefropatía membranosa que causa el síndrome nefrótico, con proteinuria masiva, albúmina baja y colesterol alto. Pero en un varón de sesenta y cuatro años, fumador crónico, que además está perdiendo peso, la nefropatía membranosa tiene alta probabilidad de ser secundaria, es decir la manifestación renal de una enfermedad de fondo, y en el adulto mayor la asociación más temida es con un cáncer sólido oculto, con frecuencia de pulmón, que en un fumador

con baja de peso enciende todas las alarmas. Por eso, antes de tratar el riñón, la conducta prioritaria es buscar esa neoplasia escondida, porque encontrarla y tratarla puede resolver también la nefropatía. Iniciar corticoides a altas dosis de entrada sería tratar la enfermedad como si fuera primaria e inmunológica, sin haber descartado que detrás haya un tumor que es la verdadera causa; se pondría inmunosupresión en un posible cáncer. El manejo conservador con medidas de soporte es parte del cuidado del síndrome nefrótico, pero por sí solo ignora la obligación de investigar la causa subyacente en este perfil de alto riesgo oncológico. Tratarla como una glomerulonefritis posinfecciosa es un error diagnóstico: esa entidad aparece tras infecciones, cursa con hematuria e hipocomplementemia y es otra enfermedad distinta de la membranosa que la biopsia ya confirmó.

VILLAPEPA ENAM: Nefropatía membranosa en adulto mayor fumador con pérdida de peso = alta sospecha de forma secundaria a neoplasia sólida oculta (pulmón). La conducta prioritaria es buscar el cáncer antes de inmunosuprimir, porque tratarlo puede resolver la nefropatía.

67. Varón 70 años, agricultor del altiplano acude porque desde hace 9 meses presenta cansancio, aumento de peso, intolerancia al frío y estreñimiento. Examen: FC 50 x', reflejos osteotendinosos con fase de relajación lenta. Laboratorio: TSH 22 mUI/L, T4 libre 0.2, anticuerpos anti-TPO positivos elevados. No consume fármacos ni cirugías previas. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A. Metaproterenol (orciprenalina) para bradicardia
- B. Atribuyendo síntomas al envejecimiento
- C. Levotiroxina a dosis ajustada
- D. Ecografía tiroidea y postergar tratamiento

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Todo el cuadro es un hipotiroidismo primario franco. Los síntomas encajan uno a uno: cansancio, aumento de peso, intolerancia al frío, estreñimiento, bradicardia y ese signo tan característico de los reflejos con fase de relajación lenta, el reflejo perezoso del hipotiroidismo. El laboratorio lo confirma sin dudas: la TSH está muy alta y la hormona tiroidea libre muy baja, el patrón del fallo de la propia glándula, y los anticuerpos anti-TPO elevados señalan la causa, una tiroiditis autoinmune de Hashimoto. Frente a un hipotiroidismo clínico y bioquímico establecido, la conducta es reemplazar la hormona que falta, y el tratamiento es la levotiroxina, empezando con cuidado y ajustando la dosis, sobre todo en un adulto mayor en quien se sube despacio para no forzar el corazón. Dar metaproterenol para la bradicardia es tratar un síntoma aislado sin ver la causa: la frecuencia baja es consecuencia del hipotiroidismo y se corrige al reponer la hormona, no con un estimulante. Atribuir todo al envejecimiento es un error que dejaría sin tratamiento a un paciente con una enfermedad reversible bien documentada por el laboratorio. Pedir una ecografía y postergar el tratamiento retrasa sin motivo el reemplazo hormonal que el paciente ya necesita; el diagnóstico está hecho con la clínica y las hormonas, y demorar la levotiroxina solo prolonga sus síntomas.

VILLAPEPA ENAM: TSH muy alta + T4 libre muy baja + anti-TPO positivos con clínica de hipotiroidismo (bradicardia, reflejos de relajación lenta) = hipotiroidismo primario por Hashimoto. El tratamiento es levotiroxina con dosis ajustada, iniciada con cuidado en el adulto mayor; no se posterga ni se trata solo la bradicardia.

68. Recién nacido de 29 semanas de gestación, es atendido en sala de partos y será trasladado a la UCIN. Se desea reducir el riesgo de que desarrolle displasia broncopulmonar. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es la más apropiada?

- A. Uso de tubo en T con presiones definidas
- B. Secado con toallas precalentadas y estimulación energética

C. Garantizar SO_2 94-98%

D. Restricción hídrica final < 140 ml/kg/día

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Para entender qué previene la displasia broncopulmonar hay que saber cómo se produce: el pulmón del prematuro es inmaduro y frágil, y se daña sobre todo por dos agresiones que le imponemos al reanimarlo, el exceso de volumen y presión en cada insuflación, el volutrauma y barotrauma, y el exceso de oxígeno. La estrategia que ataca lo primero es usar un dispositivo que entregue las ventilaciones con presiones controladas y consistentes, el reanimador con pieza en T, que permite fijar la presión inspiratoria y mantener una presión positiva al final de la espiración de forma precisa, en lugar de las insuflaciones irregulares y potencialmente lesivas de una bolsa manual. Esa ventilación gentil y medida protege el pulmón inmaduro y reduce el riesgo de displasia. Secar y estimular es parte de la reanimación inicial de todo recién nacido, pero la estimulación debe ser suave, no enérgica, y de todos modos no es la maniobra que previene la displasia. Garantizar una saturación de noventa y cuatro a noventa y ocho por ciento es apuntar demasiado alto en un prematuro: esas cifras favorecen la hiperoxia, que es justamente uno de los factores que causan displasia y retinopatía; en el prematuro se busca una saturación más contenida. La restricción hídrica cuidadosa puede ayudar a la evolución pulmonar, pero un límite de ciento cuarenta mililitros por kilo al día no es una restricción marcada ni la intervención de sala de partos que más impacta; la protección desde el primer minuto la da la ventilación con presiones controladas.

VILLAPEPA ENAM: La displasia broncopulmonar del prematuro se produce por volutrauma, barotrauma e hiperoxia. La intervención de sala de partos que más protege es ventilar con presiones controladas mediante tubo en T; apuntar a saturación de 94-98% favorece la hiperoxia, que también causa displasia.

69. Mujer de 48 años acude por dolor musculoesquelético generalizado de 10 meses de evolución, que compromete espalda, hombros, nuca y extremidades. Refiere fatiga, sueño no reparador y sensación de "no poder caminar" durante las crisis de dolor. Ha recibido AINE y relajantes musculares con escasa mejoría. Los exámenes de laboratorio básicos (hemograma, VSG, PCR, TSH, perfil bioquímico) son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A. Fibromialgia

B. Hipotiroidismo subclínico

C. Polimialgia reumática

D. Síndrome de fatiga crónica

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El retrato es el de una fibromialgia. Una mujer de mediana edad con dolor musculoesquelético generalizado y crónico, que abarca varias regiones del cuerpo, acompañado de fatiga y de un sueño que no descansa, y que no ha respondido a los antiinflamatorios ni a los relajantes musculares. Y el dato que redondea el diagnóstico es que todos los exámenes de laboratorio son normales: no hay marcadores de inflamación elevados, la tiroides está bien y la bioquímica es normal. La fibromialgia es precisamente un síndrome de dolor generalizado con fatiga y sueño no reparador, en el que los análisis salen normales porque no hay una lesión inflamatoria ni orgánica que los altere; es un trastorno del procesamiento del dolor. La polimialgia reumática también da dolor en cinturas y hombros, pero es una enfermedad inflamatoria que cursa con la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva claramente elevadas, y aquí ambas son normales, lo que la descarta. El hipotiroidismo puede dar cansancio y molestias musculares, pero la TSH normal lo excluye. El síndrome de fatiga crónica comparte terreno con la fibromialgia, pero en él el síntoma que domina y define el cuadro es el agotamiento

incapacitante, mientras que en esta paciente el protagonista es el dolor musculoesquelético generalizado, que es el eje de la fibromialgia.

VILLAPEPA ENAM: Dolor musculoesquelético generalizado crónico + fatiga + sueño no reparador con laboratorio normal = fibromialgia (trastorno del procesamiento del dolor, sin marcadores alterados). La polimialgia reumática eleva la VSG y la PCR; el hipotiroidismo altera la TSH.

70. Varón de 55 años con diabetes tipo 2 y obesidad (IMC 32 kg/m²) no alcanza metas de HbA1c pese a cambios en el estilo de vida y metformina en dosis máximas. El médico decide añadir un agonista del receptor de GLP-1. El mecanismo farmacodinámico que contribuye de manera más directa al mejor control glucémico con este grupo de fármacos es la

- A. disminución de la secreción de glucagón, con reducción de la producción hepática de glucosa en presencia de hiperglicemia.
- B. estimulación de la reabsorción tubular de glucosa, con incremento leve compensatorio de la secreción de insulina basal.
- C. inhibición directa de la gluconeogénesis hepática independiente de los niveles de glucosa plasmática.
- D. activación de receptores adrenérgicos β_2 hepáticos, con incremento de la glucogenólisis y sensibilidad a la insulina

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Los agonistas del receptor de GLP-1 imitan a una hormona intestinal que el cuerpo libera cuando comemos, la incretina, y su efecto sobre la glucosa se apoya en dos brazos: por un lado aumentan la liberación de insulina, y por otro, el que la pregunta busca, frenan la secreción de glucagón. El glucagón es la hormona que le ordena al hígado fabricar y soltar glucosa; al bajar el glucagón, el hígado reduce su producción de glucosa y por eso cae la glucemia. Lo elegante y seguro de este mecanismo es que es dependiente de la glucosa: actúa cuando hay hiperglicemia y se atenúa cuando la glucosa está normal, lo que explica el bajo riesgo de hipoglucemia de estos fármacos. Por eso la respuesta correcta une la caída del glucagón con la menor producción hepática de glucosa en presencia de hiperglicemia. Estimular la reabsorción tubular de glucosa es lo contrario de lo que se quiere y describe mal el mecanismo; de hecho los fármacos que actúan en el riñón, los del otro grupo, bloquean esa reabsorción para eliminar glucosa por la orina. Inhibir la gluconeogénesis de forma independiente de la glucosa describe más bien a la metformina, y además pierde justamente la característica de dependencia de glucosa que define al GLP-1. Activar receptores beta dos hepáticos para aumentar la glucogenólisis subiría la glucosa, lo opuesto a un antidiabético, así que no tiene sentido.

VILLAPEPA ENAM: Los agonistas de GLP-1 mejoran la glucemia sobre todo suprimiendo el glucagón, lo que reduce la producción hepática de glucosa, y lo hacen de forma dependiente de la glucosa (bajo riesgo de hipoglucemia). Bloquear la reabsorción tubular de glucosa es de los SGLT2; inhibir la gluconeogénesis basal es de la metformina.

71. Según el marco de la OMS sobre determinantes sociales de la salud. ¿Cuál ejemplo corresponde principalmente a un determinante social estructural de la salud?

- A. Disponibilidad de establecimientos de salud, personal sanitario y esquemas de vacunación gratuitos
- B. Nivel de contaminación del aire, calidad del agua de consumo y exposición ocupacional a sustancias tóxicas
- C. Patrón de consumo de alimentos ultraprocesados y nivel de actividad física de las personas

D. Posición económica, género y pertenencia a un grupo étnico en una comunidad determinada

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El marco de la OMS separa dos niveles. Los determinantes estructurales son los que definen la posición de cada persona dentro de la jerarquía social, es decir dónde nace y se ubica en la escalera de la sociedad: su posición económica, su género y su pertenencia a un grupo étnico. Esos son los ejes que generan las desigualdades de fondo, y por eso la posición económica, el género y la etnia son el ejemplo de determinante estructural. Todo lo demás fluye a partir de ahí. Los otros ejemplos son determinantes intermediarios, los que median entre la posición social y la salud. La disponibilidad de servicios de salud y vacunación es el sistema sanitario, un intermediario que puede amortiguar o agravar las desigualdades, pero no es el eje estructural que las origina. La contaminación del aire, la calidad del agua y la exposición ocupacional son las condiciones materiales y ambientales en las que vive la gente, también intermediarias, consecuencia de la posición social más que su causa raíz. El patrón de alimentación y de actividad física son factores conductuales del individuo, el nivel más cercano a la persona, otro intermediario; la posición económica, el género y la etnia son la capa estructural que está por debajo condicionando a todas las demás.

VILLAPEPA ENAM: Los determinantes estructurales son los que fijan la posición en la jerarquía social: posición económica, género y etnia. El sistema de salud, las condiciones ambientales y las conductas son determinantes intermediarios, que median entre la posición social y la salud.

72. Mujer de 34 años, desde hace un año episodios de cefalea pulsátil en hemicráneo derecho, intensidad 8/10, de 4–24 horas de duración, que se agravan con la actividad física. Se acompañan de náuseas, vómitos y foto-fonofobia. Examen físico y neurológico normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Cefalea por abuso de analgésicos
- B. Cefalea tensional crónica
- C. Migraña en racimos
- D. Migraña sin aura

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Las características de la cefalea encajan casilla por casilla con la migraña. Es una cefalea pulsátil, de un solo lado de la cabeza, de intensidad fuerte, que dura entre unas horas y un día, que empeora con la actividad física y que se acompaña del cortejo típico de náuseas, vómitos y molestia tanto a la luz como al sonido. Ese conjunto de rasgos, dolor unilateral pulsátil con síntomas acompañantes y agravado por el movimiento, es la definición de la migraña, y como no hay síntomas neurológicos previos al dolor ni el examen muestra nada anormal, se trata de una migraña sin aura, la forma más común. La cefalea tensional es lo opuesto en carácter: es un dolor opresivo, como una banda que aprieta, habitualmente bilateral, de intensidad leve a moderada, que no pulsa, no empeora con la actividad ni se acompaña de ese cortejo de náuseas y fotofobia. La cefalea en racimos golpea sobre todo alrededor de un ojo, con crisis muy cortas y muy intensas que se repiten en salvas, junto con lagrimeo y congestión nasal del mismo lado, un patrón distinto al de estos episodios de horas con náuseas. La cefalea por abuso de analgésicos surge en quien toma medicación para el dolor de forma muy frecuente y se vuelve casi diaria; nada en el caso indica ese consumo excesivo, y el patrón episódico pulsátil con aura ausente define a la migraña sin aura.

VILLAPEPA ENAM: Cefalea pulsátil, unilateral, de horas de duración, que empeora con la actividad física y se

acompañía de náuseas y foto-fonofobia, sin aura previa = migraña sin aura. La tensional es opresiva y bilateral sin cortejo; la de racimos es periorbitaria, muy breve y con síntomas autonómicos.

73. Varón de 50 años es traído al servicio de emergencia tras accidente de tránsito. Examen: PA 75/60 mmHg, FC 120 x', FR 28 x', SO2 90%, pálido, desorientado, moviliza cuatro extremidades, pupilas isocóricas y reactivas, sangrado rutilante activo por herida penetrante en muslo derecho. Según la evaluación XABCDE del paciente politraumatizado, ¿Cuál debe ser la primera prioridad en su manejo?

- A. Reposición rápida con cristaloides balanceados IV
- B. Escala de Glasgow y colocación de collarín cervical
- C. Colocación de torniquete en muslo derecho
- D. Asegurar y mantener la vía aérea permeable

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La clave está en la letra que se antepone al ABCDE tradicional. La X del esquema XABCDE representa el control de la hemorragia exanguinante, es decir el sangrado masivo que puede desangrar al paciente en minutos, y por eso se coloca antes que la vía aérea. Este paciente tiene precisamente eso: un sangrado rutilante y activo por una herida en el muslo, rutilante porque es sangre arterial a presión, la que mata más rápido. Frente a una hemorragia arterial en una extremidad, la maniobra que salva la vida y va primero es cortar ese sangrado con un torniquete por encima de la herida. Por eso la primera prioridad es el torniquete, no lo que viene después. Reponer líquidos con cristaloides es parte de la reanimación del shock, pero llenar el tanque mientras sigue abierta la fuga es inútil: primero se cierra el grifo, luego se repone. Asegurar la vía aérea es la A del esquema y es prioritario en el trauma clásico, pero en este marco la hemorragia exanguinante se atiende antes que la vía aérea porque el paciente ventila y el sangrado arterial es la amenaza más inmediata. Calcular el Glasgow y poner el collarín pertenecen a pasos posteriores de la evaluación, la parte neurológica y la protección cervical, que no pueden anteponerse a detener una hemorragia que está vaciando al paciente.

VILLAPEPA ENAM: En el esquema XABCDE, la X (control de hemorragia exanguinante) va antes que la vía aérea. Con sangrado arterial rutilante activo en una extremidad, la primera prioridad es el torniquete: primero se cierra la fuga, después se reponen líquidos y se sigue con el ABCDE.

74. En un programa de tamizaje se identifica a una mujer de 45 años con hipertensión arterial mal controlada y enfermedad renal crónica estadio 4. Refiere cansancio progresivo y menor rendimiento laboral. El hemograma muestra Hb 9 g/dL, VCM 90 fL, leucocitos y plaquetas normales; ferritina y saturación de transferrina en rango normal; albúmina sérica y TSH normales. ¿Cuál es la explicación fisiopatológica más adecuada para estos hallazgos?

- A. Disminución del filtrado glomerular con pérdida de proteínas
- B. Uremia leve con hemólisis intravascular aguda produciendo anemia
- C. Disminución de la masa de nefronas con menor producción de eritropoyetina
- D. Hiperfosfatemia aislada en ERC estadio 4 que induce hipercalcemia

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El tipo de anemia y su contexto apuntan a un solo mecanismo. Es una anemia con glóbulos rojos de tamaño normal, sin alteración de las otras series, en una paciente con enfermedad renal crónica avanzada, y con las

reservas de hierro conservadas, la ferritina y la saturación de transferrina son normales. Descartado el hierro, la tiroides y la nutrición, lo que queda es el mecanismo propio del riñón enfermo. El riñón, además de filtrar, es la fábrica de la eritropoyetina, la hormona que ordena a la médula ósea producir glóbulos rojos. A medida que la enfermedad renal destruye nefronas, se pierde el tejido que fabrica esa hormona, cae la eritropoyetina y la médula produce menos hematíes, generando una anemia normocítica. Por eso la explicación correcta es la disminución de la masa de nefronas con menor producción de eritropoyetina. La caída del filtrado con pérdida de proteínas explicaría edema o hipoalbuminemia, pero la albúmina está normal y eso no causa esta anemia. La hemólisis intravascular aguda produciría signos de destrucción de glóbulos rojos y una anemia de instalación brusca, no este cuadro progresivo con reservas de hierro intactas. La hiperfosfatemia con hipercalcemia forma parte de los trastornos minerales de la enfermedad renal, pero no es el mecanismo de la anemia; el hilo que conecta enfermedad renal avanzada, anemia normocítica y hierro normal es el déficit de eritropoyetina.

VILLAPEPA ENAM: Anemia normocítica en enfermedad renal crónica avanzada con reservas de hierro normales = déficit de eritropoyetina por pérdida de masa de nefronas (el riñón fabrica la hormona que estimula la médula). No es pérdida de proteínas ni hemólisis; el hierro conservado lo confirma.

75. Anita, de 15 meses de edad, presenta cardiopatía congénita y desnutrición moderada; desde hace 3 días heces semilíquidas, 6 a 8 por día, de aproximadamente 10 a 20 ml cada vez, con moco. Hace 2 días se agrega rasgos sanguinolentos en las heces, dolor abdominal intermitente e hiporexia. Examen: despierta, conectada, hidratada; abdomen: globuloso, ruidos incrementados en frecuencia y tonalidad, depresible, no dolor. ¿Cuál es la conducta terapéutica recomendada?

- A. Coprocultivo e iniciar antibióticos
- B. Coprocultivo y esperar resultados
- C. Hemocultivo y esperar resultados
- D. Hemocultivo e iniciar antibióticos

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Lo que define la conducta es que se trata de una diarrea con moco y sangre, es decir una disentería, en una niña con dos factores de riesgo que la vuelven vulnerable: desnutrición moderada y una cardiopatía congénita. La disentería implica una invasión de la mucosa del intestino por bacterias, y en un niño con esos factores de riesgo no se puede simplemente esperar: la conducta es tomar un coprocultivo para identificar el germen y su sensibilidad, pero iniciar el antibiótico de inmediato de forma empírica sin aguardar el resultado, porque demorar el tratamiento en un desnutrido con cardiopatía aumenta el riesgo de complicaciones y de que la infección se disemine. El estudio que sirve es el coprocultivo, no el hemocultivo, porque la infección está en el intestino y es de las heces de donde se aísla el agente; el hemocultivo se reservaría para sospecha de bacteriemia o sepsis, que no es el foco aquí. Por eso las dos opciones que piden hemocultivo apuntan al examen equivocado. Y entre las dos que piden coprocultivo, esperar el resultado antes de tratar es lo que no corresponde en este perfil de riesgo: en una niña desnutrida con cardiopatía y disentería, se cultiva y se trata al mismo tiempo, no se pierde tiempo esperando.

VILLAPEPA ENAM: Diarrea con moco y sangre (disentería) en niña con desnutrición y cardiopatía = coprocultivo para identificar el germen MÁS inicio empírico inmediato de antibiótico, sin esperar el resultado. El estudio es de heces (coprocultivo), no de sangre; el riesgo del paciente obliga a no demorar.

76. Las células cancerosas suelen evadir la apoptosis, lo que contribuye a su proliferación descontrolada. ¿Cuál es el cambio molecular que se asocia de manera más directa con la pérdida de esta respuesta apoptótica ante el daño del ADN en estas células?

- A. Sobreexpresión de proteínas proapoptóticas de la familia BAX/BAK mitocondrial
- B. Activación constitutiva de caspasas efectoras en la vía intrínseca
- C. Disminución de la expresión de la proteína antiapoptótica BCL-2
- D. Pérdida de la función del gen supresor tumoral TP53

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La pregunta pide el cambio que más directamente hace que una célula, cuando su ADN se daña, ya no se autodestruya. El personaje central de esa decisión es el gen supresor de tumores TP53, que fabrica la proteína p53, conocida como el guardián del genoma. Cuando el ADN sufre un daño importante, la p53 detiene el ciclo para intentar reparar y, si el daño es irreparable, ordena a la célula suicidarse por apoptosis para que no se propague una célula con mutaciones peligrosas. Si el TP53 pierde su función, ese guardián desaparece: la célula dañada ya no recibe la orden de morir, sobrevive con su ADN alterado y prolifera sin control. Por eso la pérdida de función de TP53 es el cambio más directamente ligado a la evasión de la apoptosis ante el daño del ADN, y es la mutación más frecuente en los cánceres humanos. Las otras opciones describen cambios que, si ocurrieran, favorecerían la muerte celular, es decir lo contrario de evadirla. Sobreexpresar las proteínas que abren el poro mitocondrial y disparan la apoptosis empujaría a la célula a morir, no a sobrevivir. Activar de forma constitutiva las caspasas ejecutoras también ejecutaría la apoptosis. Y disminuir una proteína que protege de la muerte celular dejaría a la célula más propensa a apoptar; la evasión, al revés, se logra perdiendo el gatillo que es el TP53.

VILLAPEPA ENAM: El cambio que más directamente permite evadir la apoptosis ante daño del ADN es la pérdida de función de TP53 (la p53, guardián del genoma, que ordena el suicidio de la célula dañada). Es la mutación más frecuente en cáncer; las otras opciones favorecerían la muerte celular, no su evasión.

77. Varón de 80 años con EPOC severo y cardiopatía isquémica, hospitalizado en UCI por choque séptico, requiere infusión de vasopresores. Ingresó por emergencia hace 2 días por fiebre, dolor en hipocondrio derecho y leucocitosis. Ecografía: engrosamiento de pared vesicular y líquido peri vesicular compatible con colecistitis aguda alitiásica. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- A. Colecistectomía laparoscópica inmediata
- B. Indicar solamente antibióticos intravenosos
- C. Colecistectomía abierta de urgencia
- D. Colecistostomía percutánea guiada por imagen

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que cruzar la enfermedad con el estado del paciente. Tiene una colecistitis aguda que necesita ser drenada, pero se trata de un anciano de ochenta años con enfermedad pulmonar severa y cardiopatía isquémica que, además, está en shock séptico dependiente de vasopresores. Ese es un paciente demasiado inestable para tolerar una cirugía y una anestesia general: llevarlo al quirófano en esas condiciones tiene un riesgo altísimo de que muera en la mesa. La solución es descomprimir la vesícula infectada sin operar, y eso se logra con una colecistostomía percutánea, un catéter que se introduce a través de la piel bajo guía de imagen y drena la vesícula, controlando la infección y ganando tiempo hasta que el paciente mejore y, eventualmente, se pueda operar de forma programada. Por eso el drenaje percutáneo es la conducta. La colecistectomía laparoscópica inmediata sería lo ideal en un paciente estable, pero en este enfermo crítico con vasopresores es temeraria. La colecistectomía abierta de urgencia es aún más agresiva, con mayor trauma quirúrgico, absolutamente desaconsejada en alguien tan frágil. Y limitarse solo a antibióticos intravenosos deja sin drenar la colección

infectada: en una colecistitis establecida los antibióticos por sí solos suelen no controlar el foco, que necesita ser evacuado; por eso, cuando la cirugía no es posible, el drenaje percutáneo es el que resuelve.

VILLAPEPA ENAM: Colecistitis aguda alitiásica en anciano crítico, séptico y con vasopresores (riesgo quirúrgico prohibitivo) = colecistostomía percutánea guiada por imagen para drenar sin operar. La colecistectomía es temeraria en el inestable, y solo antibióticos no drena el foco infectado.

78. Neonato de 26 semanas de gestación y 800 gramos de peso, presenta hipoactividad, palidez súbita, caída brusca del hematocrito y fontanela anterior abombada. Se solicita una ecografía transfontanelar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Leucomalacia periventricular
- B. Hidrocefalia congénita
- C. Meningitis bacteriana
- D. Hemorragia Intraventricular

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El escenario es el de un prematuro extremo, de veintiséis semanas y apenas ochocientos gramos, y en ese grupo hay una catástrofe característica: la hemorragia intraventricular. Ocurre porque el cerebro del prematuro tiene una zona muy vascularizada y frágil, la matriz germinal, con vasos inmaduros que se rompen con facilidad ante cambios de presión o flujo. Los signos del caso son los del sangrado agudo dentro del cerebro: la palidez súbita y la caída brusca del hematocrito reflejan que se perdió sangre hacia los ventrículos, la hipoactividad muestra el deterioro neurológico, y la fontanela abombada indica que la presión dentro del cráneo subió por la sangre acumulada. Que se pida una ecografía a través de la fontanela confirma el razonamiento, porque es justo el estudio que diagnostica la hemorragia intraventricular a la cabecera del prematuro. La leucomalacia periventricular es otra lesión del prematuro, pero es un daño isquémico de la sustancia blanca que evoluciona de forma silenciosa y se manifiesta después con secuelas motoras, no con este cuadro agudo de palidez y caída del hematocrito. La hidrocefalia congénita agranda la cabeza de forma progresiva, no produce una descompensación brusca con anemia aguda. La meningitis bacteriana daría fiebre e inestabilidad con signos de infección, pero no explica la caída súbita del hematocrito, que es el sello de un sangrado; el conjunto de anemia aguda más fontanela abombada en un prematuro extremo es la hemorragia intraventricular.

VILLAPEPA ENAM: Prematuro extremo + palidez súbita + caída brusca del hematocrito + fontanela abombada = hemorragia intraventricular por rotura de la frágil matriz germinal, confirmable con ecografía transfontanelar. La leucomalacia es isquémica y silenciosa; la anemia aguda es el sello del sangrado.

79. Varón de 45 años, sin comorbilidades conocidas, presenta tos productiva con expectoración fétida, fiebre y pérdida de peso de 3 meses de evolución. Ha recibido ATB empíricos por vía endovenosa durante más de 3 semanas, sin mejoría clínica. Examen: MV disminuido en base del HTD. TC de tórax: cavidad de paredes engrosadas con nivel hidroaéreo en el lóbulo inferior derecho. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- A. Iniciar drenaje pleural con tubo de tórax para evacuación de la cavidad
- B. Continuar solo con antibióticos de amplio espectro por 4 semanas adicionales
- C. Programar broncoscopia diagnóstica sin modificar el manejo terapéutico actual
- D. Lobectomía inferior derecha por absceso pulmonar crónico refractario a manejo médico

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El cuadro es un absceso pulmonar, con la cavidad de paredes gruesas y nivel hidroaéreo, y la expectoración fétida que delata gérmenes anaerobios. La mayoría de estos abscesos curan solo con antibióticos, así que cuando uno no responde tras varias semanas de tratamiento adecuado hay que preguntarse por qué, y la respuesta más peligrosa que no se puede pasar por alto es que exista algo tapando el bronquio que impide drenar la cavidad, como un tumor endobronquial o un cuerpo extraño. En un varón de mediana edad con un absceso refractario, descartar un carcinoma que obstruye es obligatorio. Por eso la conducta es programar una broncoscopia, que permite mirar directamente el árbol bronquial, tomar biopsias y cultivos, y además ayudar al drenaje. La broncoscopia es el paso diagnóstico que falta antes de escalar a cualquier cirugía. Poner un tubo de drenaje pleural sería un error de concepto, porque la colección está dentro del pulmón, en el parénquima, no en la pleura; ese tubo es para el empiema o el neumotórax, no para un absceso intrapulmonar. Seguir solamente con más antibióticos cuatro semanas más es insistir en lo que ya fracasó sin investigar la causa del fracaso. Y saltar directo a la lobectomía es prematuro y desproporcionado: la cirugía se reserva para cuando se agotó el manejo y se descartó todo, y aquí todavía falta el estudio broncoscópico que puede revelar la razón de que no cure.

VILLAPEPA ENAM: Absceso pulmonar que no responde a semanas de antibiótico adecuado = broncoscopia para descartar obstrucción endobronquial o tumor que impida el drenaje, antes de escalar a cirugía. El tubo pleural es para colecciones de la pleura, no del parénquima; la lobectomía es el último recurso.

80. Varón de 40 años, 10 años de criador de palomas, desde hace 3 meses tos seca, disnea de esfuerzo progresiva y pérdida de peso de 4 kg. Examen: crepitantes finos bibasales, SO_2 91 % al aire ambiente. Espirometría: patrón restrictivo moderado con disminución de la capacidad de difusión de CO. TC pulmones: vidrio esmerilado en parches, nódulos centrolobulillares mal definidos y patrón en mosaico de atenuación a predominio en lóbulos superiores. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado?

- A. Corticoide inhalado en dosis alta
- B. Prednisona oral con reducción progresiva
- C. Antagonista de leucotrienos
- D. Metilprednisolona intravenosa en pulsos

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El diagnóstico es una neumonitis por hipersensibilidad, la enfermedad del pulmón del criador de aves. La exposición durante años a las proteínas de las palomas desató una reacción inmunológica en el pulmón, y el cuadro lo refleja: tos seca y disnea progresiva, crepitantes finos, un patrón restrictivo con caída de la capacidad de difusión, que indica compromiso del intersticio, y en la tomografía el vidrio esmerilado con nódulos centrolobulillares y el patrón en mosaico, hallazgos típicos de esta enfermedad. El tratamiento tiene dos pilares: retirar la exposición al antígeno, alejarlo de las palomas, y calmar la inflamación pulmonar con corticoides por vía sistémica. El corticoide de elección para esto es la prednisona oral, iniciada a una dosis eficaz y luego reducida de forma progresiva a medida que el pulmón mejora. Por eso es la respuesta. El corticoide inhalado deposita el fármaco en las vías aéreas y es el tratamiento del asma, pero no alcanza ni controla bien la inflamación difusa del intersticio pulmonar de esta enfermedad. El antagonista de leucotrienos también es un fármaco de la vía del asma y las alergias respiratorias altas, sin papel en el tratamiento de la neumonitis por hipersensibilidad. Los pulsos de metilprednisolona intravenosa se reservan para las formas fulminantes o muy graves que amenazan la vida de inmediato; para este cuadro subagudo, moderado, el estándar es la prednisona oral con descenso gradual, no la vía intravenosa en pulsos.

VILLAPEPA ENAM: Criador de aves + enfermedad intersticial (restrictivo, difusión baja, vidrio esmerilado y nódulos centrolobulillares) = neumonitis por hipersensibilidad. El tratamiento es retirar la exposición más prednisona oral con descenso progresivo; el corticoide inhalado y los antileucotrienos son del asma.

81. Mujer de 22 años, octavo día postoperatorio de apendicectomía convencional por apendicitis aguda purulenta. Estuvo hospitalizada 2 días y recibió antibióticos intravenosos. Consulta por dolor, enrojecimiento y aumento de volumen en la herida operatoria, sensación febril y náuseas. Examen: herida con bordes aproximados, tensa, eritematosa, al retirar algunos puntos secreción purulenta maloliente limitada a la incisión, no dolor abdominal difuso ni signos de irritación peritoneal. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- A. Tomografía abdominal para buscar colecciones intrabdominales
- B. Mantener la herida cerrada y dar antibióticos por 48 horas
- C. Preparar para laparoscopia diagnóstica para ver el lecho apendicular
- D. Retirar puntos de la herida, tomar cultivo y ATB cobertura amplia

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El cuadro está claramente localizado en la pared: es una infección del sitio quirúrgico. La herida está tensa, roja, y al retirar unos puntos sale pus maloliente confinado a la incisión, mientras que el abdomen no duele de forma difusa y no hay signos de irritación peritoneal, lo que indica que el problema está en la herida y no dentro del vientre. Ante una colección de pus, el principio quirúrgico es inamovible: donde hay pus, hay que drenarlo. Por eso la conducta inicial es abrir la herida retirando los puntos para que salga la secreción, tomar un cultivo del material para dirigir el antibiótico, y dar cobertura antibiótica de amplio espectro. Drenar es lo que resuelve; los antibióticos solos no vacían una colección. Pedir una tomografía abdominal en busca de colecciones dentro del abdomen no corresponde, porque no hay ningún signo de infección intraperitoneal: el abdomen está blando y sin irritación, todo apunta a la pared. Mantener la herida cerrada y solo dar antibióticos es justamente el error de no drenar el pus, que quedaría atrapado empeorando la infección. Preparar una laparoscopia para revisar el lecho apendicular es una intervención mayor e injustificada para una infección superficial de la herida; sería llevar al quirófano un problema que se resuelve abriendo y drenando la incisión en la cama.

VILLAPEPA ENAM: Secreción purulenta limitada a la incisión, con abdomen blando y sin irritación peritoneal = infección del sitio quirúrgico. La conducta es abrir la herida (retirar puntos), drenar el pus, cultivar y dar antibióticos. Los antibióticos solos no drenan una colección; no hace falta imagen abdominal ni reoperar.

82. Varón de 65 años con diabetes tipo 2 en tratamiento con metformina, presenta dolor en flanco derecho y hematuria. Se sospecha tumor renal y se programa TC con contraste yodado. Evaluación: PA 130/80 mmHg, FGe 40 mL/min/1,73 m², hidratado. ¿Cuál es la estrategia más adecuada para minimizar el riesgo asociado al contraste?

- A. Iniciar diuréticos IV y restringir líquidos para aumentar la eliminación del contraste
- B. Suspender metformina y solución salina IV antes y después de la TC
- C. Administrar N-acetilcisteína a dosis 1.200mg por vía oral antes y después del procedimiento
- D. Hemodiálisis profiláctica después del procedimiento

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay dos riesgos que atender en este paciente al que le van a poner contraste yodado. El primero es la nefropatía por contraste, más probable porque su función renal ya está reducida; y la medida que de verdad la previene es una buena hidratación con suero salino por vía intravenosa antes y después del estudio, que mantiene el flujo renal y diluye el contraste. El segundo riesgo es propio de la combinación de metformina con un riñón que puede empeorar tras el contraste: si la función renal cae, la metformina se acumula y puede desencadenar una acidosis láctica; por eso se suspende la metformina alrededor del procedimiento. La respuesta que junta ambas cosas, suspender metformina más hidratación salina, es la correcta. Dar diuréticos y restringir líquidos es exactamente lo contrario de lo que protege: forzar diuresis y deshidratar reduce el flujo renal y aumenta el daño por contraste. La N-acetilcisteína se usó durante años con esta intención, pero la evidencia acumulada mostró que no previene la nefropatía por contraste, así que ya no se recomienda como estrategia. La hemodiálisis profiláctica después del estudio no protege el riñón y expone al paciente a los riesgos de un procedimiento invasivo innecesario; la clave es hidratar y suspender la metformina, no dializar.

VILLAPEPA ENAM: Para minimizar el riesgo del contraste yodado en un diabético con función renal reducida en metformina: hidratación con salina intravenosa antes y después MÁS suspender la metformina (riesgo de acidosis láctica si cae la función renal). La N-acetilcisteína ya no se recomienda y forzar diuresis empeora el daño.

83. Un niño de 6 años, procedente de zona urbana de la costa norte, presenta 24 horas de fiebre y malestar general. La madre refiere que hace dos días notó una "picadura" en el abdomen que ha aumentado de tamaño y ahora muestra una placa violácea con área central negruzca y flictenas hemorrágicas. En la emergencia se constata palidez, orina rojiza y hemoglobina de 8 g/dL (previa 12 g/dL hace 3 meses), con bilirrubina indirecta elevada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Escorpionismo
- B. Loxoscelismo
- C. Latroductismo
- D. Tarantulismo

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La lesión de la piel y el compromiso de la sangre juntos apuntan a una sola araña. En el sitio de la picadura se formó una placa violácea con el centro negro y ampollas de sangre, que es la lesión necrótica característica de la mordedura de la araña *Loxosceles*, la araña de los rincones o casera. Pero el caso no se queda en la piel: hay palidez, orina rojiza, la hemoglobina cayó a la mitad y la bilirrubina indirecta subió, es decir se está destruyendo la sangre. Esa combinación de una lesión cutánea necrótica más hemólisis intravascular es la forma grave de la enfermedad, el loxoscelismo cutáneo-visceral, en el que el veneno no solo mata la piel sino que rompe los glóbulos rojos y puede dañar el riñón. El latroductismo, causado por la viuda negra, produce un cuadro completamente distinto: dolor intenso, calambres y rigidez muscular por acción sobre el sistema nervioso, sin la lesión necrótica de la piel ni la hemólisis. El escorpionismo genera un síndrome de excitación autonómica con sudoración, salivación y afectación cardíaca o pancreática, tampoco la placa necrótica con destrucción de sangre. El tarantulismo es de escasa relevancia clínica y no produce ni la necrosis cutánea ni la hemólisis; la dupla necrosis local más hemólisis es la firma del loxoscelismo.

VILLAPEPA ENAM: Picadura con placa violácea, centro necrótico negruzco y flictenas hemorrágicas + hemólisis (orina rojiza, caída de hemoglobina, bilirrubina indirecta alta) = loxoscelismo cutáneo-visceral (araña *Loxosceles*). El latroductismo da síndrome muscular sin necrosis; el escorpionismo, excitación autonómica.

84. Mujer de 22 años, con antecedente de depresión mayor, acude a emergencia 1 hora después de ingerir aproximadamente 20 tabletas de paracetamol de 500 mg con intención suicida. Se encuentra consciente, asintomática y hemodinamia estable. Mientras se esperan los resultados de laboratorio.

¿Cuál es la acción terapéutica de elección?

- A. Programar hemodiálisis de urgencia
- B. Iniciar de inmediato N-acetilcisteína IV
- C. Indicar observación clínica estricta
- D. Realizar lavado gástrico e inducir el vómito

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Lo que decide la conducta es la cantidad ingerida y el antídoto disponible. Veinte tabletas de quinientos miligramos son diez gramos de paracetamol, una dosis dentro del rango tóxico capaz de producir una lesión grave del hígado. El punto engañoso del cuadro es que la paciente está asintomática, pero eso es normal en las primeras horas: el daño hepático del paracetamol es silencioso al inicio y se manifiesta días después, cuando ya puede ser irreversible. El antídoto es la N-acetilcisteína, que repone el compuesto que el hígado necesita para neutralizar el metabolito tóxico, y su gran ventaja es que es más eficaz cuanto antes se administra y es muy segura. Por eso, ante una ingesta de dosis tóxica confirmada por la historia, lo correcto es iniciar la N-acetilcisteína sin esperar a que aparezcan síntomas ni a que el hígado ya esté dañado. La observación clínica estricta es insuficiente y peligrosa: esperar a ver qué pasa desperdicia la ventana en la que el antídoto realmente protege. La hemodiálisis de urgencia no es el tratamiento de elección de la intoxicación por paracetamol; el manejo es el antídoto, no depurar por diálisis. El lavado gástrico y la inducción del vómito prácticamente ya no se recomiendan por su escaso beneficio y el riesgo de aspiración, y de todos modos no sustituyen a la N-acetilcisteína, que es la que evita la falla hepática.

VILLAPEPA ENAM: Ingesta de dosis tóxica de paracetamol (10 g) = iniciar N-acetilcisteína de inmediato, sin esperar que aparezcan síntomas, porque el daño hepático es silencioso al inicio y el antídoto es más eficaz cuanto más temprano se da. La observación sola es peligrosa y el lavado gástrico ya no se recomienda.

85. Según norma técnica de salud, ¿Cuál es la categoría mínima de establecimiento que está autorizada para brindar atención con camas de internamiento general para pacientes?

- A. I-2
- B. II-1
- C. I-4
- D. I-3

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La clave está en las palabras internamiento general. En la categorización de los establecimientos de salud, todo el primer nivel de atención, desde el puesto de salud más básico hasta el centro de salud más completo, está orientado a la atención ambulatoria y a acciones de promoción, prevención y recuperación de baja complejidad. Aun cuando algunos establecimientos del primer nivel disponen de camas para observación o para la atención del parto, no brindan hospitalización general de pacientes. El internamiento general, es decir la hospitalización de pacientes en camas para el manejo de diversas patologías, comienza en el segundo nivel de atención, cuya categoría de entrada es la II-1, el hospital de atención general. Por eso la categoría mínima autorizada para internamiento general es la II-1. Las categorías del primer nivel, el I-2, el I-3 y el I-4, pertenecen todas a ese

primer nivel ambulatorio: el I-2 es un puesto con médico, el I-3 un centro de salud sin internamiento y el I-4 un centro de salud que puede tener algunas camas para funciones específicas, pero ninguno de ellos alcanza la hospitalización general de pacientes que define al hospital del segundo nivel.

VILLAPEPA ENAM: La hospitalización o internamiento general de pacientes comienza en el segundo nivel de atención, cuya categoría mínima es II-1 (hospital de atención general). El primer nivel (I-1 a I-4) es ambulatorio; aunque el I-4 tenga algunas camas, no brinda internamiento general.

86. Mujer de 35 años, primigesta de 12 semanas, acude a su primer control prenatal. Ecografía del primer trimestre: translucencia nuchal por encima del percentil 95 para la edad gestacional. Este hallazgo principalmente indica un incremento del riesgo de:

- A. Restricción del crecimiento fetal
- B. Defectos del tubo neural
- C. Preeclampsia de inicio precoz
- D. Cromosomopatía fetal

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La translucencia nuchal es la medición del pequeño acúmulo de líquido bajo la piel de la nuca del feto en el primer trimestre, y es uno de los marcadores más útiles del tamizaje ecográfico temprano. Cuando ese espacio está aumentado, por encima del percentil noventa y cinco para la edad gestacional, lo que principalmente señala es un mayor riesgo de que el feto tenga una alteración de los cromosomas, sobre todo la trisomía veintiuno o síndrome de Down, pero también otras trisomías. Por eso el hallazgo de una translucencia nuchal gruesa se interpreta como un incremento del riesgo de cromosomopatía fetal, y obliga a ofrecer pruebas de confirmación. Los defectos del tubo neural, como la espina bífida, se rastrean con otros métodos, como la alfafetoproteína en sangre materna y la ecografía de la columna y el cráneo en el segundo trimestre, no con la translucencia nuchal. La restricción del crecimiento fetal y la preeclampsia de inicio precoz se predicen con otros marcadores, como el estudio Doppler de las arterias uterinas y factores placentarios, no con el grosor de la nuca en el primer trimestre; el aumento de la translucencia nuchal apunta específicamente a las anomalías cromosómicas.

VILLAPEPA ENAM: Translucencia nuchal aumentada (por encima del percentil 95) en el primer trimestre = mayor riesgo de cromosomopatía fetal, sobre todo trisomía 21. Los defectos del tubo neural se tamizan con alfafetoproteína y ecografía del segundo trimestre, no con la translucencia nuchal.

87. Neonato de 15 días de vida, nacido a las 42 semanas de gestación y alimentado con lactancia materna exclusiva, persiste icterico desde el tercer día de vida. Examen: presenta hernia umbilical, tono muscular disminuido y una fontanela anterior grande. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Galactosemia
- B. Enfermedad de Gilbert
- C. Atresia de vías biliares
- D. Hipotiroidismo congénito

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Los signos, tomados en conjunto, dibujan un hipotiroidismo congénito. Hay una ictericia que se prolonga más allá de lo esperado, y a eso se suman tres hallazgos muy sugerentes: una hernia umbilical, el tono muscular disminuido y una fontanela anterior grande. Cada uno de esos rasgos es típico del recién nacido con déficit de hormona tiroidea, porque esa hormona es esencial para el tono muscular, el cierre de la fontanela y el metabolismo de la bilirrubina; su falta enlentece todo y prolonga la ictericia. Por eso el conjunto de ictericia persistente con hernia umbilical, hipotonía y fontanela amplia es el retrato clásico, y justifica el tamizaje neonatal que busca precisamente esta enfermedad para tratarla antes de que dañe el cerebro. La galactosemia también da ictericia, pero se acompaña de vómitos, rechazo del alimento, agrandamiento del hígado y a menudo un cuadro grave tipo sepsis al iniciar la leche, nada de lo cual figura aquí. La enfermedad de Gilbert es un trastorno leve y benigno del metabolismo de la bilirrubina que no produce hernia umbilical, hipotonía ni fontanela grande. La atresia de vías biliares causa ictericia por obstrucción, con bilirrubina directa elevada, orina oscura y heces pálidas, un patrón obstructivo distinto que tampoco explica los signos de hipotonía y fontanela amplia que apuntan al hipotiroidismo.

VILLAPEPA ENAM: Ictericia prolongada + hernia umbilical + hipotonía + fontanela anterior grande en un neonato = hipotiroidismo congénito (el déficit de hormona tiroidea enlentece el metabolismo de la bilirrubina y el tono). Es lo que busca el tamizaje neonatal; la atresia biliar da patrón obstructivo con bilirrubina directa.

88. Escolar de 8 años. Hace una semana presentó fiebre de 39°C durante 2 días con posterior aparición de exantema máculo pápulo pruriginoso con algunas lesiones vesiculares y costrosas. Examen: placa eritematosa, sobreelevada y dolorosa al tacto, en parte superior de hemitórax derecho. ¿Cuál es la enfermedad de fondo y la complicación que sufre el paciente?

- A. Rubéola-Empiema
- B. Exantema súbito-Estreptodermia
- C. Sarampión-Urticaria
- D. Varicela-Celulitis

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Primero hay que identificar la enfermedad de base por el tipo de exantema. Un brote que empieza tras fiebre y muestra al mismo tiempo máculas, pápulas, vesículas y costras, es decir lesiones en distintas etapas de evolución conviviendo, y que además pica, es el patrón inconfundible de la varicela, donde las lesiones aparecen en oleadas y por eso se ven en todos los estadios a la vez. Sobre ese fondo aparece la complicación: una placa roja, sobreelevada y dolorosa al tacto en el tórax. Esa lesión localizada, caliente y dolorosa, es una infección bacteriana de la piel que se metió por las lesiones de varicela al rascarse, es decir una celulitis, que es justamente la complicación más frecuente de la varicela. Por eso la respuesta es varicela con celulitis. La rubéola da un exantema tenue y uniforme con ganglios detrás de las orejas, no lesiones en distintos estadios ni vesículas, y el empiema es una colección de pus en la pleura que no corresponde a una placa cutánea. El exantema súbito afecta a lactantes pequeños con fiebre alta que cede y luego brota el exantema, no encaja con un escolar y con vesículas y costras. El sarampión produce un exantema que desciende de la cara hacia el cuerpo con manchas de Koplik en la boca, sin el patrón vesicular en distintos estadios de la varicela, y la urticaria son ronchas fugaces que pican pero no son una placa infecciosa dolorosa; el binomio varicela más celulitis es el que cuadra.

VILLAPEPA ENAM: Exantema con lesiones en distintos estadios a la vez (máculas, pápulas, vesículas y costras) y prurito = varicela. La placa roja, sobreelevada y dolorosa sobre ese fondo = celulitis por sobreinfección bacteriana de las lesiones rascadas, la complicación más frecuente de la varicela.

89. Varón de 16 años, desde hace una semana presenta edema palpebral y en miembros inferiores. Laboratorio: proteinuria en rango nefrótico (albuminuria masiva) con función renal conservada y sin hematuria significativa. En la biopsia renal, ¿Qué estructura del glomérulo se encontrará predominantemente dañada y explica mejor la albuminuria masiva?

- A. Membrana basal de la cápsula parietal de Bowman
- B. Endotelio fenestrado de los capilares glomerulares
- C. Podocitos de la capa visceral de la cápsula de Bowman
- D. Células mesangiales y matriz mesangial del glomérulo

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El cuadro es un síndrome nefrótico en un adolescente: edema y una pérdida masiva de albúmina por la orina, con la función renal intacta y sin sangre en la orina. Ese perfil, sobre todo a esta edad, corresponde a la enfermedad de cambios mínimos, y la pregunta pide la estructura del filtro glomerular que está dañada. La barrera que impide que las proteínas se escapen a la orina tiene varias capas, y la más importante para retener la albúmina son los podocitos, las células de la capa visceral de la cápsula de Bowman que envuelven los capilares con sus prolongaciones, dejando entre ellas unas rendijas finísimas que dejan pasar el agua pero no las proteínas grandes. En la enfermedad de cambios mínimos esos podocitos se lesionan y sus prolongaciones se aplanan y fusionan, se borran las rendijas de filtración, y entonces la albúmina se cuela masivamente; por eso el daño predominante está en los podocitos. La membrana basal de la cápsula parietal no es la barrera de filtración, es solo el revestimiento externo de la cápsula, y no explica la proteinuria. El endotelio fenestrado es la capa más interna de la pared capilar, con poros grandes que dejan pasar el plasma; su daño se asocia más a cuadros con sangre en la orina, no a la proteinuria pura. El mesangio es el tejido de sostén entre los capilares y su alteración produce otros patrones glomerulares, no la albuminuria masiva y aislada de este caso, que se explica por la lesión de los podocitos.

VILLAPEPA ENAM: Síndrome nefrótico con proteinuria masiva, función conservada y sin hematuria en adolescente = enfermedad de cambios mínimos, con daño predominante de los podocitos (capa visceral de Bowman), cuya fusión de prolongaciones borra las rendijas de filtración y deja escapar la albúmina.

90. En un centro de salud de primer nivel se recibe a un varón de 65 años en paro cardio respiratorio. Solo se dispone de un resucitador manual (AMBU), oxígeno y un desfibrilador externo automático (DEA). No hay personal adicional entrenado en ACLS. Considerando las recomendaciones de las guías internacionales de RCP adaptables a contextos de recursos limitados. ¿Cuál es la secuencia inicial de actuación más adecuada para optimizar la supervivencia neurológica?

- A. Iniciar compresiones torácicas de alta calidad, aplicar DEA apenas esté disponible, detener compresiones para analizar el ritmo, reiniciando compresiones tras cada descarga o análisis
- B. Administrar oxígeno con mascarilla simple mientras se prepara el resucitador manual y se consigue un acceso venoso periférico para administrar adrenalina precozmente
- C. Trasladar al paciente al establecimiento de referencia más cercano, iniciando compresiones durante el traslado en la ambulancia para no retrasar la derivación
- D. Conectar primero el DEA al paciente hasta completar el análisis del ritmo y la primera descarga si está indicada, luego brindar compresiones.

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Lo que más salva neuronas en un paro cardíaco es mantener el cerebro perfundido, y eso se logra con compresiones torácicas de alta calidad iniciadas de inmediato y con las mínimas interrupciones posibles. Por eso la secuencia correcta empieza por comprimir el tórax ya, sin demora, y en cuanto el desfibrilador esté disponible se coloca y se usa: se detienen las compresiones solo el instante justo para que analice el ritmo y dé la descarga si está indicada, y enseguida se reanudan las compresiones tras cada análisis o descarga. Esa coreografía, compresiones continuas con el desfibrilador integrado y pausas brevísimas, es la que da la mejor supervivencia neurológica. Empezar por dar oxígeno con mascarilla y perder tiempo consiguiendo un acceso venoso para adrenalina antepone medidas secundarias a lo esencial: la circulación se mantiene comprimiendo, no ventilando ni buscando una vena primero. Trasladar al paciente de inmediato mientras se hacen compresiones en una ambulancia en movimiento sacrifica la calidad de esas compresiones, que se vuelven ineficaces con el vehículo en marcha; primero se reanima bien en el sitio. Conectar el desfibrilador y esperar a completar todo su análisis y una descarga antes de comprimir retrasa el inicio de las compresiones, que deben empezar de una vez mientras el aparato se prepara; lo primero es comprimir, y el desfibrilador se suma apenas llega.

VILLAPEPA ENAM: En el paro cardíaco, lo que más protege el cerebro son las compresiones torácicas de alta calidad iniciadas de inmediato con mínimas interrupciones, sumando el desfibrilador apenas esté disponible. No se antepone oxígeno ni el acceso venoso para adrenalina, ni se retrasan las compresiones esperando el análisis del desfibrilador.

91. Gestante de 24 años, sin controles prenatales previos, acudió a las 28 semanas, donde se realizó ecografía obstétrica encontrándose alteraciones óseas metafisarias y engrosamiento de la placenta. Refirió antecedente de úlcera genital indolora 8 meses antes, que no recibió tratamiento. En el control del recién nacido, al mes, se diagnostica hipoacusia neurosensorial, hepatomegalia y nariz en silla de montar. ¿Cuál es la etiología más probable de este cuadro?

- A. Citomegalovirus
- B. Virus de la rubéola
- C. *Treponema pallidum*
- D. *Toxoplasma gondii*

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El dato que abre el caso es el antecedente materno: una úlcera genital indolora hace ocho meses que no se trató. Una úlcera genital que no duele es el chancro, la lesión de la sífilis primaria, causada por el *Treponema pallidum*, y al no recibir tratamiento la infección siguió su curso y se transmitió al feto. Todo lo demás encaja con sífilis congénita: en la ecografía, las alteraciones de las metafisis de los huesos y el engrosamiento de la placenta; y en el recién nacido, los estigmas tan característicos de la sífilis congénita, con hipoacusia neurosensorial, junto con la hepatomegalia y la nariz en silla de montar por el daño del cartílago nasal. Ese conjunto, chancro materno no tratado más lesiones óseas, hepáticas, sordera y nariz deformada, es el retrato de la sífilis congénita por *Treponema pallidum*. El citomegalovirus produce microcefalia, calcificaciones cerebrales y sordera, pero no la úlcera genital indolora previa ni la nariz en silla de montar. La rubéola congénita da cardiopatía, cataratas y sordera, tampoco con el antecedente de chancro. La toxoplasmosis cursa con la tríada de hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis, un patrón distinto; el hilo del chancro indoloro no tratado apunta inequívocamente al *treponema*.

VILLAPEPA ENAM: Úlcera genital indolora materna no tratada (chancro) + alteraciones óseas metafisarias + hepatomegalia + hipoacusia + nariz en silla de montar en el neonato = sífilis congénita por *Treponema pallidum*. El citomegalovirus da calcificaciones cerebrales y la toxoplasmosis, coriorretinitis con hidrocefalia.

92. Varón de 50 años presenta hipertrigliceridemia persistente a pesar de 6 meses de adherencia a cambios de estilos de vida, dieta y actividad física. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- A. Ezetimiba
- B. Atorvastatina
- C. Ácido bempedoico
- D. Fenofibrato

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Lo importante es qué grasa de la sangre está elevada, porque cada fármaco tiene su blanco. Aquí el problema son los triglicéridos altos que no bajaron pese a seis meses de dieta y ejercicio bien hechos. El grupo de medicamentos que baja específica y más potentemente los triglicéridos son los fibratos, y el de elección es el fenofibrato, que activa una vía metabólica que acelera la eliminación de los triglicéridos del plasma. Por eso es la respuesta cuando el objetivo es controlar la hipertrigliceridemia. Las otras tres opciones son fármacos dirigidos a bajar el colesterol malo, el LDL, no los triglicéridos. La atorvastatina es una estatina, la piedra angular para reducir el LDL, con efecto solo modesto sobre los triglicéridos, así que no es la elección cuando el problema aislado son estos. La ezetimiba bloquea la absorción intestinal de colesterol y se usa para bajar el LDL, sin acción relevante sobre los triglicéridos. El ácido bempedoico también actúa sobre la síntesis de colesterol para reducir el LDL, otra herramienta del mismo objetivo; ninguno de esos tres ataca el trastorno de este paciente, que es la hipertrigliceridemia, y para eso el fármaco es el fibrato.

VILLAPEPA ENAM: Hipertrigliceridemia persistente pese a estilo de vida = fibrato (fenofibrato), que es el fármaco que más baja los triglicéridos. Las estatinas, la ezetimiba y el ácido bempedoico están dirigidos a reducir el colesterol LDL, no los triglicéridos.

93. Niño de 2 años es llevado a consulta porque los padres notan que "camina con los pies planos". Embarazo y parto sin complicaciones. Examen: marcha normal, sin dolor ni limitación funcional; pies planos bilaterales, arco longitudinal disminuido al estar de pie, que se forma parcialmente al ponerse de puntas (pie plano flexible). ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A. Zapatos ortopédicos rígidos
- B. No requiere tratamiento
- C. Plantillas internas a la medida
- D. Corrección quirúrgica

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que reconocer que esto es una variante normal del desarrollo, no una enfermedad. A los dos años casi todos los niños tienen los pies aparentemente planos, en parte por la almohadilla de grasa de la planta y porque el arco todavía se está formando; el arco longitudinal se desarrolla de manera natural a lo largo de los primeros años de vida. Lo que confirma que se trata de un pie plano flexible y benigno es que el arco reaparece cuando el niño se pone de puntas, lo que demuestra que la estructura está sana y solo se aplanan al apoyar el peso, y que además el niño camina normal, sin dolor ni limitación. En esa situación la conducta correcta es tranquilizar a los padres y no hacer nada, porque el pie se corregirá solo con el crecimiento. Los zapatos ortopédicos rígidos no aceleran la formación del arco ni corrigen nada, solo incomodan al niño y generan un gasto inútil; se abandonó esa práctica. Las plantillas a medida tampoco modifican la evolución natural de un pie plano flexible asintomático y no están indicadas cuando no hay dolor. La corrección quirúrgica es una intervención agresiva

reservada para pies planos rígidos, dolorosos o con una causa estructural de fondo, absolutamente desproporcionada para un pie flexible, indoloro y normal en su función.

VILLAPEPA ENAM: Pie plano flexible, bilateral, indoloro y con arco que reaparece al ponerse de puntas en un niño pequeño = variante normal del desarrollo, no requiere tratamiento. Los zapatos rígidos y las plantillas no modifican su evolución; la cirugía se reserva para el pie plano rígido o doloroso.

94. Varón de 71 años, hipertenso y diabético controlado, desde hace 4 días inicia dolor abdominal tipo cólico difuso, distensión abdominal progresiva y desde hace 6 horas no elimina flatos. Examen: T 37°C, FC 90 x', PA 124/82 mmHg. Abdomen: distendido, timpánico, leve dolor a la palpación, RHA (-), ampolla rectal vacua al tacto. Lab: leucocitos 9 000/cm³ . Rx de abdomen: signo de "grano de café" ¿Cuál es la conducta a seguir?

- A. Devolvulación endoscópica
- B. Lactulosa vía oral
- C. Tratamiento con neostigmina
- D. Laparotomía exploratoria

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La radiografía pone el diagnóstico: el signo del grano de café es la imagen clásica del vólvulo de sigmoides, el asa del colon sigmoides que se retuerce sobre sí misma y se llena de aire formando esa gran asa en forma de grano. Encaja con todo el cuadro, un anciano con obstrucción intestinal, distensión, ausencia de gases y ampolla rectal vacía. El punto clave para elegir la conducta es que no hay signos de que el asa esté sufriendo o perforada: el paciente está estable, afebril, sin defensa ni irritación peritoneal marcada y con los leucocitos normales, lo que indica que todavía no hay isquemia ni gangrena. En ese escenario, sin sufrimiento del asa, el tratamiento inicial es intentar destorcerla desde adentro con el endoscopio: la devolvulación endoscópica introduce el instrumento por el recto, desenrolla el asa y la descomprime, resolviendo la urgencia sin abrir el abdomen. Por eso es la conducta. La laparotomía exploratoria se reserva para cuando hay signos de isquemia o perforación, o cuando la devolvulación endoscópica fracasa; llevarlo a cirugía de entrada con un paciente estable y un asa viable sería excesivo. La neostigmina es el tratamiento de la pseudoobstrucción colónica, un colon dilatado sin torsión mecánica, que es un cuadro distinto del vólvulo. La lactulosa es un laxante que no tiene ningún papel en una obstrucción mecánica por torsión y hasta podría empeorar la distensión.

VILLAPEPA ENAM: Obstrucción intestinal en anciano + signo del grano de café en la radiografía = vólvulo de sigmoides. Sin signos de isquemia ni perforación (estable, afebril, leucocitos normales), el tratamiento inicial es la devolvulación endoscópica; la laparotomía se reserva para el asa sufriente o el fracaso endoscópico.

95. Varón de 60 años, con dengue grave que requirió expansión con cristaloideos durante la fase crítica. A las 48 horas de la defervescencia presenta disnea progresiva, taquipnea, SO₂ de 88% al aire ambiente y crepitantes bilaterales. Hemodinamia estable. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Edema pulmonar por extravasación capilar debido a sobrecarga de fluidos
- B. Hemorragia alveolar difusa asociada a dengue grave
- C. Neumonía atípica secundaria como complicación sobreagregada
- D. Síndrome de dificultad respiratoria aguda por daño alveolar directo del virus

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que entender la dinámica del dengue grave por fases. En la fase crítica los capilares se vuelven permeables y el plasma se escapa del vaso hacia los tejidos, por lo que hay que reponer líquidos generosamente para sostener la circulación. Pero luego llega la fase de recuperación, que empieza alrededor de la defervescencia, cuando esa fuga capilar se cierra y todo el líquido que se había escapado, más el que se administró, regresa de golpe al torrente sanguíneo. Si durante la fase crítica se dio demasiado volumen, en la recuperación ese líquido reabsorbido sobrecarga la circulación y se desborda al pulmón, produciendo un edema pulmonar por sobrecarga de fluidos. Eso explica perfectamente a este paciente que, a las cuarenta y ocho horas de bajar la fiebre, es decir en plena fase de recuperación, desarrolla disnea, desaturación y crepitantes, pero se mantiene hemodinámicamente estable. Por eso el diagnóstico es el edema pulmonar por la sobrecarga de fluidos al reabsorberse la extravasación. La hemorragia alveolar difusa daría expectoración con sangre y caída del hematocrito, no este cuadro de sobrecarga en la recuperación. La neumonía sobreagregada cursaría con fiebre nueva y un foco de consolidación, no con crepitantes bilaterales justo cuando el líquido vuelve al vaso. El síndrome de dificultad respiratoria por daño viral directo es mucho menos frecuente y no encaja con el momento exacto de la reabsorción; el escenario clásico de disnea en la fase de recuperación tras haber expandido con líquidos es la sobrecarga.

VILLAPEPA ENAM: Disnea y crepitantes bilaterales a las 48 horas de la defervescencia del dengue, en un paciente que recibió líquidos en la fase crítica y está hemodinámicamente estable = edema pulmonar por sobrecarga de fluidos, al reabsorberse el plasma extravasado en la fase de recuperación.

96. Mujer de 28 años desde hace 5 años con LES en tratamiento con prednisona a dosis baja e hidroxiquina, presenta hace 3 meses fiebre, sudoración nocturna, pérdida de 6 kg de peso y fatiga intensa. Examen: linfadenopatías cervical y axilar no dolorosa. Laboratorio: Hb 10 g/dL, leucocitos 2 800/ μ L y plaquetas 90 000/ μ L, sin datos de hemólisis, complemento C3/C4 está dentro de rango normal. LDH en sangre 600 UI/L. ¿Cuál condición debe incluirse prioritariamente en el diagnóstico diferencial?

- A. Linfoma no Hodgkin
- B. Tuberculosis ganglionar
- C. Reactivación de LES
- D. Micosis profunda

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que combinar tres pistas. La primera es que los pacientes con lupus tienen un riesgo aumentado de desarrollar linfoma. La segunda es el cuadro clínico: fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, lo que se conoce como síntomas B, junto con ganglios crecidos, no dolorosos, en cuello y axila, y una enzima, la deshidrogenasa láctica, claramente elevada; esa constelación de síntomas B, adenopatías indoloras y deshidrogenasa alta es muy sugestiva de un linfoma. Y la tercera pista es la que descarta la alternativa más obvia: el complemento está normal. En una reactivación del lupus, el consumo de complemento haría que el C3 y el C4 bajaran, así que un complemento normal habla en contra de que el lupus se haya reactivado y empuja a buscar otra causa para todos estos síntomas. Por eso lo prioritario en el diferencial es el linfoma no Hodgkin. La reactivación del lupus explicaría fiebre y citopenias, pero cursaría con el complemento bajo, no normal como aquí, y no suele dar la deshidrogenasa tan alta con adenopatías tumorales. La tuberculosis ganglionar es un diferencial razonable en un inmunosuprimido con adenopatías y síntomas constitucionales, y hay que tenerla presente, pero la deshidrogenasa muy elevada junto con el patrón de ganglios indoloros y el riesgo aumentado de linfoma en el lupus la sitúan por delante. La micosis profunda es mucho menos probable en este contexto y no explica bien el conjunto; lo que manda es descartar el linfoma.

VILLAPEPA ENAM: Paciente con lupus (riesgo aumentado de linfoma) + síntomas B + adenopatías indoloras

+ LDH elevada + complemento NORMAL = priorizar linfoma no Hodgkin. El complemento normal habla en contra de una reactivación lúpica, que cursaría con complemento bajo.

97. Mujer de 45 años con enfermedad renal crónica estadio 5 acude a emergencia por debilidad generalizada. Se encuentra en tratamiento con amikacina EV por infección urinaria complicada desde hace 3 días. En los exámenes se evidencia potasio sérico de 7,5 mEq/L. ¿Qué tratamiento debe indicarse primero para disminuir el riesgo inmediato de arritmias malignas?

- A. Infusión de insulina regular con solución de dextrosa hipertónica
- B. Gluconato de calcio EV en bolo lento
- C. Programar hemodiálisis urgente en las siguientes horas
- D. Nebulizaciones con salbutamol de alta dosis

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El potasio en siete y medio es una hiperpotasemia severa, y la amenaza más inmediata es que ese exceso de potasio altere la actividad eléctrica del corazón y desencadene una arritmia mortal. La pregunta pide qué se hace primero para proteger de ese riesgo inmediato, y la respuesta es estabilizar la membrana de las células cardíacas con gluconato de calcio intravenoso. El calcio no baja el potasio, pero antagoniza su efecto sobre el corazón: eleva el umbral de excitación de las células cardíacas y así protege de la arritmia en cuestión de minutos mientras se preparan las demás medidas. Por eso es lo primero, la maniobra que salva la vida en el instante. La insulina con dextrosa sí baja el potasio de verdad, empujándolo dentro de las células, y es un pilar del tratamiento, pero tarda un poco en actuar y no protege el corazón de inmediato; va después del calcio. El salbutamol nebulizado también mete potasio a la célula y ayuda a bajarlo, pero igualmente es una medida de desplazamiento que no estabiliza la membrana cardíaca de entrada. La hemodiálisis es el tratamiento definitivo que elimina el potasio del cuerpo, imprescindible en esta paciente con riñón terminal, pero se programa para las siguientes horas y no protege el corazón en el minuto crítico; lo primero, siempre, es el calcio.

VILLAPEPA ENAM: En hiperpotasemia grave con riesgo de arritmia, lo primero es gluconato de calcio intravenoso: estabiliza la membrana cardíaca y protege del ritmo mortal en minutos, aunque no baje el potasio. La insulina con glucosa y el salbutamol desplazan el potasio (más lentos) y la diálisis lo elimina (definitiva pero no inmediata).

98. Mujer de 52 años, con diabetes mellitus tipo 2 mal controlada, consulta por dolor anal intenso de 3 días de evolución, asociado a fiebre de 38,5 °C. Hemodinamia estable. Examen: eritema y tumefacción fluctuante dolorosa en el margen anal posterior, sin signos de celulitis extensa ni crepitación. ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?

- A. Solicitar ecografía perianal y confirmar la presencia de colección
- B. Inicio de ATB intravenosos de amplio espectro y control glucémico estricto
- C. Observación ambulatoria con analgesia y antibióticos durante 48 a 72 horas
- D. Drenaje quirúrgico inmediato del absceso y hospitalización

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El examen ya da el diagnóstico y el tratamiento en una sola palabra: fluctuante. Una tumoración fluctuante, dolorosa, roja y caliente en el margen del ano, con fiebre, es un absceso perianal, una colección de pus, y el principio quirúrgico es absoluto: el pus se drena. La conducta inicial es el drenaje quirúrgico inmediato de la colección para evacuar el material infectado y aliviar el cuadro, y como esta paciente además es diabética mal controlada, un terreno donde estas infecciones pueden diseminarse y complicarse rápido, se la hospitaliza para

vigilarla y optimizar su glucemia. Por eso la respuesta es drenaje inmediato con hospitalización. Pedir una ecografía para confirmar la colección es innecesario y peligroso por la demora: el diagnóstico de un absceso fluctuante es clínico, se palpa, y no se debe retrasar el drenaje esperando una imagen. Dar solo antibióticos intravenosos y controlar la glucemia sin drenar deja la colección de pus atrapada, y los antibióticos por sí solos no penetran ni resuelven un absceso ya formado; son un complemento del drenaje, no su reemplazo. La observación ambulatoria con analgesia y antibióticos es aún más riesgosa en una diabética, porque posterga el único tratamiento eficaz y expone a que la infección progrese a una forma grave y necrotizante del periné.

VILLAPEPA ENAM: Tumoración perianal fluctuante, dolorosa y con fiebre = absceso perianal, y el pus se drena. La conducta es drenaje quirúrgico inmediato más hospitalización, sobre todo en la diabética por el riesgo de progresión. No se retrasa por una ecografía ni se maneja solo con antibióticos, que no resuelven una colección.

99. Un médico investigador modifica deliberadamente los resultados de su estudio clínico para satisfacer las expectativas de la entidad financiadora. ¿Cómo se clasifica esta falta en el ámbito de la integridad científica?

- A. Práctica aceptable para financiamiento
- B. Mala conducta científica
- C. Conflicto de intereses
- D. Práctica cuestionable de investigación

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La palabra que define la falta es deliberadamente. El investigador altera a propósito los resultados de su estudio, es decir inventa o manipula los datos para que digan lo que el financiador quiere oír. Falsificar o fabricar resultados es una de las faltas más graves de la investigación, y tiene un nombre preciso: mala conducta científica, la categoría que agrupa las transgresiones deliberadas de la integridad como fabricar datos, falsificarlos o plagiar. Por eso esta acción se clasifica ahí. Llamarla práctica aceptable para financiamiento es absurdo: manipular datos nunca es aceptable, sea cual sea la fuente del dinero, y contradice el fundamento mismo de la ciencia. El conflicto de intereses describe una situación de riesgo, tener un interés secundario, como la relación con el financiador, que podría sesgar el juicio, pero en sí mismo no es una falta consumada; aquí no estamos ante un simple riesgo de sesgo sino ante un fraude ya cometido, que es algo mucho más grave. Las prácticas cuestionables de investigación son la zona gris, los deslices metodológicos discutibles que no llegan a fraude claro; falsificar resultados a propósito está muy por encima de eso, es directamente mala conducta científica.

VILLAPEPA ENAM: Modificar o fabricar resultados de forma deliberada = mala conducta científica (fabricación y falsificación, junto con el plagio, son las faltas graves). El conflicto de intereses es solo un riesgo de sesgo, no una falta consumada; las prácticas cuestionables son la zona gris, no el fraude directo.

100. Niña escolar de 7 años con diagnóstico de asma desde hace 2 años. En el último mes ha tenido tos y sibilancias más de 2 veces por semana, no presentó despertares nocturnos, no tuvo visitas a emergencias ni limitación importante en sus actividades escolares. ¿Cuál clasificación de asma padece?

- A. Intermitente
- B. Persistente moderada
- C. Persistente grave
- D. Persistente leve

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La clasificación del asma se basa en la frecuencia de los síntomas diurnos, los despertares nocturnos y el grado de limitación de la actividad. Esta niña tiene síntomas de día más de dos veces por semana, pero no todos los días; no se despierta de noche por el asma; no ha ido a emergencias y no tiene una limitación importante de sus actividades. Ese patrón, síntomas más frecuentes que dos veces por semana pero sin llegar a ser diarios, y sin despertares ni limitación relevante, corresponde al asma persistente leve. El límite es fino y hay que ubicarlo bien. El asma intermitente exige que los síntomas sean iguales o menores a dos veces por semana; como esta niña los tiene más de dos veces, ya cruzó ese umbral y no es intermitente. El asma persistente moderada se caracteriza por síntomas prácticamente diarios y despertares nocturnos frecuentes, con limitación de la actividad, nada de lo cual presenta esta paciente. El asma persistente grave es aún más severa, con síntomas continuos a lo largo del día, despertares nocturnos casi todas las noches y limitación marcada; está muy lejos del cuadro leve de esta niña. El punto justo entre intermitente y persistente moderada, con síntomas más de dos veces por semana pero no diarios, es la persistente leve.

VILLAPEPA ENAM: Síntomas de asma más de 2 veces por semana pero no diarios, sin despertares nocturnos ni limitación de actividad = asma persistente leve. El intermitente son síntomas iguales o menores a 2 veces por semana; el moderado es síntomas casi diarios con despertares.

101. Puérpera inmediata de parto vaginal eutócico, presenta hemorragia postparto por atonía uterina. A pesar de masaje uterino bimanual y administración de uterotónicos el sangrado continúa siendo abundante. Examen: PA: 80/60 mmHg, FC: 98 x', paciente desea preservar su fertilidad, antes de considerar una histerectomía: ¿Cuál es el siguiente paso recomendable?

- A. Ligadura de arterias uterinas
- B. Inyección de metotrexate
- C. Legrado puerperal
- D. Taponamiento vaginal

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que seguir la escalera del manejo de la hemorragia posparto por atonía. Ya se hicieron los primeros peldaños, el masaje uterino y los uterotónicos, y el sangrado no cede. El siguiente peldaño, sobre todo en una mujer que quiere conservar la fertilidad y antes de llegar a la histerectomía, son las técnicas quirúrgicas conservadoras que reducen el flujo de sangre al útero sin extirparlo. La ligadura de las arterias uterinas hace exactamente eso: ata los vasos que irrigan el útero, disminuye la presión de perfusión y ayuda a que el útero atónico deje de sangrar, todo preservando el órgano y por tanto la capacidad de tener más hijos. Por eso es el paso recomendable. El taponamiento vaginal no controla una hemorragia de origen uterino: rellenar la vagina no comprime el útero, que es donde está el problema; lo que sí se usa es el taponamiento intrauterino con balón, pero eso es distinto de un taponamiento de la vagina. El legrado puerperal se indica cuando la causa del sangrado es la retención de restos placentarios, no la atonía; raspar un útero atónico no lo hace contraerse. La inyección de metotrexato no tiene ningún papel en la hemorragia posparto: es un fármaco para el embarazo ectópico o la enfermedad trofoblástica, no para detener el sangrado de un útero que no se contrae.

VILLAPEPA ENAM: Hemorragia posparto por atonía que no cede a masaje y uterotónicos, en mujer que desea conservar la fertilidad = ligadura de arterias uterinas antes de la histerectomía. El taponamiento vaginal no comprime el útero; el legrado es para restos retenidos y el metotrexato para el ectópico.

102. Mujer de 45 años, residente a 3 500 m s. n. m., consulta por prurito intenso que empeora con agua caliente, cefalea recurrente. Hemograma: Hb 19 g/dL, Hto 60%, leucocitosis leve, plaquetas 520 000/ μ L. SO_2 : 97%. Eritropoyetina sérica disminuida. Estudio molecular: mutación JAK2 V617F, confirmando policitemia vera de bajo riesgo. ¿Cuál es la intervención más apropiada?

- A. Tratar solo la hipoxia crónica de altura con oxígeno domiciliario
- B. Indicar reposo relativo e hidratación oral, observando evolución
- C. Realizar flebotomías seriadas para mantener el hematocrito
- D. Administrar hidroxiurea para reducir todos los linajes celulares

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El diagnóstico ya viene confirmado y hay que separarlo de la altura. Aunque la paciente vive a gran altitud, esto no es una policitemia por hipoxia: la saturación de oxígeno es normal y el dato que lo define es que la eritropoyetina está baja. En la poliglobulia de altura la eritropoyetina estaría alta, porque el cuerpo la sube para compensar la hipoxia; que aquí esté baja, junto con la mutación JAK2 positiva, el prurito que empeora con el agua caliente y el aumento de las tres series, confirma una policitemia vera, una enfermedad de la médula que produce glóbulos de más por cuenta propia. En la policitemia vera de bajo riesgo, el pilar del tratamiento es reducir mecánicamente la masa de glóbulos rojos con flebotomías seriadas, sangrías repetidas que bajan el hematocrito a un objetivo por debajo del cuarenta y cinco por ciento, lo que reduce el espesor de la sangre y el riesgo de trombosis. Por eso esa es la intervención. Tratar solo con oxígeno domiciliario sería manejar una hipoxia de altura que no existe, ya que la saturación es normal y la eritropoyetina baja descarta ese mecanismo. Reposo e hidratación observando la evolución deja sin tratar una enfermedad que aumenta el riesgo de trombosis y necesita bajar activamente el hematocrito. La hidroxiurea, que frena la producción de todas las líneas en la médula, se reserva para la policitemia vera de alto riesgo o cuando las flebotomías no bastan; en una de bajo riesgo el tratamiento de base son las flebotomías.

VILLAPEPA ENAM: Policitemia vera (JAK2 positivo, eritropoyetina baja, prurito con agua caliente) de bajo riesgo = flebotomías seriadas para mantener el hematocrito por debajo de 45%. La eritropoyetina baja la separa de la poliglobulia de altura (donde estaría alta); la hidroxiurea se reserva para el alto riesgo.

103. Varón de 34 años desde hace 10 horas presenta dolor lumbar derecho intenso, irradiado a testículo, asociado con náuseas y vómitos. Examen: signos vitales normales, abdomen no rebote, PPL derecha positiva. Lab: creatinina 0,9 mg/dL, leucocitos 8 500/μL, examen de orina con hematuria, sin leucocituria ni bacteriuria. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- A. Antibióticos de amplio espectro previo urocultivo
- B. Corticoides orales y reposo absoluto
- C. AINE de acción rápida IV y ecografía renal
- D. Antiespasmódicos (butilbromuro de hioscina)

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El cuadro es un cólico nefrítico de manual: dolor lumbar intenso que se irradia hacia el testículo, con náuseas y vómitos, la puñopercusión lumbar positiva y una orina con sangre pero sin signos de infección, es decir sin glóbulos blancos ni bacterias. Todo apunta a un cálculo que bajó por el uréter y lo está obstruyendo. La conducta inicial persigue dos cosas: calmar ese dolor tan intenso y confirmar la piedra. Para el dolor, el analgésico de elección en el cólico renal es un antiinflamatorio de acción rápida por vía intravenosa, porque además de quitar el dolor disminuye la producción de prostaglandinas y con ello reduce el edema y la presión dentro de la vía urinaria, que es el origen del dolor, no solo la sensación. Y para confirmar, la ecografía renal muestra el cálculo y si hay dilatación de la vía urinaria. Por eso la respuesta une el antiinflamatorio con la ecografía. Los antibióticos no corresponden porque no hay infección: la orina no tiene leucocitos ni bacterias, la hematuria es por el roce del cálculo, no por una infección que tratar. Los corticoides no son el tratamiento del cólico renal ni alivian este dolor. Los antiespasmódicos como la hioscina se han usado, pero son menos eficaces que el antiinflamatorio

para el cólico renal, así que no son la mejor opción inicial; el antiinflamatorio de acción rápida es el que controla mejor el dolor y ataca la inflamación ureteral.

VILLAPEPA ENAM: Dolor lumbar irradiado al testículo + puñopercusión positiva + hematuria sin infección = cólico nefrítico por litiasis ureteral. La conducta inicial es un antiinflamatorio de acción rápida intravenoso (analgésico de elección) más ecografía renal; sin infección no van antibióticos, y los antiespasmódicos son menos eficaces.

104. Mujer de 45 años, con antecedente reciente de pancreatitis aguda leve de probable origen biliar, tratada con hidratación y analgesia, es dada de alta en buenas condiciones. Dos semanas después acude nuevamente por dolor abdominal moderado. Examen físico se encuentra afebril, con abdomen blando y se palpa una masa poco dolorosa en epigastrio. No presenta ictericia. ¿Cuál es la complicación de la pancreatitis aguda más probable?

- A. Síndrome colestásico por coledocolitiasis
- B. Seudoquiste pancreático
- C. Absceso pancreático
- D. Ascitis secundaria a pancreatitis

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El tiempo y la forma de presentación son las claves. Dos semanas después de una pancreatitis aguda, aparece una masa palpable en el epigastrio, poco dolorosa, en una paciente que está afebril y sin ictericia. Esa combinación de una colección que se forma unas semanas después de la pancreatitis y se hace palpable como masa en epigastrio, sin fiebre, corresponde a un pseudoquiste pancreático, una colección de líquido rico en enzimas rodeada de una pared que no es un quiste verdadero, y que típicamente madura entre dos y cuatro semanas tras el episodio agudo. Por eso es la complicación más probable. El absceso pancreático también es una colección, pero está infectado, así que cursaría con fiebre y signos de infección, y esta paciente está afebril, lo que va en contra. El síndrome colestásico por un cálculo en la vía biliar se manifestaría con ictericia y un patrón de colestasis por obstrucción del conducto biliar, y aquí no hay ictericia, lo que lo hace improbable. La ascitis pancreática produce distensión por líquido libre en todo el abdomen, no una masa localizada y palpable en el epigastrio como la que se describe; el hallazgo de una masa epigástrica que surge un par de semanas después de la pancreatitis, sin fiebre ni ictericia, es el pseudoquiste.

VILLAPEPA ENAM: Masa epigástrica poco dolorosa que aparece 2 a 4 semanas después de una pancreatitis aguda, sin fiebre ni ictericia = pseudoquiste pancreático (colección con pared que madura tras el episodio). El absceso tendría fiebre y la coledocolitiasis, ictericia con colestasis.

105. Lactante de 8 meses de edad, llevado a Emergencia por episodio convulsivo. Examen: afebril, estado post ictal, fontanela anterior cerrada, no signos de focalización. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Craneosinostosis
- B. Epilepsia
- C. Trastorno hidroelectrolítico
- D. Meningitis

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El dato que orienta es que la convulsión ocurrió sin fiebre, es decir es una convulsión afebril, en un lactante que además no tiene signos de foco neurológico. Ante una primera crisis afebril en un niño pequeño, lo primero que hay que descartar son las causas metabólicas y de los electrolitos, porque son frecuentes, corregibles y potencialmente peligrosas: la baja de glucosa, de calcio o de sodio pueden desencadenar convulsiones en el lactante. Por eso, en este escenario sin fiebre y sin focalización, el diagnóstico más probable a investigar es un trastorno hidroelectrolítico. La epilepsia no se diagnostica con una sola convulsión: requiere crisis recurrentes y no provocadas, y es un diagnóstico de exclusión que se plantea recién después de descartar las causas agudas como la metabólica; con un único episodio no se puede etiquetar de epilepsia. La meningitis es una causa importante de convulsión en el lactante, pero suele acompañarse de fiebre y compromiso del estado general, y aquí el niño está afebril, lo que la hace menos probable como primera opción. La craneosinostosis es el cierre prematuro de las suturas del cráneo y no es una causa de convulsión aguda; además, mencionar que la fontanela está cerrada a los ocho meses no equivale a craneosinostosis y, por sí solo, no explica una crisis convulsiva.

VILLAPEPA ENAM: Primera convulsión afebril en un lactante, sin focalización = descartar prioritariamente un trastorno hidroelectrolítico (hipoglucemia, hipocalcemia, hiponatremia). La epilepsia exige crisis recurrentes no provocadas (diagnóstico de exclusión) y la meningitis suele cursar con fiebre.

106. Varón de 40 años, con diarrea crónica de 2 años de evolución asociada a dolor abdominal cólico y episodios de fiebre. Colonoscopia: áreas de mucosa "en empedrado" con úlceras lineales a lo largo del colon, comprometiendo la válvula ileocecal y el íleon terminal, con zonas de mucosa aparentemente sana entre las lesiones. Biopsia: revela inflamación transmural y segmentaria, con presencia de granulomas no caseificantes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Enfermedad de Crohn
- B. Síndrome de intestino irritable
- C. Colitis ulcerativa crónica
- D. Colitis infecciosa por Clostridioides difficile

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Cada hallazgo de la colonoscopia y de la biopsia es una firma de la enfermedad de Crohn. El aspecto en empedrado de la mucosa y las úlceras lineales son típicos; el compromiso de la válvula ileocecal y del íleon terminal señala que afecta el intestino delgado, algo que Crohn hace y que la otra enfermedad inflamatoria no; las zonas de mucosa sana entre las lesiones describen el patrón segmentario, las lesiones salteadas que dejan tramos indemnes; y la biopsia lo confirma con dos rasgos definitorios, la inflamación transmural, que atraviesa todo el grosor de la pared, y los granulomas no caseificantes. Ese conjunto es Crohn de principio a fin. La colitis ulcerosa es lo opuesto en varios puntos: compromete solo la mucosa de forma superficial, no toda la pared, es continua desde el recto hacia arriba sin dejar zonas sanas, no afecta el íleon salvo excepciones y no forma granulomas. El síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional sin lesiones: la colonoscopia y la biopsia serían normales, incompatibles con las úlceras y los granulomas de este caso. La colitis por Clostridioides difficile produce una inflamación aguda con pseudomembranas, habitualmente tras antibióticos, no una enfermedad crónica de dos años con empedrado, compromiso ileal y granulomas; el patrón transmural, segmentario y granulomatoso es exclusivo de Crohn.

VILLAPEPA ENAM: Empedrado + úlceras lineales + compromiso del íleon terminal + lesiones salteadas (mucosa sana entre lesiones) + inflamación transmural con granulomas no caseificantes = enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa es continua, solo mucosa, sin granulomas y respeta el íleon.

107. Primigesta de 39 semanas, acude a emergencia por contracciones uterinas regulares desde hace 8 horas. Examen vaginal: cérvix con dilatación de 6 cm, AP -2, membranas íntegras; las contracciones son de moderada intensidad cada 3 minutos. Cuatro horas después, permanece con 6 cm de dilatación, AP -2, contracciones de similar intensidad y frecuencia, los latidos cardíacos fetales son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable respecto a la evolución del trabajo de parto?

- A. Falso trabajo de parto sin modificación cervical significativa
- B. Detención de la fase activa del trabajo de parto
- C. Fase latente prolongada del trabajo de parto
- D. Prolongación de la fase expulsiva del trabajo de parto

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que ubicar en qué fase del parto está y ver si progresa. Una dilatación de seis centímetros ya corresponde a la fase activa del trabajo de parto, la etapa en que el cuello debería seguir abriéndose de forma sostenida. Lo que muestra el caso es que, teniendo contracciones adecuadas, regulares cada tres minutos y de intensidad moderada, después de cuatro horas la paciente sigue igual: los mismos seis centímetros y la misma altura de la presentación, sin ningún avance. Cuando en plena fase activa hay contracciones eficaces pero la dilatación no progresa durante varias horas, el diagnóstico es una detención de la fase activa del trabajo de parto. Por eso es la respuesta. El falso trabajo de parto son contracciones que no modifican el cuello y no llevan a dilatación; aquí ya hay seis centímetros y trabajo activo establecido, así que no es falso. La fase latente prolongada se refiere a la etapa inicial, antes de la fase activa, cuando el cuello todavía dilata poco y lento; a seis centímetros ya se pasó esa fase, no puede ser latente. La prolongación de la fase expulsiva ocurre en el período de pujos, con dilatación completa de diez centímetros, cuando el feto no termina de descender y nacer; esta paciente está en seis centímetros, muy lejos de la expulsión, así que ese diagnóstico no corresponde.

VILLAPEPA ENAM: Dilatación de 6 cm (fase activa ya establecida) que no progresa en 4 horas pese a contracciones adecuadas = detención de la fase activa del trabajo de parto. La fase latente es antes de la fase activa; la prolongación de la expulsión ocurre con dilatación completa de 10 cm.

108. Niño de 2 años, previamente sano, inicia asistencia a una guardería pública en Lima. En los últimos 12 meses ha presentado 8 episodios de rinofaringitis aguda autolimitada, sin hospitalizaciones ni neumonías. Sus padres se muestran preocupados y preguntan si esta frecuencia de resfriados indica un trastorno de inmunidad y si deberían retirarlo de la guardería. Desde la perspectiva clínica, inmunológica y de salud pública, ¿cuál es la respuesta más adecuada del médico?

- A. Explicar que 6–8 episodios de resfriado al año son habituales en una guardería y reforzar higiene respiratoria
- B. Señalar que más de 4 episodios de resfriado al año son anormales y suspender la asistencia a guardería
- C. Minimizar la preocupación pues los resfriados son inevitables en la infancia, solo traerlo si presenta fiebre
- D. Indicar que la frecuencia de resfriados sugiere asma atópica subyacente y reducir al mínimo contacto con niños

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La clave está en distinguir lo normal de lo patológico en las infecciones respiratorias del niño pequeño. Un niño sano de dos años, sobre todo si asiste a una guardería donde comparte virus con muchos otros, puede tener con toda normalidad entre seis y ocho resfriados al año, y aún más durante los primeros años, porque su sistema inmune se está estrenando y educando frente a los virus del ambiente. El dato que confirma que esto es normal

es que todos los episodios fueron rinofaringitis leves y autolimitadas, sin neumonías, sin hospitalizaciones ni infecciones graves. Por eso la respuesta correcta es tranquilizar a los padres, explicarles que esa frecuencia es habitual en la guardería y reforzar las medidas de higiene respiratoria. Decir que más de cuatro resfriados al año son anormales y retirar al niño de la guardería es incorrecto, porque el umbral normal es bastante más alto y suspender la guardería no está justificado por resfriados banales. Minimizar la preocupación diciéndole a los padres que solo lo traigan si hay fiebre desatiende su inquietud y da un consejo pobre; lo adecuado es educarlos, no despacharlos. Atribuir los resfriados a un asma atópica y aislar al niño del contacto con otros es un salto diagnóstico sin fundamento: nada en el caso sugiere asma, y aislarlo socialmente no tiene sentido cuando el patrón es el de un niño sano que hace las infecciones esperables de su edad y su entorno.

VILLAPEPA ENAM: Un niño sano en guardería puede tener 6-8 resfriados leves y autolimitados al año como parte normal de la maduración inmune; sin infecciones graves, neumonías ni hospitalizaciones, no hay inmunodeficiencia. Lo correcto es tranquilizar, educar y reforzar higiene, no retirarlo de la guardería.

109. Según la normativa MINSA de suplementación con micronutrientes. ¿A partir de qué semana de gestación se recomienda iniciar de manera rutinaria la suplementación profiláctica con hierro en una gestante de bajo riesgo y sin anemia que acude a control prenatal oportuno?

- A. 14
- B. 28
- C. 10
- D. 20

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La norma peruana de suplementación con micronutrientes en la gestante establece que el hierro profiláctico, junto con el ácido fólico, se inicia de manera rutinaria a partir de las 14 semanas de gestación en la embarazada sin anemia que llega a control oportuno. Hay una lógica detrás de esa fecha: durante el primer trimestre son frecuentes las náuseas y los vómitos, que el hierro tiende a empeorar por su irritación gástrica, y además se prefiere no cargar de suplementos las primeras semanas de la organogénesis; al pasar el primer trimestre, alrededor de las 14 semanas, las molestias digestivas ceden y comienza a aumentar la demanda de hierro por el crecimiento fetal y la expansión de la sangre materna, momento ideal para empezar la profilaxis y prevenir la anemia. Por eso la respuesta es 14 semanas. Iniciar a las 10 semanas sería adelantarse al primer trimestre, cuando aún predominan las náuseas y no se recomienda comenzar de rutina. Las 20 y las 28 semanas son demasiado tarde para una profilaxis que busca prevenir la anemia a lo largo de la gestación; empezar tan tarde deja a la madre expuesta a desarrollar déficit de hierro justo cuando la demanda ya está creciendo. El punto normado, que equilibra tolerancia y prevención, son las 14 semanas.

VILLAPEPA ENAM: La suplementación profiláctica con hierro en la gestante sin anemia se inicia de rutina a partir de las 14 semanas según la norma MINSA, tras pasar el primer trimestre de náuseas y cuando aumenta la demanda de hierro. Antes (10 sem) coincide con las náuseas; después (20-28) es tarde para prevenir la anemia.

110. Varón de 40 años que hace 30 minutos sufre asalto con arma de fuego. Examen: PA: 60/40 mmHg, FC: 100 x', FR: 30 x'. Abdomen: distendido con orificio de entrada, RHA (-), signo de rebote (+). En sala de operaciones: lesión hepática sangrante incontrolable. En este caso se debe realizar la maniobra de.....

- A. Chutro.

- B. Pringle.
- C. Mattox.
- D. exclusión duodenal.

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El escenario es un sangrado hepático masivo e incontrolable durante una laparotomía por herida de bala, y la pregunta busca la maniobra que corta ese sangrado. La maniobra de Pringle es exactamente eso: el cirujano clampa el pedículo hepático, es decir el ligamento hepatoduodenal, por donde entran al hígado la arteria hepática y la vena porta, los dos vasos que le llevan sangre. Al ocluir temporalmente ese pedículo se interrumpe el flujo de entrada al hígado y disminuye de golpe la hemorragia, lo que le da al cirujano el control y el tiempo para ver la lesión y repararla. Por eso es la maniobra indicada en el sangrado hepático incontrolable. La exclusión duodenal es una técnica para lesiones graves del duodeno, no del hígado, así que no controla una hemorragia hepática. La maniobra de Mattox sí existe, pero sirve para rotar las vísceras y exponer la aorta y el retroperitoneo izquierdo, no para controlar el sangrado hepático; el gesto quirúrgico clásico y correcto para clampar la entrada de sangre al hígado y frenar la hemorragia es la maniobra de Pringle.

VILLAPEPA ENAM: Sangrado hepático incontrolable en cirugía = maniobra de Pringle: clampaje del pedículo hepático (ligamento hepatoduodenal con la arteria hepática y la vena porta) para interrumpir el flujo de entrada al hígado y controlar la hemorragia. La exclusión duodenal es para lesiones del duodeno, no del hígado.

111. Según la normativa del Ministerio de Salud ¿Cuál es la definición que mejor describe la Cartera de Servicios de un establecimiento de salud?

- A. Registro de las atenciones realizadas en un periodo determinado, utilizado para la programación de metas y recursos de salud
- B. Conjunto de prestaciones de salud que se ofrece para responder a las necesidades de la población y a las prioridades de salud
- C. Listado de prestaciones, exámenes auxiliares y medicamentos disponibles para la atención diaria
- D. Documento administrativo que fija horarios de atención y distribución del personal para la oferta de servicios de salud

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La cartera de servicios responde a la pregunta de qué ofrece un establecimiento de salud, y su definición tiene dos rasgos que hay que reconocer: es el conjunto de prestaciones que el establecimiento brinda, y esas prestaciones se definen en función de las necesidades de la población que atiende y de las prioridades sanitarias. Es decir, no es una lista cualquiera, sino la oferta organizada de servicios pensada para dar respuesta a lo que la gente necesita. Por eso la definición correcta es la que habla de un conjunto de prestaciones orientado a las necesidades de la población y las prioridades de salud. El registro de las atenciones realizadas en un periodo es un dato de producción, mira hacia atrás para contar lo que ya se hizo y programar metas y recursos, pero no es la oferta de servicios en sí. El listado de prestaciones, exámenes y medicamentos disponibles se acerca, pero se queda en un inventario de lo que hay en el día a día, sin el sentido de responder a las necesidades y prioridades de la población que da su verdadero significado a la cartera. El documento que fija horarios y distribuye al personal es una herramienta de organización interna del trabajo, no la definición de qué prestaciones se ofrecen a la comunidad.

VILLAPEPA ENAM: La cartera de servicios es el conjunto de prestaciones de salud que un establecimiento

ofrece para responder a las necesidades de su población y a las prioridades sanitarias. No es el registro de atenciones (producción) ni un simple inventario de insumos ni el rol de personal.

112. En las infecciones urinarias bajas no complicadas causadas por Escherichia coli, la colonización del urotelio depende de un mecanismo específico de adhesión bacteriana. ¿Cuál es el principal factor de virulencia con que se fija E. coli a las células del tracto urinario?

- A. Liberación de exotoxinas que producen daño directo y necrosis del urotelio
- B. Secreción de enzimas proteolíticas que degradan proteínas de la matriz extracelular urotelial
- C. Producción de una cápsula mucoide que dificulta la fagocitosis por neutrófilos
- D. Fimbrias tipo I que se unen a receptores glucídicos de la superficie urotelial

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La pregunta pide el mecanismo con que la bacteria se agarra al urotelio, y ese es el paso decisivo de la infección urinaria: si la Escherichia coli no logra fijarse a la pared de la vía urinaria, la orina la arrastra y la elimina antes de que colonice. La herramienta que le permite anclarse son las fimbrias, unas prolongaciones filamentosas en su superficie que funcionan como ganchos moleculares; las fimbrias tipo uno tiene en su punta una adhesina que reconoce y se une a los azúcares presentes en los receptores glucídicos de las células del urotelio, lo que fija la bacteria a la superficie y le permite resistir el barrido de la orina y colonizar. Por eso el principal factor de virulencia para la adhesión son esas fimbrias. Las exotoxinas que dañan y necrosan el urotelio contribuyen a la lesión del tejido en algunas cepas, pero eso es hacer daño una vez instalada, no el mecanismo de fijación inicial que pregunta el caso. Las enzimas proteolíticas que degradan la matriz favorecen la invasión de tejidos, pero tampoco son el gancho que ancla la bacteria a la célula. La cápsula mucoide ayuda a la bacteria a escapar de la fagocitosis, es un mecanismo de defensa frente al sistema inmune, no de adhesión al urotelio; el agarre lo dan las fimbrias.

VILLAPEPA ENAM: La Escherichia coli uropatógena se fija al urotelio con fimbrias tipo I, cuya adhesina reconoce receptores glucídicos de la superficie celular; ese anclaje le permite resistir el barrido de la orina y colonizar. Las exotoxinas dañan el tejido, la cápsula evade la fagocitosis, pero la adhesión la dan las fimbrias.

113. En control de niño sano de 2 meses de edad, se encuentra lactante reactivo, con adecuado desarrollo psicomotor para su edad y sin déficits neurológicos aparentes. Mueve las cuatro extremidades de forma simétrica y los reflejos osteotendinosos están conservados. Sin embargo, al examinar la región lumbosacra, el pediatra observa un pequeño hoyuelo cutáneo cubierto por un mechón de pelo denso justo sobre la línea media, sin evidencia de salida de líquido cefalorraquídeo ni masas palpables. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Seno dérmico congénito
- B. Mielomeningocele
- C. Espina bífida oculta
- D. Meningocele

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que fijarse en dos cosas: qué se ve en la piel y qué no hay. En la línea media de la región lumbosacra aparece un hoyuelo con un mechón de pelo denso, y estos son los estigmas cutáneos clásicos de un defecto

oculto del cierre de la columna: la piel avisa que por debajo los arcos posteriores de las vértebras no se fusionaron del todo. Lo que no hay es igual de importante: no sale líquido cefalorraquídeo, no se palpa ninguna masa y el niño está neurológicamente normal, moviendo las cuatro extremidades y con reflejos conservados. Ese conjunto, un defecto de cierre vertebral cubierto por piel, sin masa ni compromiso neurológico y con marcadores cutáneos como el mechón de pelo, es la espina bífida oculta. Por eso es el diagnóstico. El mielomeningocele es lo opuesto en visibilidad: es una forma abierta y grave, con una masa que contiene médula y meninges protruyendo por el defecto, y suele acompañarse de déficits neurológicos importantes; aquí no hay masa ni déficit. El meningocele también es una forma con masa visible, un saco de meninges que sobresale, distinto del defecto plano y cubierto de este caso. El seno dérmico congénito es un trayecto que comunica la piel con estructuras profundas a través de un orificio, y aunque puede asociarse a marcadores cutáneos, lo que describe el caso, el hoyuelo con mechón de pelo sobre la línea media sin masa ni salida de líquido y con examen normal, corresponde al cuadro típico de la espina bífida oculta.

VILLAPEPA ENAM: Hoyuelo con mechón de pelo en la línea media lumbosacra, sin masa, sin salida de líquido y con examen neurológico normal = espina bífida oculta (defecto de cierre vertebral cubierto por piel). El mielomeningocele y el meningocele presentan masa visible; el estigma cutáneo con niño sano es la forma oculta.

114. Gestante de 20 semanas con lupus eritematoso sistémico, antecedente de tres óbitos fetales. Actualmente, el laboratorio solo puede procesar una prueba prioritaria. ¿Cuál es la prueba más adecuada para confirmar el probable diagnóstico?

- A. Anticuerpos anti-ADN de doble cadena
- B. Anticuerpos anticardiolipina (IgG, IgM o IgA)
- C. Anticuerpos anti-Ro/SSA y anti-La/SSB
- D. Dímero D plasmático

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La pista clínica es la historia de tres muertes fetales en una mujer con lupus. Las pérdidas fetales repetidas en una paciente con lupus apuntan a una complicación asociada muy concreta: el síndrome antifosfolípido, en el que unos anticuerpos favorecen la formación de trombos, incluso en los vasos de la placenta, y esas trombosis placentarias provocan las muertes fetales de repetición. Para confirmarlo, la prueba prioritaria es buscar esos anticuerpos, y entre ellos están los anticardiolipina, uno de los criterios de laboratorio del síndrome. Por eso, si solo se puede hacer un examen, ese es el más adecuado para confirmar el diagnóstico que explica los óbitos. Los anticuerpos anti-ADN de doble cadena son útiles para el lupus en sí, marcan su actividad, pero el lupus ya está diagnosticado; no explican las pérdidas fetales recurrentes, que es lo que hay que aclarar ahora. Los anticuerpos anti-Ro y anti-La se asocian a otra complicación distinta, el bloqueo cardíaco congénito y el lupus neonatal en el bebé, no a los óbitos por trombosis placentaria, así que no son la prueba prioritaria para este patrón. El dímero D es un marcador inespecífico de coagulación que sube en muchas situaciones, incluido el embarazo normal, y no confirma el síndrome antifosfolípido; el examen que lo diagnostica y explica las muertes fetales repetidas es el de los anticuerpos anticardiolipina.

VILLAPEPA ENAM: Lupus + pérdidas fetales recurrentes = síndrome antifosfolípido, y la prueba prioritaria son los anticuerpos anticardiolipina (criterio de laboratorio). El anti-ADN mide actividad lúpica; los anti-Ro/La se asocian a bloqueo cardíaco fetal, no a óbitos por trombosis placentaria.

115. Varón de 60 años, desde hace 2 meses presenta dolor en rodilla derecha que aparece al iniciar el movimiento y cede con el reposo. Examen: rodilla con aumento de volumen sin eritema ni calor local. Rx de rodilla: estrechamiento del espacio articular medial y osteofitos marginales. Líquido sinovial: se obtiene 10 mL, color amarillento, glucosa 82 mg/dL, leucocitos 1 800/mm³ y 20 % de neutrófilos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Artritis reumatoidea
- B. Artritis infecciosa
- C. Osteoartritis
- D. Gota aguda

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Tres piezas apuntan al mismo diagnóstico. Primero, el tipo de dolor: aparece al iniciar el movimiento y cede con el reposo, el llamado dolor mecánico, característico del desgaste articular, a diferencia del dolor inflamatorio que empeora con el reposo y mejora al moverse. Segundo, la radiografía: estrechamiento del espacio articular por el desgaste del cartilago y osteofitos, los picos de hueso que crecen en los bordes, que son la imagen clásica de la osteoartritis. Y tercero, el análisis del líquido articular: con menos de dos mil células y pocos neutrófilos, es un líquido no inflamatorio, coherente con un proceso degenerativo y no con una inflamación activa. Todo junto, dolor mecánico, osteofitos con pinzamiento y líquido no inflamatorio, es osteoartritis. La artritis reumatoide daría un dolor inflamatorio con rigidez matutina prolongada, un líquido claramente inflamatorio con muchos más leucocitos, y en la radiografía erosiones y osteopenia, no osteofitos. La artritis infecciosa cursaría con una articulación caliente, roja y muy dolorosa, con fiebre, y un líquido purulento con decenas de miles de leucocitos y glucosa baja; nada de eso aparece aquí. La gota aguda produce un ataque muy inflamatorio, con la articulación roja y caliente, y cristales de urato en el líquido, tampoco compatible con este cuadro mecánico y frío; el conjunto degenerativo señala la osteoartritis.

VILLAPEPA ENAM: Dolor mecánico (aparece al mover, cede en reposo) + osteofitos y estrechamiento articular en la radiografía + líquido no inflamatorio (menos de 2000 leucocitos) = osteoartritis. La artritis reumatoide e infecciosa dan líquido muy inflamatorio; la gota, cristales de urato con articulación caliente.

116. Mujer de 63 años acude al servicio de Emergencia por dolor abdominal tipo cólico de 24 horas de evolución, localizado en hipocondrio derecho y región periumbilical, asociado a vómitos inicialmente alimentarios y luego biliosos. Examen: distensión abdominal y disminución del peristaltismo. Rx simple de abdomen de pie muestra asas de intestino delgado dilatadas con disposición en escalera, múltiples niveles hidroaéreos y presencia de aire en la vía biliar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Íleo biliar
- B. Trombosis de vena mesentérica
- C. Colangitis aguda
- D. Colecistitis enfisematosa

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La radiografía junta dos hallazgos que, combinados, arman el diagnóstico. Por un lado, todos los signos de una obstrucción del intestino delgado: asas dilatadas dispuestas en escalera y múltiples niveles hidroaéreos, con distensión, dolor cólico, vómitos que se volvieron biliosos y peristaltismo disminuido. Por otro lado, y este es el dato que lo define, hay aire dentro de la vía biliar, lo que se llama neumobilia. Esa presencia de aire en la vía

biliar significa que se abrió una comunicación anormal entre la vesícula y el intestino, una fístula por la que un cálculo grande pasó al tubo digestivo y bajó hasta impactarse y obstruir el intestino delgado. Ese cuadro, obstrucción del delgado más aire en la vía biliar, es el íleo biliar. Por eso es la respuesta. La colangitis aguda es una infección de la vía biliar con la tríada de fiebre, ictericia y dolor, no una obstrucción del intestino delgado con neumobilia por un cálculo migrado. La colecistitis enfisematosa es una infección de la vesícula por gérmenes productores de gas, con aire en la pared de la vesícula, no aire en la vía biliar ni obstrucción intestinal. La trombosis de la vena mesentérica produce isquemia intestinal con dolor desproporcionado y no genera neumobilia; la dupla de obstrucción del delgado con aire en la vía biliar es exclusiva del íleo biliar.

VILLAPEPA ENAM: Obstrucción de intestino delgado (asas en escalera, niveles hidroaéreos) + aire en la vía biliar (neumobilia) = íleo biliar: un cálculo grande pasó por una fístula colecistoentérica y obstruye el intestino. La colangitis da fiebre e ictericia; la colecistitis enfisematosa, aire en la pared vesicular.

117. Niña de 7 años, previamente sana, residente en zona con brote de dengue. Acude por 3 días de fiebre alta, cefalea, mialgias y rash en tronco y extremidades. Desde hace 12 h presenta dolor abdominal difuso y vómitos persistentes (más de 3 episodios en 1 hora). Según las recomendaciones actuales para el manejo de dengue en niños, ¿cuál es la conducta más apropiada?

- A. Hospitalización inmediata en Cuidados Intensivos Pediátricos
- B. Observación en el servicio de Emergencia
- C. Hospitalización en sala de Pediatría
- D. Manejo ambulatorio con hidratación oral

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La clave está en reconocer que esta niña dejó de tener un dengue simple para tener un dengue con signos de alarma. El dolor abdominal intenso y los vómitos persistentes son precisamente dos de los signos de alarma que marcan el momento en que el dengue puede empezar a complicarse, porque anuncian la fuga de plasma y el riesgo de evolucionar hacia el shock. La aparición de esos signos cambia la conducta: el niño con dengue y signos de alarma debe ser hospitalizado para vigilancia estrecha e hidratación controlada, generalmente con líquidos intravenosos, y por eso la conducta correcta es hospitalizar en sala de pediatría. El manejo ambulatorio con hidratación oral es apropiado solo para el dengue sin signos de alarma, en un niño que tolera la vía oral y sin datos de complicación; una vez que aparecen el dolor abdominal y los vómitos persistentes, mandarla a casa es peligroso. La observación en emergencia se queda corta para un paciente que ya cruzó al grupo con signos de alarma y necesita ingreso e hidratación monitorizada, no solo unas horas de vigilancia. La unidad de cuidados intensivos se reserva para el dengue grave, con shock, dificultad respiratoria, sangrado importante o falla de órganos; esta niña tiene signos de alarma, pero aún no un cuadro grave establecido, así que el nivel adecuado es la hospitalización en sala, no la terapia intensiva.

VILLAPEPA ENAM: Dengue con signos de alarma (dolor abdominal intenso, vómitos persistentes) = hospitalización en sala de pediatría para vigilancia e hidratación controlada. El manejo ambulatorio es solo para el dengue sin signos de alarma; la UCI se reserva para el dengue grave con shock o falla de órganos.

118. Varón de 35 años sufre trauma por aplastamiento al colapsarse una pared de concreto, permaneciendo atrapado durante aproximadamente 8 horas. Al ser rescatado presenta dolor intenso, tumefacción y adormecimiento en el muslo derecho, así como orina escasa y de color muy oscuro. Lab: creatinina 4,1 mg/dL y urea 210 mg/dL. ¿Cuál es la causa más probable de la lesión renal aguda en este paciente?

- A. Obstrucción del tracto urinario inferior por coágulos
- B. Reducción del volumen intravascular efectivo por deshidratación
- C. Necrosis tubular aguda por mioglobinuria
- D. Disminución del gasto cardíaco por hemorragia interna

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Todo el caso describe un síndrome por aplastamiento. Un músculo comprimido durante ocho horas sufre una destrucción masiva de sus fibras, la rabdomiólisis, y al romperse esas fibras liberan a la sangre su contenido, entre ellos la mioglobina, una proteína que le da a la orina ese color muy oscuro, casi como té o cola, que menciona el caso. La mioglobina que se filtra en el riñón es tóxica para los túbulos: los obstruye y los daña directamente, provocando una necrosis tubular aguda, que es el mecanismo de la falla renal aquí, con la creatinina y la urea disparadas. Por eso la causa es la necrosis tubular por mioglobinuria. La deshidratación con reducción del volumen efectivo puede contribuir en el aplastamiento, porque se secuestra líquido en el músculo lesionado, pero la causa específica y protagonista de la lesión renal en este contexto es la mioglobina, no la simple hipovolemia; la orina oscura lo delata. La obstrucción del tracto urinario por coágulos daría una uropatía obstructiva con anuria y globo vesical, no encaja con el músculo destruido y la orina pigmentada por mioglobina. La caída del gasto cardíaco por una hemorragia interna produciría un shock hipovolémico con hipotensión, pero el caso resalta la lesión muscular por aplastamiento y la orina oscura, que son la firma de la rabdomiólisis con mioglobinuria como causa del daño renal.

VILLAPEPA ENAM: Aplastamiento muscular prolongado + orina muy oscura + lesión renal aguda = rabdomiólisis con mioglobinuria que produce necrosis tubular aguda. La mioglobina liberada del músculo destruido obstruye y daña los túbulos; la orina color té o cola es su marca característica.

119. Secundigesta de 31 semanas, acude a emergencia por convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Examen: PA: 160/105 mmHg, FC: 72x'. Abdomen: AU 29 cm, FCF: 144 x'. SPP: LPD. Se administra sulfato de magnesio y se inicia tratamiento antihipertensivo, lográndose estabilización hemodinámica y neurológica. No hay signos de desprendimiento prematuro de placenta ni sufrimiento fetal agudo. ¿Cuál es la conducta obstétrica a seguir?

- A. Culminación de la gestación
- B. Monitoreo materno fetal
- C. Inducción con oxitocina
- D. Conducta expectante

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El diagnóstico es una eclampsia: una gestante con hipertensión que convulsiona. Lo primero, que ya se hizo bien, es estabilizar a la madre, controlar las convulsiones con sulfato de magnesio y bajar la presión con antihipertensivos. Pero hay que entender el principio de fondo: la eclampsia, como toda la enfermedad hipertensiva grave del embarazo, solo se cura terminando la gestación, porque su origen está en la placenta y mientras el embarazo continúe la enfermedad puede volver a descompensarse y poner en riesgo la vida de la madre. Por eso, una vez estabilizada la paciente, la conducta obstétrica definitiva es culminar la gestación, es decir terminar el embarazo, independientemente de que solo tenga treinta y una semanas; el bienestar materno manda. La conducta expectante, esperar sin terminar el embarazo, sería lo indicado en cuadros hipertensivos leves y controlados en fetos muy prematuros, pero no después de una eclampsia, donde prolongar el embarazo es peligroso. El monitoreo materno-fetal es parte del cuidado continuo, pero no es una conducta definitiva ni

resuelve la eclampsia; vigilar sin terminar el embarazo deja activa la enfermedad. La inducción con oxitocina es una forma de culminar la gestación por vía vaginal, pero como opción aislada no responde a la pregunta sobre la conducta, que es la decisión de terminar el embarazo; la vía, inducción o cesárea, se elige después según las condiciones obstétricas, pero lo esencial es que la gestación debe culminar.

VILLAPEPA ENAM: Eclampsia estabilizada con sulfato de magnesio y antihipertensivo = culminar la gestación, porque la enfermedad hipertensiva grave solo se cura terminando el embarazo, sin importar la edad gestacional. La conducta expectante es para cuadros leves controlados, no tras una convulsión ecláptica.

120. Varón de 45 años presenta astenia, equimosis frecuentes y palidez progresiva. Hemograma: anemia, trombocitopenia y leucocitosis con blastos circulantes. En médula ósea se observan blastos con gránulos azurófilos citoplasmáticos. ¿Cuál es el hallazgo morfológico típico que confirma el linaje mieloide en esta neoplasia?

- A. Células de Reed-Sternberg binucleadas con nucléolos prominentes
- B. Linfocitos atípicos grandes con citoplasma abundante basófilo
- C. Plasmocitos maduros con núcleo excéntrico y cromatina en rueda de carro
- D. Bastones de Auer en el citoplasma de los blastos mieloides

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El cuadro es una leucemia aguda: la médula está tomada por blastos que desplazan a las células normales, lo que produce anemia, plaquetas bajas con los moretones fáciles, y blastos circulando en la sangre. La pregunta pide el hallazgo que confirma que esos blastos son de estirpe mieloide, y ese es el bastón de Auer, una estructura alargada en forma de aguja o astilla que se ve dentro del citoplasma de los blastos y que resulta de la fusión anómala de los gránulos azurófilos. Encontrar bastones de Auer es prácticamente la firma de la leucemia mieloide aguda, porque solo aparecen en las células de linaje mieloide; por eso confirman el diagnóstico. Las células de Reed-Sternberg, grandes y con dos núcleos que parecen ojos de búho, son el sello del linfoma de Hodgkin, una enfermedad distinta de los ganglios, no de la médula mieloide. Los linfocitos atípicos grandes con citoplasma basófilo son característicos de la mononucleosis infecciosa por virus, una reacción reactiva benigna, no de una leucemia mieloide. Los plasmocitos con núcleo excéntrico y cromatina en rueda de carro pertenecen al mieloma múltiple, una neoplasia de células plasmáticas; ninguno de esos marca el linaje mieloide, que se confirma con los bastones de Auer.

VILLAPEPA ENAM: Leucemia aguda con blastos que contienen bastones de Auer (agujas azurófilas en el citoplasma) = leucemia mieloide aguda; los bastones de Auer confirman el linaje mieloide. Las células de Reed-Sternberg son de Hodgkin, los plasmocitos en rueda de carro del mieloma.

121. Primigesta acude al servicio de emergencia con su neonato de 3 días de vida. Usted constata que el neonato ha perdido 7% de su peso de nacimiento. La madre refiere que el bebé orina al menos 4 veces al día, eliminó meconio en las primeras 24 horas y actualmente presenta deposiciones amarillentas. El recién nacido se muestra activo, con buena succión, sin signos de deshidratación ni fiebre. La madre está preocupada porque el bebé “quiere mamar a cada rato” y teme no producir suficiente leche. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este caso?

- A. Iniciar extracción de leche con equipo mecánico o eléctrico
- B. Reforzar técnicas de lactancia y vigilar la evolución del peso
- C. Solicitar análisis de electrolitos séricos para descartar deshidratación

D. Indicar suplementación con fórmula cada 3 horas

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que reconocer que todo en este neonato es normal, y que la preocupación de la madre nace del desconocimiento, no de un problema real. Una pérdida del siete por ciento del peso al tercer día está dentro de lo esperado, porque el recién nacido pierde peso los primeros días y se acepta hasta alrededor del diez por ciento. Los signos de que se está alimentando bien están todos presentes: orina varias veces al día, ya eliminó el meconio y hace deposiciones amarillentas de transición, está activo y succiona bien, sin ningún dato de deshidratación. Y que quiera mamar muy seguido no es señal de poca leche, sino el comportamiento normal del lactante, que mama a demanda y con frecuencia justamente para estimular la producción. Por eso la conducta correcta es tranquilizar a la madre, reforzar la técnica de lactancia para que se sienta segura y seguir vigilando la curva de peso. Indicar suplementación con fórmula sería un error clásico: introducir fórmula sin necesidad hace que el bebé mame menos, reduce el estímulo al pecho y termina disminuyendo la producción de leche, provocando el problema que la madre teme. Iniciar extracción con equipo no está indicado en una lactancia que va bien; solo agrega complejidad. Pedir electrolitos para descartar deshidratación es innecesario en un neonato que está clínicamente bien hidratado, activo y orinando; someterlo a un análisis sin indicación no aporta nada.

VILLAPEPA ENAM: Neonato con pérdida de peso dentro de lo normal (hasta 10%), buena diuresis, deposiciones de transición y activo = lactancia adecuada; que mame seguido es normal, no falta de leche. La conducta es reforzar la técnica y vigilar el peso, nunca suplementar con fórmula, que reduce el estímulo y la producción.

122. Varón de 58 años acude a emergencia por dolor torácico opresivo de 40 minutos de duración, irradiado a brazo izquierdo, acompañado de diaforesis. Hemodinamia estable. El EKG muestra elevación del ST en derivaciones II, III y aVF. El hospital cuenta con sala de hemodinamia disponible las 24 horas. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- A. Angioplastia coronaria primaria urgente dentro de los primeros 90 minutos
- B. Angioplastia coronaria electiva luego de tener resultados de troponina
- C. Tratamiento médico conservador y reevaluar reperfusión en 12 horas
- D. Fibrinólisis intravenosa solo si el dolor persiste más de 24 horas

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El diagnóstico salta del electrocardiograma: elevación del segmento ST en las derivaciones de la cara inferior, con el dolor opresivo irradiado, la diaforesis y el tiempo de evolución, es un infarto agudo con elevación del ST. En este cuadro la arteria está ocluida y el músculo se está muriendo minuto a minuto, así que lo único que importa es abrir esa arteria lo antes posible, la reperfusión. Y aquí hay un dato que define la mejor estrategia: el hospital tiene sala de hemodinamia disponible las veinticuatro horas. Cuando existe esa capacidad y se puede hacer a tiempo, la reperfusión de elección es la angioplastia primaria, llevar al paciente al cateterismo para destapar la arteria con balón y stent, idealmente dentro de los primeros noventa minutos desde que llega. Por eso esa es la conducta. Esperar el resultado de la troponina para decidir es un error grave: el diagnóstico de infarto con elevación del ST se hace con el electrocardiograma y la clínica, y no se debe demorar la reperfusión aguardando una enzima que tarda en elevarse; el tiempo perdido es músculo perdido. El tratamiento conservador y reevaluar en doce horas condena al paciente a que se complete el infarto sin abrir la arteria. Y la fibrinólisis solo si el dolor persiste más de veinticuatro horas es doblemente incorrecto: por un lado, teniendo

hemodinamia disponible se prefiere la angioplastia, y por otro, la reperfusión se hace ya, dentro de la ventana temprana, no esperando veinticuatro horas cuando ya no serviría.

VILLAPEPA ENAM: Infarto con elevación del ST en cara inferior + hospital con hemodinamia 24 horas = angioplastia primaria urgente dentro de los primeros 90 minutos. El diagnóstico se hace con el electrocardiograma, no se espera la troponina; el tiempo perdido es músculo perdido.

123. Mujer de 23 años, sin antecedentes patológicos de importancia, consulta por secreción sanguinolenta espontánea y unilateral por el pezón derecho desde hace 2 semanas. No está embarazada ni en periodo de lactancia. Mama derecha: no se palpa masa ni adenopatías axilares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Fibroadenoma
- B. Cáncer de mama
- C. Tumor filoides
- D. Papiloma intraductal

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Lo que orienta el diagnóstico es el tipo de secreción por el pezón. Una salida de sangre por el pezón que es espontánea, aparece sin apretar, y unilateral, de un solo lado, en una mujer joven que no está embarazada ni amamantando, tiene una causa característica: el papiloma intraductal, un pequeño tumor benigno que crece dentro de un conducto de la mama y, al ser muy vascularizado y frágil, sangra hacia el conducto y produce esa telorragia. Es, de hecho, la causa más frecuente de secreción sanguinolenta por el pezón, sobre todo cuando no se palpa ninguna masa, como en este caso. Por eso es el diagnóstico más probable. El cáncer de mama también puede dar secreción sanguinolenta, y siempre hay que tenerlo en mente y descartarlo, pero es mucho menos probable a los veintitrés años, sin masa ni ganglios; el papiloma explica mejor el cuadro en una mujer tan joven. El fibroadenoma es el tumor benigno más común en jóvenes, pero se presenta como un nódulo firme, móvil e indoloro que se palpa, no como una secreción sanguinolenta sin masa. El tumor filóide también es una masa palpable, generalmente de crecimiento rápido, no una telorragia aislada; el patrón de sangrado espontáneo unilateral por el pezón sin masa apunta al papiloma intraductal.

VILLAPEPA ENAM: Secreción sanguinolenta espontánea y unilateral por el pezón, sin masa palpable, en mujer joven = papiloma intraductal, la causa más frecuente de telorragia. El fibroadenoma y el tumor filóides se presentan como masa palpable; el cáncer es menos probable a esta edad pero siempre se descarta.

124. Varón de 54 años, hace 24 horas inicia dolor abdominal tipo cólico, vómitos, distensión abdominal y no elimina flatos. Examen: PA 100/60 mmHg, FC 110x', FR 25x', T 38.5 °C. Abdomen: distendido, timpánico y doloroso. En región inguinal derecha se palpa una masa irreductible, muy dolorosa, con piel eritematosa y tensa, más dolorosa que el resto del abdomen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Diverticulitis Aguda
- B. Apendicitis Aguda complicada
- C. Sarcoma región inguinal
- D. Hernia inguinal estrangulada

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que unir dos cosas: un cuadro de obstrucción intestinal y una masa inguinal con signos de sufrimiento. Por un lado, el paciente tiene todos los signos de obstrucción del intestino: dolor cólico, vómitos, distensión y ausencia de eliminación de gases. Por otro, en la ingle derecha se palpa una masa que ya no se puede reintroducir, es decir irreductible, exquisitamente dolorosa, con la piel roja y tensa, y más dolorosa que el resto del abdomen. Esa masa inguinal irreductible con signos inflamatorios y dolor intenso, en el contexto de una obstrucción intestinal y con fiebre, es una hernia inguinal estrangulada: un asa de intestino quedó atrapada en el saco herniario, se comprometió su irrigación y está sufriendo, lo que explica a la vez la obstrucción y el dolor local intenso con eritema. Por eso es el diagnóstico. La apendicitis aguda complicada da dolor en la fosa ilíaca derecha, pero no produce una masa inguinal irreductible con eritema ni el cuadro obstructivo por atrapamiento herniario. La diverticulitis aguda se localiza típicamente en la fosa ilíaca izquierda y tampoco explica la masa inguinal estrangulada. El sarcoma de la región inguinal sería una masa de crecimiento lento y progresivo, sin el dolor agudo, el eritema ni la obstrucción intestinal de este caso; el conjunto de hernia irreductible dolorosa con eritema más obstrucción y fiebre es la estrangulación.

VILLAPEPA ENAM: Obstrucción intestinal + masa inguinal irreductible, muy dolorosa, con piel eritematosa y tensa + fiebre = hernia inguinal estrangulada (asa atrapada con compromiso vascular). La apendicitis y la diverticulitis no dan masa inguinal irreductible; el sarcoma es de crecimiento lento sin obstrucción aguda.

125. Niño de 6 años, acude a emergencia por fiebre de 2 semanas y sangrado nasal. Dolor intenso en ambas piernas. Infecciones respiratorias altas a repetición en los últimos meses. Examen: FR 32x', FC 100x', palidez marcada de piel y mucosas, múltiples lesiones purpúricas en piernas y muslos, dolor a la palpación de tibias y esplenomegalia 3 cm por debajo del reborde costal. No se palpan adenomegalias cervicales significativas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Mononucleosis infecciosa
- B. Leucemia linfoblástica
- C. Púrpura trombocitopénica
- D. Linfoma no Hodgkin

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Todo el cuadro apunta a que la médula ósea de este niño está tomada por células malignas que desplazan a las normales, y eso produce fallo de las tres líneas de la sangre a la vez. La anemia explica la palidez marcada; la falta de plaquetas, el sangrado nasal y las lesiones purpúricas en las piernas; y la falta de defensas normales, las infecciones respiratorias repetidas y la fiebre prolongada. A esto se suman dos hallazgos muy sugestivos en un niño: el dolor óseo intenso en las piernas, con las tibias dolorosas a la palpación, que se debe a la médula repleta de blastos que la expande, y la esplenomegalia por infiltración. Ese conjunto, pancitopenia con dolor óseo y esplenomegalia en un niño, es el retrato de la leucemia linfoblástica aguda, que además es la leucemia y el cáncer más frecuente de la infancia. La púrpura trombocitopénica solo baja las plaquetas y da sangrado, pero no produce anemia, ni fiebre prolongada, ni dolor óseo, ni esplenomegalia; no explica el compromiso de todas las series. La mononucleosis infecciosa cursa con fiebre, ganglios y a veces bazo grande, pero no con la pancitopenia ni el dolor óseo de una médula infiltrada. El linfoma no Hodgkin suele presentarse con masas ganglionares o tumorales, y aquí justamente no hay adenomegalias significativas, mientras que el compromiso medular con dolor óseo y las tres series caídas señala la leucemia.

VILLAPEPA ENAM: Niño con fiebre prolongada + sangrado y púrpura + palidez (anemia) + dolor óseo con tibias dolorosas + esplenomegalia = leucemia linfoblástica aguda (médula infiltrada por blastos que causa pancitopenia y dolor óseo). La púrpura trombocitopénica solo baja plaquetas, sin anemia ni dolor óseo.

126. Mujer de 30 años presenta máculas acrómicas bien delimitadas en cara y dorso de manos, de 2 años de evolución, que han aumentado lentamente de tamaño. El área afectada corresponde al 5% de la superficie corporal total. No tiene comorbilidades ni tratamientos previos. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado en este caso?

- A. Corticoides tópicos de potencia media-alta aplicados de manera intermitente sobre las lesiones
- B. Inhibidores de la calcineurina tópicos exclusivamente en manos y rostro, sin otra intervención
- C. Fototerapia con rayos UVB de banda estrecha dos a tres veces por semana como monoterapia inicial
- D. Trasplante de melanocitos autólogo como primera elección terapéutica en este contexto

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El cuadro es un vitíligo, con máculas sin pigmento, bien delimitadas, y lo importante para elegir el tratamiento es que es una forma localizada: afecta solo un cinco por ciento de la superficie corporal, unas pocas zonas en la cara y el dorso de las manos. En el vitíligo localizado, el tratamiento inicial de primera línea es tópico, y la opción de arranque son los corticoides tópicos de potencia media a alta, aplicados de forma intermitente sobre las lesiones para frenar el ataque inmune contra los melanocitos y estimular la repigmentación, siempre vigilando los efectos de los corticoides sobre la piel fina. Por eso esa es la conducta inicial. Los inhibidores de la calcineurina tópicos son una excelente alternativa, sobre todo en zonas delicadas como la cara y los pliegues, donde evitan el adelgazamiento que pueden causar los corticoides, pero se plantean como opción dentro del mismo escalón tópico, no como la única intervención posible; el tratamiento inicial estándar de primera línea son los corticoides tópicos. La fototerapia con luz ultravioleta de banda estrecha es muy eficaz, pero se reserva para el vitíligo más extenso o generalizado, no para una forma localizada de pocas lesiones como monoterapia de inicio. El trasplante de melanocitos es un procedimiento quirúrgico reservado para casos estables y resistentes a los tratamientos médicos; usarlo como primera elección en una paciente que nunca recibió tratamiento tópico es totalmente desproporcionado.

VILLAPEPA ENAM: Vitíligo localizado (pocas lesiones, 5% de superficie) = tratamiento inicial tópico, con corticoides tópicos de potencia media-alta de primera línea (los inhibidores de calcineurina son alternativa en cara). La fototerapia se reserva para formas extensas y el trasplante para casos estables refractarios.

127. Primigesta de 37 semanas con diagnóstico de enfermedad de Von Willebrand tipo 1. En el tercer trimestre presenta niveles bajos de los factores de VonWillebrand y VIII. Se encuentra en trabajo de parto espontáneo, con feto en presentación cefálica y sin otras complicaciones obstétricas. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a la vía de parto?

- A. Cesárea de emergencia con ácido tranexámico
- B. Parto vaginal con concentrados de VWF/FVIII
- C. Parto vaginal instrumentado
- D. Cesárea programada en ausencia de indicación obstétrica

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que separar dos decisiones que a veces se confunden: la vía de parto y la prevención del sangrado. Sobre la vía, la enfermedad de Von Willebrand por sí sola no es una indicación para hacer cesárea; si la paciente está en trabajo de parto espontáneo, con el feto en cefálica y sin ninguna complicación obstétrica, la vía de elección es el parto vaginal, porque además una cesárea es una cirugía que en una paciente con trastorno de la

coagulación añade más riesgo de sangrado, no menos. Sobre la prevención, como tiene los factores bajos y por tanto riesgo de hemorragia, se la cubre administrando concentrados que reponen el factor de Von Willebrand y el factor ocho, para que llegue al parto con niveles hemostáticos seguros. Por eso la conducta correcta es parto vaginal apoyado con esos concentrados. La cesárea de emergencia no está indicada porque no hay ninguna urgencia obstétrica que la justifique, y operar a una paciente con coagulopatía suma riesgo hemorrágico. La cesárea programada en ausencia de indicación obstétrica es igual de innecesaria: someterla a cirugía sin motivo aumenta el peligro de sangrado en vez de reducirlo. El parto vaginal instrumentado, con fórceps o ventosa, se evita en la medida de lo posible en estas pacientes porque los instrumentos aumentan el riesgo de hemorragia y de traumatismo, sobre todo en un feto que podría heredar la enfermedad; lo indicado es el parto vaginal cubierto con los factores, reservando la instrumentación solo si hubiera una indicación obstétrica.

VILLAPEPA ENAM: La enfermedad de Von Willebrand no es indicación de cesárea: con trabajo de parto espontáneo, feto cefálico y sin complicación obstétrica, la vía es el parto vaginal, cubierto con concentrados de factor de Von Willebrand y factor VIII. La cesárea sin indicación añade riesgo de sangrado; se evita el parto instrumentado.

128. Mujer de 25 años presenta desde hace 3 días deposiciones líquidas abundantes, en las últimas 24 horas náuseas y vómitos. Actualmente no tolera líquidos y en las últimas 12 horas no ha miccionado. Examen: deshidratada, irritable, mal estado general, no edemas. Lab: Hb 13 g/dL, leucocitos 7 500/mm³, glucosa 78 mg/dL, urea 130 mg/dL, creatinina 2,5 mg/dL. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- A. Diálisis de emergencia
- B. Administrar diuréticos IV
- C. Solución salina IV
- D. Derivar a nefrología

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El origen de la falla renal aquí es claramente la falta de volumen. La paciente lleva tres días de diarrea abundante, luego vómitos, ya no tolera líquidos y dejó de orinar; está deshidratada y con la urea y la creatinina elevadas. Esa lesión renal aguda es de tipo prerrenal: el riñón no está intrínsecamente dañado, simplemente no le llega sangre suficiente porque el cuerpo perdió mucho líquido y el volumen circulante cayó. La conducta que corrige la causa es reponer ese volumen, y por eso lo primero y esencial es administrar suero salino por vía intravenosa para rehidratarla; al restaurar el volumen se restablece el flujo al riñón y la función renal se recupera. Por eso es la respuesta. La diálisis de emergencia se reserva para complicaciones que amenazan la vida y no responden al tratamiento, como una hiperkalemia grave, una acidosis severa o una sobrecarga de líquido; nada de eso hay aquí, y dializar a una paciente que lo que necesita es líquido sería un error. Dar diuréticos es exactamente lo contrario de lo que se necesita: forzar la eliminación de más líquido en alguien que ya está deshidratado empeoraría la hipovolemia y la falla renal. Derivar a nefrología sin antes iniciar la rehidratación demora el tratamiento simple y urgente que resuelve el problema; primero se repone el volumen con suero, que es la medida que salva el riñón.

VILLAPEPA ENAM: Diarrea y vómitos con deshidratación, oliguria y elevación de urea y creatinina = lesión renal aguda prerrenal por hipovolemia. La conducta inicial es reponer volumen con suero salino intravenoso, que restaura el flujo renal. Los diuréticos empeorarían la hipovolemia y la diálisis no está indicada.

129. Puérpera de 2 semanas post cesárea, portadora de VIH en tratamiento antirretroviral, con lactancia materna exclusiva, acude por fiebre de 38,5 °C, dolor y enrojecimiento en mama derecha. Examen: mama

derecha indurada y muy dolorosa en su cuadrante súpero externo. El recién nacido está sano y continúa recibiendo profilaxis según esquema. ¿Cuál es la indicación más adecuada respecto a la lactancia materna?

- A. Mantener lactancia materna bilateral
- B. Suspender la lactancia materna de ambos senos
- C. Vendaje de mamas bilateral
- D. Mantener lactancia materna del seno sano

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay un principio de fondo que ordena todo el caso: en una madre con VIH que tiene acceso a fórmula y agua segura, la recomendación es no dar lactancia materna, porque la leche puede transmitir el virus al bebé. Ya de base esta madre no debería estar amamantando de forma exclusiva. Y ahora aparece un agravante: una mastitis en la mama derecha, con fiebre, dolor e induración. La mastitis rompe la barrera del tejido mamario y aumenta la cantidad de virus que pasa a la leche, elevando todavía más el riesgo de transmisión al recién nacido. Por eso la indicación correcta es suspender la lactancia materna de ambos senos y alimentar al bebé con fórmula, además de tratar la mastitis. Mantener la lactancia de los dos pechos va en contra de la recomendación para la madre con VIH y encima expone al niño a través de la mama infectada. Mantener la lactancia solo del seno sano tampoco resuelve el problema de fondo: aunque se evite el pecho con mastitis, la madre con VIH no debe amamantar por el riesgo del propio virus, así que dar de un solo lado sigue exponiendo al bebé. El vendaje de mamas es una medida para suprimir la producción de leche cuando se decide no amamantar, pero por sí solo no es la indicación respecto a la lactancia; la conducta es suspenderla en ambos senos y pasar a fórmula.

VILLAPEPA ENAM: Madre con VIH y acceso a fórmula no debe dar lactancia materna por el riesgo de transmisión, y una mastitis aumenta aún más la carga viral en la leche. La indicación es suspender la lactancia de ambos senos y usar fórmula; dar solo del seno sano no elimina el riesgo del propio virus.

130. Varón de 35 años sufre explosión de gas doméstico. 6 horas después lesión en la cara anterior del muslo derecho con superficie seca, dura, textura coriácea, color blanco grisáceo, sin vesículas, no sangrado al pinchar con aguja y no dolor a la palpación. La perfusión distal es adecuada y no hay compromiso sistémico. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- A. Considerarla quemadura de espesor parcial profundo y esperar 10–14 días de manejo conservador
- B. Clasificarla como quemadura de espesor total y programar desbridamiento quirúrgico temprano
- C. Clasificarla como quemadura superficial y solo indicar cremas hidratantes y fotoprotección
- D. Tratarla como quemadura de espesor parcial superficial con curaciones tópicas y analgésicos

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Cada característica de la lesión indica que la quemadura destruyó toda la piel. Es seca, dura y con textura coriácea, como cuero, formando una escara; su color es blanco grisáceo, no el rojo de una quemadura superficial; no tiene vesículas, que son propias de las quemaduras parciales; no sangra al pincharla, porque los vasos de la dermis están coagulados; y, el dato más revelador, no duele a la palpación, porque las terminaciones nerviosas de la piel fueron completamente destruidas. Una quemadura seca, coriácea, blanca, sin ampollas, que no sangra y que es indolora es una quemadura de espesor total, que atraviesa toda la epidermis y la dermis. Y como todo el grosor de la piel está muerto, esta quemadura no puede curar sola desde los bordes en un plazo

razonable: necesita que se retire quirúrgicamente el tejido necrótico y se cubra con un injerto, es decir un desbridamiento quirúrgico temprano. Por eso esa es la conducta. Clasificarla como espesor parcial profundo y esperar dos semanas de manejo conservador subestima la profundidad: una quemadura de espesor total no epiteliza sola, y esperar solo retrasa el tratamiento y favorece la infección. Llamarla superficial e indicar cremas hidratantes es un error grave de gradación, porque una lesión indolora, coriácea y que no sangra no tiene nada de superficial. Y tratarla como parcial superficial con curaciones y analgésicos también desconoce que la piel está totalmente destruida y que el paciente ni siquiera siente dolor en la zona; lo que corresponde es reconocer el espesor total y llevarla a cirugía.

VILLAPEPA ENAM: Quemadura seca, coriácea, blanco-grisácea, sin vesículas, que no sangra al pincharla y es indolora = quemadura de espesor total (destruye toda la piel y las terminaciones nerviosas). No epiteliza sola: requiere desbridamiento quirúrgico temprano e injerto. La indolora y sin sangrado nunca es superficial.

131. En un centro de salud rural se atiende a un lactante de 6 meses traído por sus padres tras haber sido encontrado inconsciente, sumergido parcialmente en un canal de riego. El traslado tomó aproximadamente 45 minutos. Examen: lactante inconsciente, sin respuesta al dolor, ausencia de respiración y de pulso central, temperatura corporal muy baja al tacto, pupilas moderadamente dilatadas, córneas transparentes, ni signos de rigor mortis. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A. Desfibrilación inmediata
- B. No iniciar RCP
- C. Iniciar únicamente ventilación con oxígeno
- D. Iniciar de inmediato RCP

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay una regla de oro en el ahogamiento con hipotermia que resuelve este caso: no se declara muerto a un paciente frío hasta que se lo haya recalentado. El frío profundo baja tanto el metabolismo del cerebro que lo protege, y se han recuperado sin secuelas pacientes que estuvieron mucho tiempo en paro por sumersión en agua fría. Este lactante está en paro, sin respiración ni pulso, y muy frío, pero, y esto es clave, no tiene ninguno de los signos de muerte irreversible: las córneas siguen transparentes y no hay rigor mortis. Eso significa que no se puede asumir que esté muerto solo por el paro y la hipotermia, y por eso la conducta es iniciar de inmediato la reanimación cardiopulmonar, comprimiendo y ventilando mientras se lo recalienta. No iniciar la reanimación sería un error grave, porque se estaría abandonando a un niño que, dada la hipotermia protectora y la ausencia de signos de muerte establecida, todavía tiene posibilidades reales de recuperarse. Aplicar una desfibrilación inmediata no corresponde como primer paso, porque la desfibrilación solo sirve si el corazón está en un ritmo desfibrilable, y eso se determina durante la reanimación; primero se comprime y se ventila, y el desfibrilador se usa según el ritmo. Dar únicamente ventilación con oxígeno deja sin tratar la ausencia de pulso: si no hay circulación, ventilar solo no basta; se necesitan las compresiones torácicas para mantener el flujo de sangre, es decir la reanimación completa.

VILLAPEPA ENAM: Ahogamiento con hipotermia y sin signos de muerte irreversible (córneas claras, sin rigor mortis) = iniciar de inmediato reanimación cardiopulmonar mientras se recalienta. Nadie está muerto hasta estar caliente y muerto: el frío protege el cerebro y hay recuperaciones tras paros prolongados en agua fría.

132. Mujer de 62 años, con lesión superficial en cuerpo gástrico detectada por endoscopia alta. Biopsia: adenocarcinoma bien diferenciado limitado a mucosa/submucosa, se interpreta como cáncer gástrico temprano. Se solicita ecoendoscopia (EUS) para detectar:

- A. carcinomatosis peritoneal difusa.
- B. metástasis en ganglios perihepáticos.
- C. extensión de la cadena linfática.
- D. compromiso de las capas gástricas.

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Para entender qué aporta la ecoendoscopia hay que saber qué ve mejor que ningún otro estudio: la ecoendoscopia combina el endoscopio con una sonda de ultrasonido en su punta, así que mira la pared del estómago desde adentro y por capas, y puede decir con precisión hasta qué profundidad llegó el tumor. En un cáncer gástrico temprano, la pregunta clave es exactamente esa: si la lesión está limitada a la mucosa o si ya invadió la submucosa, porque de ese dato depende el tratamiento. Si es muy superficial, se puede resear por vía endoscópica sin cirugía; si invade más profundo, hace falta cirugía. Por eso la ecoendoscopia se solicita para determinar el compromiso de las capas de la pared gástrica, es decir la profundidad de invasión. La carcinomatosis peritoneal difusa, la siembra del tumor por el peritoneo, no es lo que evalúa la ecoendoscopia; eso se busca con tomografía o laparoscopia. Las metástasis en ganglios perihepáticos, es decir a distancia, tampoco son el objetivo de este estudio, que se centra en la pared y los ganglios inmediatamente adyacentes, no en la enfermedad diseminada. La extensión de la cadena linfática regional puede valorarse en parte con la ecoendoscopia, pero en el cáncer temprano el dato decisivo que se busca y que define la conducta es la profundidad, cuánto penetró el tumor en las capas gástricas, que separa la resección endoscópica de la cirugía.

VILLAPEPA ENAM: En el cáncer gástrico temprano, la ecoendoscopia se solicita para determinar el compromiso de las capas de la pared gástrica (profundidad de invasión, si está en mucosa o llega a submucosa), dato que decide entre resección endoscópica y cirugía. La carcinomatosis y las metástasis se buscan con tomografía o laparoscopia.

133. En un hospital de referencia se registran todos los pacientes atendidos durante un año con una misma enfermedad rara, describiendo sus características clínicas, evolución y tratamientos recibidos, sin asignar intervenciones experimentales ni grupo de comparación. ¿Qué tipo de diseño describe mejor este estudio?

- A. Serie de casos
- B. Clínico controlado
- C. Cohorte analítico
- D. Transversal analítico

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que fijarse en lo que el estudio hace y en lo que no hace. Lo que hace es reunir a un grupo de pacientes que comparten la misma enfermedad y describir cómo son: sus características clínicas, su evolución y qué tratamientos recibieron. Lo que no hace es igual de importante: no asigna ninguna intervención experimental y no tiene un grupo de comparación. Un estudio que solo describe a una colección de pacientes con la misma condición, sin comparar con nadie y sin intervenir, es una serie de casos, el diseño descriptivo que sirve justamente para caracterizar enfermedades raras o poco conocidas. Por eso es la respuesta. El ensayo clínico controlado es lo opuesto: asigna deliberadamente una intervención a los pacientes y los compara con un grupo control, y aquí no hay ni intervención asignada ni control. El estudio de cohorte analítico sigue en el tiempo a grupos con distinta exposición para comparar la aparición de un desenlace, es decir requiere comparación entre expuestos y no expuestos, algo que este estudio no tiene. El estudio transversal analítico mide exposición y

desenlace en un momento puntual y busca asociaciones comparando grupos, mientras que aquí no se establece ninguna comparación ni se busca una asociación, solo se describe; el diseño puramente descriptivo de una colección de pacientes es la serie de casos.

VILLAPEPA ENAM: Describir a un grupo de pacientes con la misma enfermedad, su clínica, evolución y tratamiento, sin grupo de comparación ni intervención asignada = serie de casos (diseño descriptivo). El ensayo controlado asigna intervención; la cohorte y el transversal analítico requieren comparación entre grupos.

134. Puérpera de 3 días post cesárea segmentaria de emergencia, acude por dolor cada vez más intenso y constante en el hemiabdomen inferior. Examen: PA 90/60 mmHg, FC 134 x', T 39 °C. Abdomen: útero a 2 cm por encima de la cicatriz umbilical, con dolor a la palpación. Especuloscopia: loquios con mal olor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Tromboflebitis pélvica
- B. Infección del trato urinario
- C. Endometritis puerperal
- D. Infección del sitio operatorio

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Los signos apuntan directamente al útero como foco de la infección. Esta puérpera tras una cesárea de urgencia, que es un factor de riesgo, presenta fiebre alta con taquicardia, y al examinar el abdomen el útero está más grande de lo esperado para el tercer día, subinvolucionado, y doloroso a la palpación. El dato que cierra el diagnóstico es que los loquios, la secreción que sale del útero en el puerperio, tienen mal olor, lo que indica que están infectados. La combinación de fiebre, útero doloroso y subinvolucionado, y loquios fétidos es el cuadro clásico de la endometritis puerperal, la infección del endometrio y la cavidad uterina, que es la causa más frecuente de fiebre puerperal, sobre todo después de una cesárea. Por eso es el diagnóstico. La infección del sitio operatorio comprometería la herida de la cesárea, con dolor, enrojecimiento y secreción en la incisión de la pared abdominal, no un útero doloroso con loquios malolientes; el foco estaría en la herida, no en el útero. La infección urinaria daría síntomas urinarios como ardor o dolor lumbar con puñopercusión positiva, y no explica el útero doloroso ni los loquios fétidos. La tromboflebitis pélvica se sospecha cuando la fiebre persiste a pesar de tratar la endometritis con antibióticos, es un diagnóstico posterior y de exclusión; el cuadro inicial de fiebre con útero doloroso y loquios malolientes es la endometritis puerperal.

VILLAPEPA ENAM: Puérpera con fiebre + útero subinvolucionado y doloroso + loquios de mal olor, sobre todo tras cesárea = endometritis puerperal, la causa más frecuente de fiebre puerperal. La infección del sitio operatorio compromete la herida; la tromboflebitis pélvica es una fiebre que persiste pese a tratar la endometritis.

135. Gestante de 39 semanas, sin comorbilidades conocidas, acude para evaluación del bienestar fetal. Se realiza una prueba de estrés con oxitocina que muestra: 3 contracciones uterinas en 10 minutos, con intensidad adecuada y una frecuencia cardíaca fetal basal de 140-150 latidos por minuto, sin desaceleraciones tardías ni variables significativas. ¿Cómo debe informarse el resultado de esta prueba?

- A. Positivo
- B. Dudoso
- C. Negativo

D. Insatisfactorio

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La prueba de estrés con contracciones evalúa cómo tolera el feto el esfuerzo de las contracciones, que reducen transitoriamente el flujo de sangre a la placenta; si la reserva placentaria es buena, el feto lo aguanta sin problemas, y si está comprometida, aparecen desaceleraciones de la frecuencia cardíaca. Aquí la prueba se realizó de forma adecuada, con tres contracciones en diez minutos de buena intensidad, y el feto respondió muy bien: la frecuencia cardíaca se mantuvo normal y, el dato clave, no hubo desaceleraciones tardías ni variables significativas. La ausencia de desaceleraciones tardías frente a contracciones adecuadas significa que el feto tolera bien el estrés y que su oxigenación está conservada, y ese resultado tranquilizador se informa como negativo. Hay que tener cuidado con la lógica invertida de esta prueba: negativo es lo bueno. Positivo sería el resultado malo, el que muestra desaceleraciones tardías repetidas que indican sufrimiento fetal y compromiso de la oxigenación, justo lo que este feto no tiene. Dudoso se reservaría para trazados intermedios con desaceleraciones ocasionales que no permiten clasificar con claridad, tampoco el caso porque aquí no hubo ninguna. Insatisfactorio se informa cuando la prueba no se pudo interpretar bien, por ejemplo por contracciones insuficientes o un registro de mala calidad, pero en este caso la prueba fue técnicamente adecuada y perfectamente valorable, con un resultado claramente tranquilizador, es decir negativo.

VILLAPEPA ENAM: Prueba de estrés con contracciones adecuadas y SIN desaceleraciones tardías = resultado negativo, que es lo tranquilizador (buena reserva placentaria). Ojo con la lógica invertida: positivo es lo malo (desaceleraciones tardías, sufrimiento fetal); insatisfactorio es cuando la prueba no se pudo interpretar.

136. Niño de 4 años, previamente sano, acude por edema generalizado. Al examen se evidencia anasarca. Los exámenes muestran proteinuria masiva, hipoalbuminemia e hiperlipidemia, compatibles con síndrome nefrótico. Se inicia prednisona 60 mg/m² al día por 6 semanas y luego 40 mg/m² en días alternos. A las 8 semanas no hay remisión clínica y la proteinuria en orina de 24 horas es de 80 mg/m²/h. ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir?

- A. Suspender prednisona e iniciar ciclofosfamida
- B. Indicar estudio genético
- C. Agregar micofenolato (mofetil)
- D. Solicitar biopsia renal

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El punto de inflexión es que este síndrome nefrótico no respondió a un curso completo y correcto de corticoides. En un niño pequeño, el síndrome nefrótico casi siempre es por enfermedad de cambios mínimos, que responde muy bien a la prednisona, así que se trata primero sin biopsia. Pero cuando, como aquí, se cumplen las ocho semanas de corticoides a dosis adecuadas y no hay remisión, con la proteinuria todavía en rango masivo, se define como un síndrome nefrótico corticorresistente, y eso cambia todo: la falta de respuesta sugiere que no es una enfermedad de cambios mínimos sino otra lesión, como una glomeruloesclerosis focal, que se ve distinta al microscopio y tiene otro pronóstico y tratamiento. Por eso, antes de escalar a cualquier fármaco más fuerte, hay que saber exactamente qué enfermedad hay en el riñón, y para eso se solicita la biopsia renal, que da el diagnóstico histológico y orienta el tratamiento. Suspender la prednisona e iniciar ciclofosfamida sin biopsia sería tratar a ciegas, poniendo un inmunosupresor potente sin saber qué se está tratando. Agregar micofenolato tiene el mismo problema: escalar la inmunosupresión antes de tener el diagnóstico que la justifique. El estudio genético puede ser útil en algunos casos de corticorresistencia, sobre todo en los muy precoces o familiares,

pero no es el paso inmediato estándar; lo primero ante la corticorresistencia es la biopsia renal para ver la histología y decidir sobre esa base.

VILLAPEPA ENAM: Síndrome nefrótico del niño que no remite tras 8 semanas de corticoides adecuados = corticorresistente, y el paso obligatorio es la biopsia renal para conocer la histología (probable glomeruloesclerosis focal, no cambios mínimos) antes de escalar a ciclofosfamida o micofenolato.

137. Según la Norma Técnica de Salud del Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) de la niña y el niño menor de cinco años. ¿Cuál es el objetivo principal de esta intervención en el primer nivel de atención?

A. Registrar periódicamente los indicadores antropométricos del niño para contar con una curva de crecimiento individual como requisito administrativo de la historia clínica

B. Garantizar de forma prioritaria la entrega de suplementos nutricionales y vacunas al niño para disminuir las tasas de desnutrición y enfermedades inmunoprevenibles.

C. Vigilar de manera continua e integral el crecimiento y desarrollo de la niña y el niño para detectar oportunamente riesgos o alteraciones y establecer acciones de prevención y promoción de la salud

D. Realizar únicamente la evaluación nutricional y el examen físico del niño para identificar signos clínicos de desnutrición o enfermedad aguda.

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El control de crecimiento y desarrollo tiene un propósito amplio e integral, y hay que reconocerlo frente a las versiones recortadas. Su objetivo es vigilar de forma continua y global cómo crece y cómo se desarrolla el niño, no solo su peso y talla, sino también su desarrollo psicomotor, su alimentación, sus vacunas y su entorno, para detectar a tiempo cualquier riesgo o alteración y actuar con acciones de prevención y de promoción de la salud. Esa mirada integral y anticipatoria, que busca los problemas temprano para prevenirlos, es la esencia del control, y por eso la respuesta correcta es la que describe la vigilancia continua e integral con detección oportuna y acciones de prevención y promoción. Reducir el control a registrar los datos antropométricos como un requisito administrativo de la historia clínica lo empobrece: el registro es una herramienta, no el objetivo, y verlo como trámite pierde todo su sentido preventivo. Decir que su objetivo prioritario es entregar suplementos y vacunas confunde algunas de sus actividades con su propósito: la suplementación y la vacunación forman parte del control, pero no lo definen; el fin es la vigilancia integral del desarrollo. Y limitarlo a la evaluación nutricional y el examen físico para detectar desnutrición o enfermedad aguda deja fuera toda la dimensión del desarrollo psicomotor y de la promoción de la salud que hace del control una intervención integral.

VILLAPEPA ENAM: El objetivo del control de crecimiento y desarrollo es vigilar de forma continua e integral el crecimiento y el desarrollo del niño para detectar oportunamente riesgos y realizar acciones de prevención y promoción. El registro, la suplementación o el examen físico son partes de esa intervención, no su objetivo.

138. Varón 22 años, acude a establecimiento de primer nivel de atención porque desde hace 24 horas tiene dolor abdominal periumbilical, náusea y vómitos. Examen: T 38.7°C, dolor en fosa iliaca derecha, Blumberg (+). ¿Cuál es la conducta a seguir?

A. Antibióticos IV, analgesia y observación en el establecimiento

B. Hidratación, antibióticos IV, referencia a centro de mayor complejidad

C. Solicitar exámenes auxiliares y de acuerdo a resultados referenciar

D. Ayuno, analgesia y referencia diferida según evolución

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El cuadro es una apendicitis aguda de manual: el dolor que empezó alrededor del ombligo y migró a la fosa ilíaca derecha, con náuseas, vómitos, fiebre y el signo de Blumberg positivo, que indica irritación del peritoneo. Y el diagnóstico es clínico, no hace falta esperar exámenes para reconocerlo. La clave del caso es dónde está el paciente: un establecimiento de primer nivel, que no tiene capacidad quirúrgica. La apendicitis se trata operando, así que lo que corresponde es preparar al paciente para esa cirugía y llevarlo a donde puedan hacerla. Por eso la conducta es estabilizarlo e iniciar el manejo, con hidratación y antibióticos intravenosos, y referirlo de inmediato a un centro de mayor complejidad que cuente con cirujano y quirófano. Dar antibióticos y analgesia y solo observar en el mismo establecimiento es peligroso, porque un apéndice inflamado puede perforarse mientras se lo vigila en un lugar que no puede operarlo; observar no reemplaza a la cirugía. Solicitar exámenes auxiliares y referir según los resultados retrasa una derivación que ya está indicada por la clínica: con un cuadro tan claro, esperar análisis en el primer nivel solo hace perder tiempo. La analgesia con referencia diferida según la evolución es aún más riesgosa, porque diferir el traslado de una apendicitis expone a la perforación y la peritonitis; lo correcto es estabilizar y referir sin demora.

VILLAPEPA ENAM: Apendicitis aguda (dolor migratorio a fosa ilíaca derecha, fiebre, Blumberg positivo) en primer nivel sin capacidad quirúrgica = hidratación, antibióticos intravenosos y referencia inmediata a centro con cirugía. El diagnóstico es clínico; observar o diferir el traslado expone a la perforación.

139. Mujer de 67 años, posmenopáusica, sufrió hace 6 meses fractura de radio distal tras caída desde su propia altura. La densitometría ósea (DXA) muestra T-score de -2.7 en cuello femoral. No presenta enfermedad renal crónica ni uso crónico de corticoides. Vive sola, con bajo consumo de lácteos y escasa exposición solar. En este caso. ¿Cuál es la estrategia a emplear para reducir el riesgo de nuevas fracturas en los próximos 10 años?

- A. Alendronato oral semanal más calcio/vitamina D
- B. Calcio/vitamina D y ejercicio
- C. Ácido zoledrónico anual sin calcio/vitamina D
- D. DXA anual para seguimiento y postergar tratamiento

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El diagnóstico de osteoporosis está firmemente establecido por partida doble: la densitometría muestra un puntaje de menos dos coma siete, en rango osteoporótico, y además la paciente ya tuvo una fractura por fragilidad, la del radio tras una caída desde su propia altura, que por sí sola confirma la enfermedad. Con osteoporosis y una fractura previa, el riesgo de una nueva fractura es alto y hay indicación clara de tratamiento farmacológico específico, no basta con medidas generales. El fármaco de primera línea para reducir ese riesgo son los bisfosfonatos, y el alendronato oral semanal es la opción estándar; frena la resorción del hueso y disminuye las fracturas. Pero un bisfosfonato no trabaja solo: necesita como base el calcio y la vitamina D, más aún en esta paciente que consume pocos lácteos y tiene escasa exposición al sol, factores que la ponen en riesgo de déficit. Por eso la estrategia correcta es el alendronato más calcio y vitamina D. Dar solo calcio, vitamina D y ejercicio es insuficiente cuando ya hay osteoporosis con fractura: esas medidas son el cimiento, pero no sustituyen al fármaco antirresortivo que reduce las fracturas. El ácido zoledrónico sin calcio ni vitamina D es incorrecto porque los bisfosfonatos siempre se acompañan de calcio y vitamina D, y administrarlos sin corregir el déficit puede provocar hipocalcemia. Postergar el tratamiento haciendo solo densitometrías anuales de seguimiento es inaceptable en una paciente que ya tiene la enfermedad y una fractura: esperar la deja expuesta a fracturarse de nuevo cuando hay un tratamiento eficaz disponible.

VILLAPEPA ENAM: Osteoporosis confirmada (puntaje de densitometría bajo y fractura por fragilidad) = bisfosfonato de primera línea, alendronato oral semanal, SIEMPRE acompañado de calcio y vitamina D como base. El calcio y el ejercicio solos no bastan con fractura previa, y el bisfosfonato nunca se da sin calcio y vitamina D.

140. Multigesta de 35 semanas, acude por cefalea intensa y fotopsias de inicio reciente. Examen: PA: 160/110 mmHg, AU: 32, SPP LCI. DU: ausente. Laboratorio: plaquetas 80 000/ μ L, TGO 65 UI/L, creatinina 1,4mg/dL. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A. Indicar internamiento para manejo expectante hasta las 37 semanas
- B. Hospitalizar e indicar finalización de la gestación tras estabilización materna
- C. Manejo ambulatorio con control estricto de presión arterial y ecografía seriada
- D. Iniciar corticoides antenatales y diferir el parto al menos 48 horas

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Este cuadro es una preeclampsia con criterios de severidad, y hay que reconocer que ya cruzó varias líneas de alarma. La presión está en rango severo, en 160 sobre 110, y aparecen síntomas neurológicos, cefalea intensa y fotopsias, es decir esas luces o destellos que señalan compromiso del sistema nervioso y anuncian riesgo de convulsión. A eso se suma el compromiso de otros órganos en el laboratorio: las plaquetas están bajas, las enzimas del hígado elevadas y la creatinina en aumento, un patrón que apunta incluso a un síndrome HELLP. Con tantos criterios de severidad y afectación de múltiples órganos, la única solución definitiva es terminar el embarazo, porque la enfermedad se origina en la placenta y mientras el embarazo continúe la madre sigue en peligro. Por eso la conducta es hospitalizar, estabilizar a la madre con sulfato de magnesio para prevenir la convulsión y antihipertensivos para bajar la presión, y luego finalizar la gestación. El manejo expectante hasta las treinta y siete semanas es inaceptable con criterios de severidad y órganos comprometidos: esperar dos semanas más expone a la madre a convulsiones, sangrado y daño irreversible. El manejo ambulatorio es directamente peligroso, porque una preeclampsia severa necesita hospitalización y vigilancia estrecha, no controles en casa. Iniciar corticoides y diferir el parto cuarenta y ocho horas sería razonable en un pretérmino más lejano y estable para madurar el pulmón, pero a las treinta y cinco semanas y con este grado de severidad y compromiso de órganos, el beneficio pulmonar de esperar no justifica el riesgo materno; lo prioritario es estabilizar y terminar la gestación.

VILLAPEPA ENAM: Preeclampsia con criterios de severidad (presión severa + síntomas neurológicos + plaquetopenia, enzimas hepáticas altas y creatinina elevada, patrón de HELLP) a las 35 semanas = hospitalizar, estabilizar con sulfato de magnesio y antihipertensivos, y finalizar la gestación. El manejo expectante o ambulatorio es peligroso con órganos comprometidos.

141. Secundigesta de 39 semanas con antecedente de cesárea segmentaria transversa hace 8 años, es admitida en trabajo de parto para intentar parto vaginal. Examen: AU 36 cm, SPP LCI, LCF 144 x'. Durante la fase activa, desarrolla dolor abdominal súbito muy intenso, cese de las contracciones, bradicardia fetal persistente y caída de la presión arterial materna. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A. Cesárea de emergencia
- B. Inducción con oxitocina
- C. Parto vaginal instrumentado
- D. Uso de misoprostol

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Los signos, sobre el fondo de una cicatriz uterina previa, dibujan una rotura uterina, la complicación más temida del intento de parto vaginal después de una cesárea. Fíjate en la secuencia: durante la fase activa aparece de golpe un dolor abdominal muy intenso, y luego, en lugar de continuar el parto, las contracciones cesan, porque el útero se rompió y perdió su capacidad de contraerse. A eso se suma la bradicardia fetal persistente, señal de que el feto está sufriendo por la interrupción del flujo, y la caída de la presión de la madre por la hemorragia interna que la rotura produce. Ese conjunto de dolor súbito, cese de contracciones, sufrimiento fetal y shock materno es una emergencia que amenaza a la vez la vida de la madre y del feto, y solo tiene una solución: entrar al quirófano de inmediato. Por eso la conducta es la cesárea de emergencia, para extraer al feto rápidamente y reparar o extirpar el útero roto controlando la hemorragia. La inducción con oxitocina es exactamente lo contrario de lo que se necesita: estimular un útero roto empeoraría el desgarro y la hemorragia. El uso de misoprostol tampoco tiene lugar, y de hecho los uterotónicos de inducción están contraindicados en la cicatriz uterina justamente por el riesgo de rotura. El parto vaginal instrumentado es inviable: con el útero roto, sufrimiento fetal y shock materno, no hay tiempo ni condiciones para un parto por vía vaginal; la única salida que salva a ambos es la cirugía inmediata.

VILLAPEPA ENAM: Trabajo de parto tras cesárea previa + dolor súbito intenso + cese de las contracciones + bradicardia fetal + hipotensión materna = rotura uterina. La conducta es cesárea de emergencia inmediata para salvar a madre y feto; los uterotónicos están contraindicados y empeorarían el desgarro.

142. Mujer de 55 años hospitalizada por pancreatitis aguda; Al quinto día de hospitalización presenta fiebre persistente y leucocitosis. TC abdominal páncreas con colección líquida con gas en su interior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Colección peripancreática aguda
- B. Pseudoquiste pancreático
- C. Absceso pancreático
- D. Necrosis pancreática infectada

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El dato que lo cambia todo es el gas dentro de la colección pancreática. En una pancreatitis, un páncreas que desarrolla una colección con burbujas de gas en su interior está infectado, porque ese gas lo producen las bacterias que colonizaron el tejido; el aire no debería estar ahí de forma espontánea. Sumado a la fiebre persistente y la leucocitosis, y apareciendo temprano, al quinto día, esto corresponde a una necrosis pancreática infectada, es decir el tejido pancreático que se murió durante la pancreatitis y ahora se sobreinfectó con gérmenes. Es una complicación grave que exige antibióticos y, a menudo, drenaje o desbridamiento del tejido necrótico. Por eso es el diagnóstico más probable. La colección peripancreática aguda es la acumulación de líquido de las primeras fases, pero no tiene gas ni signos de infección; el gas la descarta. El pseudoquiste pancreático es una colección con una pared bien formada que madura semanas después, no una colección con gas al quinto día, y no cursa con fiebre y leucocitosis salvo que se infecte. El absceso pancreático también es una colección infectada, pero es una entidad más tardía y encapsulada que aparece semanas después; una colección con gas que se manifiesta al quinto día, en pleno tejido necrótico, corresponde a la necrosis pancreática infectada.

VILLAPEPA ENAM: Colección pancreática con gas en su interior + fiebre y leucocitosis en los primeros días

de una pancreatitis = necrosis pancreática infectada (el gas lo producen las bacterias que colonizaron el tejido necrótico). El pseudoquiste y el absceso son colecciones más tardías y encapsuladas.

143. Mujer de 45 años, con antecedente de abscesos perianales drenados, presenta desde hace 6 meses secreción purulenta intermitente y dolor leve perianal. Examen: orificio externo a 2 cm del margen anal y, en la exploración bajo anestesia, se identifica una fistula trans esfinteriana baja, con trayecto único, que compromete menos del 30% del esfínter anal externo; la paciente no tiene incontinencia. ¿Cuál es la conducta quirúrgica más adecuada?

- A. Fistulectomía con resección completa del trayecto
- B. Fistulotomía del trayecto trans esfinteriano bajo
- C. Únicamente drenajes repetidos del orificio externo
- D. Resección amplia del esfínter anal y de la piel perianal

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La decisión gira alrededor de cuánto esfínter está en juego, porque el gran riesgo de operar una fístula anal es dañar el músculo que da la continencia. Aquí los datos son favorables: es una fístula transesfinteriana baja, con un solo trayecto, que compromete menos de un tercio del esfínter externo, y la paciente no tiene ningún problema de continencia. Cuando la fístula es baja y atraviesa solo una porción pequeña del esfínter, la técnica de elección es la fistulotomía: se abre el trayecto en toda su extensión para que cicatrice de dentro hacia fuera, seccionando esa mínima parte del músculo sin comprometer la continencia. Es el procedimiento más eficaz y curativo para las fístulas bajas. Por eso es la respuesta. La fistulectomía, que reseca por completo todo el trayecto, extirpa más tejido y puede lesionar más esfínter y dejar una herida mayor, sin ofrecer mejor resultado que la fistulotomía en una fístula baja; se prefiere abrir, no extirpar en bloque. Limitarse a drenajes repetidos del orificio externo no cura la fístula: solo alivia temporalmente sin tratar el trayecto, que seguirá supurando. La resección amplia del esfínter y de la piel perianal es una barbaridad quirúrgica: destruir el esfínter dejaría a la paciente incontinente, exactamente el daño que hay que evitar; para una fístula baja y de bajo compromiso, lo correcto y seguro es la fistulotomía.

VILLAPEPA ENAM: Fístula perianal transesfinteriana baja, de trayecto único, que compromete menos del 30% del esfínter y sin incontinencia = fistulotomía (abrir el trayecto), segura y curativa por el bajo compromiso muscular. La fistulectomía extirpa más tejido sin ventaja, y resecar el esfínter causaría incontinencia.

144. Mujer de 24 años, con menstruaciones irregulares y fecha de última regla desconocida. Acude por sangrado vaginal escaso. La ecografía transvaginal muestra saco gestacional intrauterino de 30 mm, embrión de 9 mm sin actividad cardíaca detectable y vesícula vitelina de 5 mm. ¿Cuál es el diagnóstico ecográfico correspondiente?

- A. Embarazo intrauterino muy inicial
- B. Embarazo ectópico no complicado
- C. Gestación intrauterina no viable
- D. Gestación de ubicación incierta

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La ecografía tiene criterios objetivos para decidir si un embarazo es viable o no, y aquí uno de ellos se cumple de forma clara. Se ve un embrión ya formado, que mide nueve milímetros de longitud, y no tiene latido cardíaco detectable. La regla es que cuando el embrión alcanza cierto tamaño, alrededor de siete milímetros o más, ya debería verse su corazón latiendo; si un embrión de ese tamaño o mayor no muestra actividad cardíaca, se confirma que el embarazo no es viable, es decir el embrión murió. Con un embrión de nueve milímetros sin latido, el diagnóstico es una gestación intrauterina no viable, lo que corresponde a un aborto retenido. Por eso es la respuesta. El embarazo intrauterino muy inicial se caracteriza por estructuras todavía pequeñas donde aún no se espera ver el latido, por ejemplo cuando solo hay saco o un embrión muy diminuto; aquí, en cambio, el embrión ya es lo bastante grande como para que la ausencia de latido sea diagnóstica de no viabilidad, no de precocidad. El embarazo ectópico se descarta porque la ecografía muestra el saco gestacional claramente dentro del útero, no fuera. La gestación de ubicación incierta es cuando la prueba de embarazo es positiva pero la ecografía no logra localizar el saco ni dentro ni fuera del útero; en este caso el saco está bien visible en la cavidad uterina, así que la ubicación es cierta, y con el embrión sin latido el diagnóstico es la gestación no viable.

VILLAPEPA ENAM: Embrión de tamaño suficiente (9 mm, mayor o igual a 7 mm) sin actividad cardíaca en la ecografía = gestación intrauterina no viable (aborto retenido), por criterio ecográfico. No es muy inicial porque el embrión ya debería tener latido; el saco intrauterino descarta el ectópico y la ubicación incierta.

145. Escolar de 6 años presenta desde hace 3 semanas deposiciones semilíquidas, fétidas, voluminosas, que flotan y dejan aspecto grasoso en el inodoro, acompañadas de dolor abdominal tipo cólico y distensión abdominal. En el examen coproparasitológico se observan trofozoítos binucleados. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- A. Prazicuantel
- B. Cotrimoxazol
- C. Azitromicina
- D. Metronidazol

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Dos elementos identifican al parásito. Primero, el tipo de diarrea: deposiciones grasosas, que flotan y dejan una película aceitosa, es decir esteatorrea, con distensión y dolor cólico. Eso indica malabsorción de grasas, que ocurre cuando algo recubre y daña el intestino delgado alto, donde se absorben los nutrientes. Segundo, y definitivo, el hallazgo en el examen de heces: trofozoítos binucleados, es decir formas del parásito con dos núcleos, que es la imagen clásica de la Giardia, cuyo trofozoito tiene esa característica apariencia de cara con dos núcleos que parecen ojos. Giardia se pega a la mucosa del duodeno y el yeyuno y produce justamente esa malabsorción con esteatorrea. El tratamiento de elección para la giardiasis es el metronidazol, que elimina el parásito. Por eso es la respuesta. El praziquantel es un antiparasitario para gusanos planos, como las tenias y los trematodos, no para un protozoario como la Giardia, así que no serviría aquí. El cotrimoxazol es un antibiótico usado en otras infecciones, incluidas algunas diarreas bacterianas y ciertos protozoarios, pero no es el tratamiento de la giardiasis. La azitromicina es un antibiótico para bacterias, como Campylobacter o algunos gérmenes respiratorios, y no actúa sobre la Giardia; el fármaco que la trata es el metronidazol.

VILLAPEPA ENAM: Diarrea grasosa que flota (esteatorrea) por malabsorción + trofozoítos binucleados en heces = giardiasis (Giardia se adhiere al duodeno-yeyuno). El tratamiento de elección es el metronidazol. El praziquantel es para gusanos planos y los antibióticos no actúan sobre este protozoario.

146. Niña de 3 años de edad, con un tiempo de enfermedad de 5 días, caracterizado por presentar lesiones petequiales, algunos hematomas a predominio en miembros inferiores, presenta epistaxis que no cede a pesar de taponamiento nasal, tiene un hemograma normal, plaquetas en 25 000/uL, además, una lámina periférica sin alteraciones. ¿Cuál es el tratamiento que se debe instaurar en el paciente inmediatamente?

- A. Ácido tranexámico
- B. Prednisona 2 mg/Kg/día
- C. Dexametasona 0,6 mg/kg/día
- D. Metilprednisolona 30 mg/kg/día

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El cuadro es una púrpura trombocitopénica inmune: una niña sana que de forma aguda desarrolla petequias, hematomas y sangrado, con las plaquetas muy bajas pero con el resto del hemograma normal y una lámina periférica sin alteraciones. Ese detalle es clave: al estar disminuidas solamente las plaquetas, sin afectar las otras series ni mostrar células anormales en el frotis, se descarta una leucemia u otra enfermedad de la médula, y queda como diagnóstico la destrucción inmune aislada de plaquetas. La mayoría de estos casos en niños son leves y autolimitados, pero aquí hay un sangrado activo que no se controla, la epistaxis que no cede pese al taponamiento, lo que indica la necesidad de tratamiento para subir las plaquetas. El tratamiento de primera línea en esta situación son los corticoides, y la prednisona a dos miligramos por kilo al día es el esquema estándar para frenar la destrucción inmune de plaquetas y elevar su número. Por eso es la respuesta. El ácido tranexámico es solo un antifibrinolítico que ayuda a estabilizar los coágulos y puede usarse como coadyuvante del sangrado mucoso, pero no corrige el problema de fondo, que es la trombocitopenia; por sí solo no basta. La dexametasona y la metilprednisolona a las dosis planteadas son corticoides que se usan en otros esquemas o en formas más severas o refractarias, pero el tratamiento de primera línea estandarizado para la púrpura trombocitopénica inmune del niño con sangrado es la prednisona a dos miligramos por kilo al día.

VILLAPEPA ENAM: Niña con petequias, sangrado y trombocitopenia aislada (resto del hemograma y frotis normales) = púrpura trombocitopénica inmune. Con sangrado activo que no cede, el tratamiento de primera línea son los corticoides, prednisona 2 mg/kg/día. El ácido tranexámico es solo coadyuvante y no sube las plaquetas.

147. Según norma técnica ¿Cuál es la dotación mínima de médicos requerida en un establecimiento de salud I-3 del primer nivel de atención?

- A. Un médico internista y un médico general
- B. Dos médicos generales
- C. Un médico general y un gineco-obstetra
- D. Un médico general y un médico pediatra

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que ubicar qué tipo de establecimiento es un I-3 y qué recursos humanos le corresponden. El I-3 es un centro de salud del primer nivel de atención, orientado a la atención ambulatoria de la población, y una característica fundamental del primer nivel es que trabaja con médicos generales, no con especialistas; la atención especializada pertenece al segundo y tercer nivel. Por eso su dotación mínima de médicos son médicos generales, y la norma establece dos médicos generales para el I-3, lo que le permite cubrir la atención

de su población. Las opciones que incluyen especialistas son incorrectas porque llevan la atención especializada a un nivel que no le corresponde. Un médico internista pertenece al ámbito hospitalario del segundo nivel, no a un centro de salud del primer nivel. Un gineco-obstetra es un especialista cuya atención se brinda en establecimientos de mayor complejidad con capacidad resolutive obstétrica, no en un I-3 ambulatorio. Y un médico pediatra también es un especialista propio del segundo nivel; el primer nivel atiende a los niños con médicos generales dentro de sus programas, como el control de crecimiento y desarrollo. La dotación mínima correcta para el I-3 son dos médicos generales.

VILLAPEPA ENAM: El establecimiento I-3 es un centro de salud del primer nivel, que trabaja con médicos generales, no especialistas; su dotación mínima es de dos médicos generales. Los especialistas (internista, gineco-obstetra, pediatra) corresponden al segundo y tercer nivel de atención.

148. Madre con control prenatal irregular y serología positiva para VDRL 1:32 sin tratamiento, parto vaginal con recién nacido a término. El neonato está asintomático. El VDRL en sangre de cordón es 1:64. ¿Cuál es el manejo indicado para el recién nacido?

- A. Ceftriaxona endovenosa por 7 días
- B. Observación y repetir VDRL en 1 mes
- C. Penicilina G sódica endovenosa por 10 a 14 días
- D. Penicilina G benzatínica una dosis intramuscular

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que juntar dos datos que obligan a tratar de forma completa. Primero, la madre tuvo sífilis y no recibió tratamiento, lo que por sí solo ya coloca al recién nacido en alto riesgo de sífilis congénita, independientemente de que esté sin síntomas, porque la infección puede estar presente y manifestarse después. Segundo, la serología del neonato es más alta que la de la madre, 1:64 frente a 1:32; aunque esa diferencia de una dilución por sí sola no alcanza el umbral de cuatro veces que define infección, sumada a una madre no tratada obliga a asumir que el bebé está infectado y no que solo arrastra anticuerpos pasados por la placenta. Ante una madre no tratada y un neonato con estos datos, aunque esté asintomático, se lo considera con sífilis congénita probable y se trata de forma completa, y el tratamiento correcto es la penicilina por vía endovenosa durante diez a catorce días, que es el esquema que asegura eliminar el treponema, incluida su posible presencia en el sistema nervioso. Por eso es la respuesta. La penicilina benzatínica en una sola dosis intramuscular se reserva únicamente para casos de bajo riesgo, cuando la madre fue tratada adecuadamente y el neonato tiene evaluación normal; no sirve para tratar una sífilis congénita probable, porque no alcanza niveles adecuados en el sistema nervioso. La observación y repetir la serología en un mes deja sin tratar a un recién nacido de alto riesgo, lo que es inaceptable ante una madre no tratada con un título neonatal elevado. La ceftriaxona no es el tratamiento de elección de la sífilis congénita; el fármaco de elección es la penicilina, y en este contexto por vía endovenosa durante diez a catorce días.

VILLAPEPA ENAM: Madre con sífilis no tratada + neonato con título mayor que el materno (1:64 frente a 1:32) = sífilis congénita probable, que se trata con penicilina endovenosa por 10 a 14 días, aunque el bebé esté asintomático. La benzatínica en dosis única solo vale si la madre fue tratada y el neonato está de bajo riesgo.

149. Mujer de 71 años con prolapso uterino grado III en manejo conservador con pesario de anillo desde hace 6 meses, sin controles ginecológicos regulares. Acude por secreción vaginal fétida y sangrado vaginal leve. Examen se observa eritema y lesión superficial irregular sobre la pared vaginal posterior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Prolapso vesical agudo
- B. Cáncer de cuello uterino
- C. Reacción alérgica al material del pesario
- D. Ulceración de la mucosa vaginal

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El elemento que explica todo es un pesario que lleva seis meses colocado sin ningún control ginecológico. El pesario es un dispositivo que se apoya de forma continua contra las paredes de la vagina, y si no se controla y se retira periódicamente para revisar la mucosa, esa presión mantenida en el mismo punto termina lesionando la pared por decúbito, igual que una escara en la piel. El resultado es una úlcera de la mucosa vaginal, que explica exactamente lo que presenta la paciente: una lesión superficial e irregular con eritema sobre la pared vaginal, que sangra levemente y produce secreción de mal olor por la infección local de esa úlcera. Por eso el diagnóstico más probable es la ulceración de la mucosa vaginal por el pesario. El cáncer de cuello uterino siempre hay que tenerlo presente ante un sangrado en una mujer mayor, y de hecho la úlcera se debe biopsiar para descartarlo, pero la lesión está descrita como superficial sobre la pared vaginal en el contexto claro de un pesario mal controlado, lo que apunta primero a la úlcera por presión, no a una lesión del cuello. La reacción alérgica al material del pesario daría más bien una irritación difusa o dermatitis, no una úlcera localizada con sangrado en el punto de apoyo. El prolapso vesical agudo se refiere al descenso de la vejiga, un problema de descenso de órganos, no una lesión ulcerada de la mucosa con secreción fétida; el cuadro corresponde a la úlcera por decúbito del pesario.

VILLAPEPA ENAM: Pesario colocado meses sin controles + secreción fétida + sangrado + lesión superficial en la pared vaginal = ulceración de la mucosa por decúbito del pesario (presión mantenida sin control). Siempre se biopsia para descartar cáncer, pero en este contexto el diagnóstico probable es la úlcera por pesario.

150. Mujer de 34 años con VIH en estadio SIDA ($CD4 < 50$ células/ μL) presenta fotopsias y disminución progresiva de la visión. Fondo de ojo: retinitis necrosante blanco amarillenta perivascular con hemorragias en llama, descrita como "queso con tomate" o "pizza". ¿Cuál es el diagnóstico etiológico más probable?

- A. Compromiso retiniano por *Pneumocystis jirovecii*
- B. Coriorretinitis toxoplásmica
- C. Endoftalmitis fúngica por *Aspergillus*
- D. Retinitis por citomegalovirus

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Dos claves apuntan al mismo agente. Primero, el grado de inmunosupresión: un recuento de linfocitos CD4 por debajo de cincuenta es una inmunodepresión profunda, el terreno de las infecciones oportunistas más graves, y entre las que afectan la retina a ese nivel destaca una en particular. Segundo, y muy característico, el aspecto del fondo de ojo: una retinitis que destruye la retina, con zonas necróticas blanco-amarillentas que siguen los vasos y hemorragias entremezcladas, un cuadro tan típico que se describe con la imagen de queso con tomate o de pizza, por la combinación de los exudados amarillos y las hemorragias rojas. Esa retinitis necrosante hemorrágica con ese aspecto, en un paciente con CD4 muy bajos, es la retinitis por citomegalovirus, la causa más frecuente de pérdida de visión en el sida avanzado. Por eso es la respuesta. La coriorretinitis por toxoplasma también afecta el ojo en el sida, pero produce lesiones focales con inflamación intensa del vítreo y un aspecto distinto, no el patrón hemorrágico en pizza a lo largo de los vasos. El *Pneumocystis jirovecii* es sobre

todo un agente pulmonar en el sida, causa de neumonía, y no produce esta retinitis necrosante hemorrágica característica. La endoftalmitis por *Aspergillus* es una infección fúngica del ojo que da un cuadro inflamatorio distinto, más asociado a otros contextos como la inmunosupresión por trasplante o la diseminación fúngica, no la retinitis con hemorragias en llama y exudados que dibuja el aspecto de pizza propio del citomegalovirus.

VILLAPEPA ENAM: Retinitis necrosante con exudados amarillos y hemorragias (aspecto de pizza o queso con tomate) en un paciente con VIH y CD4 menor de 50 = retinitis por citomegalovirus, principal causa de pérdida visual en el sida avanzado. La toxoplasmosis ocular da lesiones focales con vitritis, no el patrón hemorrágico perivascular.

151. Neonato de 2 días, es llevado al hospital por presentar hipoactividad, pobre succión, con antecedente de madre sin control prenatal y ruptura prematura de membranas de 20 horas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Encefalitis viral
- B. Encefalopatía hipóxica isquémica
- C. Sepsis neonatal precoz
- D. Asfixia perinatal

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que unir los factores de riesgo con la forma de presentación. Este neonato tiene dos antecedentes que aumentan de manera importante el riesgo de infección: una madre sin control prenatal, en quien no se pudo pesquisar ni tratar infecciones, y una ruptura de membranas prolongada, de veinte horas, que abre una vía para que las bacterias del canal vaginal asciendan y colonicen al feto. Y la presentación es la típica del recién nacido infectado: la sepsis en el neonato no da síntomas llamativos, sino signos sutiles e inespecíficos como la hipoactividad y la pobre succión, es decir un bebé decaído que no se alimenta bien. Que esto aparezca en los primeros días de vida, en las primeras setenta y dos horas, con esos factores de riesgo maternos, define una sepsis neonatal precoz, adquirida alrededor del parto. Por eso es el diagnóstico más probable. La encefalopatía hipóxico-isquémica y la asfixia perinatal se relacionan con un evento de falta de oxígeno alrededor del nacimiento, con antecedente de sufrimiento fetal, Apgar bajo y necesidad de reanimación; nada de eso se menciona, y en cambio los datos que sí hay, la ruptura de membranas prolongada y la falta de control, apuntan a la infección, no a la hipoxia. La encefalitis viral es una causa mucho menos frecuente en esta edad y no encaja con el escenario de riesgo infeccioso bacteriano perinatal; el cuadro de un neonato hipoactivo, con mala succión, tras ruptura de membranas prolongada y sin control prenatal, es una sepsis neonatal precoz.

VILLAPEPA ENAM: Neonato de pocos días con hipoactividad y mala succión (signos sutiles) + factores de riesgo perinatal (madre sin control prenatal, ruptura de membranas prolongada) = sepsis neonatal precoz. La sepsis del recién nacido se manifiesta con signos inespecíficos, no floridos; la asfixia requiere antecedente de hipoxia con Apgar bajo.

152. Mujer de 31 años domiciliada en un ámbito de escenario III para dengue, acude a urgencias de un establecimiento de nivel I-2 por presentar fiebre desde hace cinco días y desde hace 12 horas dolor abdominal y vómito persistente; prueba de ELISA antígeno NS1 con resultado positivo. ¿Qué acción se debe realizar?

- A. Monitorización en la unidad de febriles del centro de salud
- B. Indicar aislamiento domiciliario y seguimiento telefónico

- C. Referencia a establecimiento de mayor complejidad
- D. Realizar exclusivamente vigilancia serológica en laboratorio

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que cruzar dos cosas: la gravedad del cuadro y la capacidad del lugar donde está la paciente. La gravedad ya subió de nivel: tiene un dengue confirmado por el antígeno positivo y, lo importante, aparecieron signos de alarma, el dolor abdominal y los vómitos persistentes, que anuncian la fase en que el dengue puede complicarse con fuga de plasma y evolucionar hacia el shock. Un dengue con signos de alarma necesita hospitalización con vigilancia estrecha e hidratación controlada, a menudo intravenosa. Y aquí está la capacidad: se encuentra en un establecimiento de primer nivel muy básico, un I-2, que es un puesto de salud sin la capacidad resolutive para hospitalizar y manejar las complicaciones de un dengue que se agrava. Por eso la acción correcta es referirla de inmediato a un establecimiento de mayor complejidad que pueda internarla y vigilarla adecuadamente. Monitorizarla en la unidad de febriles del mismo centro de salud la deja en un lugar sin recursos para actuar si progresa al shock. Indicar aislamiento domiciliario con seguimiento telefónico es directamente peligroso, porque mandar a casa a una paciente con signos de alarma la aleja de la atención justo cuando puede descompensarse. Y limitarse a la vigilancia serológica en laboratorio confunde una acción epidemiológica de registro con el manejo clínico que la paciente necesita ahora; lo prioritario es referirla para que reciba el cuidado hospitalario que su cuadro exige.

VILLAPEPA ENAM: Dengue confirmado con signos de alarma (dolor abdominal, vómitos persistentes) en un establecimiento de primer nivel básico (I-2) sin capacidad de hospitalización = referencia a un establecimiento de mayor complejidad. Los signos de alarma exigen internamiento e hidratación controlada, no manejo domiciliario.

153. Lactante de 3 meses, hijo de madre tratada durante el embarazo por tuberculosis pulmonar con un esquema que incluyó un fármaco inyectable, es llevado a consulta por ausencia de respuesta a estímulos sonoros desde el nacimiento. El estudio audiológico confirma hipoacusia neurosensorial bilateral severa. ¿Qué fármaco antituberculoso utilizado en la madre es el más probable responsable de la sordera del lactante?

- A. Estreptomina
- B. Isoniazida
- C. Rifampicina
- D. Etambutol

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La pista está en dos palabras del enunciado: fármaco inyectable y sordera. Entre los medicamentos contra la tuberculosis, el que se administra por vía inyectable y es clásicamente tóxico para el oído es la estreptomina, un aminoglucósido. Este grupo de fármacos daña las células sensoriales del oído interno, produciendo una hipoacusia neurosensorial, y tiene un problema añadido en el embarazo: atraviesa la placenta y llega al feto, de modo que puede lesionar el oído del bebé en formación y provocar sordera congénita, tal como muestra este lactante que no responde a los sonidos desde el nacimiento. Por eso la estreptomina es la responsable más probable, y por este mismo motivo está contraindicada durante el embarazo. La isoniazida es un pilar del tratamiento pero se toma por vía oral y su toxicidad característica es sobre los nervios periféricos, la neuropatía, que se previene con vitamina B6, no la sordera. La rifampicina también es oral y su efecto adverso típico es hepático y el color anaranjado de las secreciones, no ototóxico. El etambutol, igualmente oral, afecta de forma

característica el nervio óptico, produciendo alteraciones de la visión y del color, no del oído; el único inyectable y ototóxico del esquema, capaz de causar la sordera congénita, es la estreptomina.

VILLAPEPA ENAM: Antituberculoso inyectable + sordera congénita = estreptomina, un aminoglucósido ototóxico que atraviesa la placenta y daña el oído del feto (contraindicado en el embarazo). La isoniazida da neuropatía, la rifampicina toxicidad hepática y color naranja, y el etambutol neuritis óptica.

154. Varón de 27 años sufre un accidente de tránsito y es trasladado a un centro de salud ubicado a 3 horas del hospital de mayor complejidad. Examen: diaforético, PA: 80/50 mmHg, FC: 132x', SO₂: 86%, múltiples heridas y deformidad evidente en el fémur derecho. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- A. Administrar O₂, fluidoterapia con cristaloideos y controlar hemorragia
- B. Inmovilizar el fémur con férula, analgésicos y referir de inmediato
- C. Collarín cervical, inmovilizar el fémur y solicitar exámenes básicos
- D. Observación y referir si persiste inestabilidad hemodinámica

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Este paciente está en shock, y eso ordena las prioridades. Tiene todos los signos del shock hemorrágico: sudoración fría, presión baja de ochenta sobre cincuenta, taquicardia intensa de ciento treinta y dos, y una saturación caída. Además, la fractura de fémur puede por sí sola secuestrar una gran cantidad de sangre. En el manejo del politraumatizado, lo primero siempre es reanimar según la secuencia vital: asegurar la oxigenación, reponer el volumen perdido y controlar el sangrado, porque de nada sirve trasladar bien inmovilizado a un paciente que se está desangrando y desoxigenando. Por eso la conducta inicial es administrar oxígeno, iniciar fluidoterapia con cristaloideos para levantar la presión y controlar las fuentes de hemorragia. Esa es la base que estabiliza al paciente. Inmovilizar el fémur con férula, dar analgésicos y referir de inmediato tiene su parte correcta, porque la férula ayuda a reducir el sangrado de la fractura, pero como conducta aislada omite lo esencial: la reanimación con oxígeno y líquidos del paciente en shock; primero se estabiliza, luego se traslada. Poner collarín, inmovilizar y solicitar exámenes básicos pierde tiempo en estudios en un paciente que necesita reanimación inmediata, no análisis. Observar y referir solo si persiste la inestabilidad es directamente peligroso: el paciente ya está inestable ahora, en shock, y esperar es dejar que se agrave; hay que actuar de inmediato con oxígeno, volumen y control de la hemorragia.

VILLAPEPA ENAM: Politraumatizado en shock hemorrágico (hipotensión, taquicardia, desaturación) = reanimar primero según la secuencia vital: oxígeno, fluidoterapia con cristaloideos y control de la hemorragia. La inmovilización del fémur ayuda, pero primero se estabiliza al paciente en shock; no se pierde tiempo en exámenes ni se observa.

155. Mujer de 27 años, sexualmente activa, acude por flujo vaginal abundante de 2 semanas de evolución. Refiere leucorrea amarillenta, espumosa y maloliente, acompañada de leve prurito vaginal. No presenta dolor pélvico ni fiebre. Examen: especuloscopia flujo espumoso amarillo verdoso y cérvix con aspecto puntillado "en fresa". ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- A. Gardnerella vaginalis
- B. Trichomonas vaginalis
- C. Candida albicans
- D. Virus papiloma humano

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Dos rasgos apuntan directamente al agente. El primero es el flujo: una leucorrea abundante, amarillo-verdosa, espumosa y de mal olor. El segundo, y prácticamente definitivo, es lo que se ve en el cuello del útero durante el examen: un aspecto puntillado, el llamado *cérvix en fresa*, que son las pequeñas hemorragias puntiformes de la mucosa inflamada. Ese *cérvix en fresa* junto con el flujo espumoso amarillo-verdoso es la firma de la tricomoniasis, la infección por *Trichomonas vaginalis*, un parásito de transmisión sexual. Por eso es el agente más probable. La *Gardnerella vaginalis* causa la vaginosis bacteriana, que da un flujo grisáceo, homogéneo y con olor a pescado, pero no espumoso ni amarillo-verdoso, y no produce el *cérvix en fresa* ni la inflamación con prurito. La *Candida albicans* produce la candidiasis, con un flujo blanco y grumoso, como leche cortada, y mucho prurito y ardor, sin el aspecto espumoso ni el *cérvix puntillado*. El virus del papiloma humano se asocia a las verrugas genitales y a las lesiones del cuello relacionadas con el cáncer, pero no causa este cuadro de flujo espumoso maloliente con *cérvix en fresa*; ese conjunto es característico de la tricomoniasis.

VILLAPEPA ENAM: Flujo abundante espumoso amarillo-verdoso y maloliente + *cérvix en fresa* (puntillado hemorrágico) = tricomoniasis por *Trichomonas vaginalis*. La vaginosis por *Gardnerella* da flujo gris con olor a pescado; la candidiasis, flujo blanco grumoso con mucho prurito.

156. Varón de 48 años acude al servicio de emergencia por presentar desde hace 24 horas dolor abdominal difuso, náuseas, poliuria y polidipsia. Niega consumo de alcohol y fármacos recientes. Examen: taquicárdico, normotenso, con respiración profunda y rápida. Lab: glucosa 360 mg/dL, pH arterial 7.02, bicarbonato sérico 9 mEq/L, sodio 135 mEq/L, potasio 4.5 mEq/L, cuerpos cetónicos en orina ++. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Acidosis metabólica asociada a enfermedad renal crónica en fase terminal
- B. Acidosis metabólica por aumento de lactato en el contexto de hipoperfusión tisular
- C. Estado hiperglucémico hiperosmolar con acidosis metabólica
- D. Cetoacidosis diabética con acidosis metabólica anión gap elevado

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Las piezas encajan en un diagnóstico. Hay hiperglucemia, con la glucosa elevada; hay acidosis metabólica, con el pH muy bajo y el bicarbonato desplomado; hay cuerpos cetónicos en la orina, es decir cetosis; y hay la respiración profunda y rápida de Kussmaul, que es el intento del pulmón de eliminar el exceso de ácido. Esa combinación de glucosa alta, cetonas y acidosis es la definición de la cetoacidosis diabética, que se produce cuando la falta de insulina obliga al cuerpo a quemar grasa y generar cuerpos cetónicos, unos ácidos que consumen el bicarbonato y acidifican la sangre. Además, esos cetoácidos son aniones no medidos que aumentan el anión gap, por eso es una acidosis metabólica con anión gap elevado. Los síntomas de poliuria, polidipsia y el dolor abdominal completan el cuadro clásico. Por eso es la respuesta. El estado hiperglucémico hiperosmolar es la trampa a evitar: también cursa con hiperglucemia, pero típicamente con glucosas mucho más altas, sin cetonas significativas y sin acidosis marcada, justo lo contrario de este paciente que sí tiene cetonas y acidosis profunda. La acidosis por enfermedad renal terminal no explica la hiperglucemia con cetonas ni encaja con este cuadro agudo. La acidosis láctica por hipoperfusión ocurre en el shock con mala perfusión de los tejidos, pero este paciente está normotenso y tiene cetonas en orina, lo que señala que su acidosis es por cetoácidos, no por lactato; el conjunto de hiperglucemia, cetosis y acidosis con anión gap elevado es la cetoacidosis diabética.

VILLAPEPA ENAM: Hiperglucemia + cetonas en orina + acidosis metabólica (pH y bicarbonato bajos) con

respiración de Kussmaul = cetoacidosis diabética con anión gap elevado (los cetoácidos consumen bicarbonato y elevan el anión gap). El estado hiperosmolar tiene glucosa mucho más alta pero sin cetosis ni acidosis marcada.

157. Mujer de 24 años, previamente sana, consulta por una lesión en el tórax de 3 cm de diámetro, ovalada, eritematosa, con descamación periférica fina y prurito leve. Refiere que apareció hace dos semanas. Desde hace 5 días han surgido múltiples lesiones más pequeñas, ovaladas, similares, distribuidas siguiendo las líneas de tensión cutánea en el dorso ("árbol de Navidad"). No presenta fiebre ni compromiso del estado general. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Eritema multiforme
- B. Dermatitis seborreica
- C. Pitiriasis rosada
- D. Psoriasis vulgar

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El cuadro tiene una secuencia y un patrón muy característicos. Primero apareció una sola lesión más grande, ovalada, eritematosa y con descamación en el borde, lo que se conoce como la placa heráldica o medallón heráldico, que precede en días o una a dos semanas al resto. Después, brotaron múltiples lesiones más pequeñas y parecidas, y estas se distribuyen de una manera muy distintiva: siguiendo las líneas de tensión de la piel del tronco, lo que en la espalda dibuja la imagen de un árbol de Navidad. Esa combinación de una placa heráldica inicial seguida del brote en patrón de árbol de Navidad, en una persona joven, sin fiebre ni compromiso general, es la pitiriasis rosada, una enfermedad benigna y autolimitada. Por eso es el diagnóstico. La dermatitis seborreica afecta zonas grasas como el cuero cabelludo, las cejas y los surcos de la nariz, con escamas amarillentas y grasosas, no da la placa heráldica ni el patrón en árbol de Navidad en el tronco. La psoriasis se presenta con placas cubiertas de escamas gruesas y plateadas en codos, rodillas y cuero cabelludo, con una evolución crónica, muy distinta de la aparición aguda con placa heráldica de este caso. El eritema multiforme se caracteriza por lesiones en diana o escarapela, a menudo tras una infección o un fármaco, no por óvalos descamativos siguiendo las líneas de tensión precedidos de un medallón heráldico; ese patrón es de la pitiriasis rosada.

VILLAPEPA ENAM: Placa heráldica (medallón inicial ovalado con descamación en el borde) seguida días después de múltiples lesiones ovaladas que siguen las líneas de tensión de la piel (patrón en árbol de Navidad), sin fiebre = pitiriasis rosada, benigna y autolimitada. La psoriasis da escamas plateadas gruesas y crónicas.

158. Niña de 7 años traída por sus padres por prurito intenso y lesiones cutáneas de varios meses de evolución, con exacerbaciones frecuentes. Antecedente de rinitis alérgica y episodios recurrentes de bronquitis. Al examen se observan pápulas eritematosas, placas secas y descamativas con escoriaciones en pliegues de flexión de codos y rodillas, cuello y dorso de pies, de distribución bilateral y simétrica, la sospecha diagnóstica más probable es una dermatitis

- A. seborreica.
- B. atópica.
- C. de contacto.
- D. fotosensible.

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Dos elementos hacen el diagnóstico. El primero es la localización tan típica: lesiones en los pliegues de flexión, es decir en el interior de los codos y detrás de las rodillas, además del cuello y el dorso de los pies, de forma bilateral y simétrica, con piel seca, descamativa y escoriaciones por el rascado del prurito intenso. Esa distribución en los pliegues flexores es la marca de la dermatitis atópica en el niño. El segundo elemento es el contexto de atopía, la predisposición alérgica personal: la niña tiene rinitis alérgica y episodios recurrentes de bronquitis, es decir forma parte de la llamada marcha atópica, la asociación de eccema, rinitis y asma que comparten un mismo terreno alérgico. Prurito crónico con eccema en los pliegues, más antecedentes de rinitis y broncoespasmo, es dermatitis atópica. La dermatitis seborreica se localiza en zonas grasas, el cuero cabelludo y la cara, con escamas amarillentas, no en los pliegues de flexión ni con este trasfondo de alergia respiratoria. La dermatitis de contacto aparece en el sitio exacto donde la piel tocó una sustancia irritante o alérgica, con una distribución que corresponde al área de contacto, no simétrica en los pliegues flexores ni ligada a la atopía. La dermatitis fotosensible se produce por la luz solar y compromete las zonas expuestas al sol, la cara, el escote y los antebrazos, no los pliegues de flexión que están protegidos de la luz; el patrón flexural con antecedentes alérgicos es la dermatitis atópica.

VILLAPEPA ENAM: Eccema crónico y pruriginoso en los pliegues de flexión (codos, rodillas), bilateral y simétrico, en un niño con rinitis alérgica y broncoespasmo (marcha atópica) = dermatitis atópica. La seborreica afecta zonas grasas; la de contacto sigue el área expuesta al irritante y la fotosensible las zonas de sol.

159. Varón de 18 años, sano, presenta hace 2 horas habones eritemato-edematosos generalizados, muy pruriginosos, que aparecen y desaparecen en menos de 24 h. Refiere ingesta reciente de mariscos. No hay fiebre, dificultad respiratoria ni compromiso hemodinámico. Constantes vitales normales. Además de educar sobre los signos de alarma. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A. Antihistamínico oral y evitar alimento sospechoso
- B. Adrenalina intramuscular y derivación a emergencia
- C. Corticoides intravenosos y observación ambulatoria
- D. Solicitar estudios antes de iniciar tratamiento

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El cuadro es una urticaria aguda: habones, esas ronchas rojas y elevadas que pican mucho y son fugaces, aparecen y desaparecen en menos de un día, desencadenados por la ingesta de mariscos, un alérgeno frecuente. Y el dato tranquilizador que define la conducta es que la reacción se quedó en la piel: no hay compromiso respiratorio, ni caída de la presión, ni ningún signo de que la reacción alérgica haya progresado a algo sistémico y grave. Una urticaria aislada, sin síntomas de anafilaxia, se trata de forma sencilla: un antihistamínico oral para bloquear la histamina que produce las ronchas y el picor, junto con la indicación de evitar el alimento que la provocó, y educar al paciente sobre los signos de alarma por si en el futuro apareciera algo más serio. Por eso esa es la conducta. La adrenalina intramuscular con derivación a emergencia es el tratamiento de la anafilaxia, la reacción alérgica grave con compromiso de la vía aérea, la respiración o la circulación; usarla en una urticaria simple, sin ninguno de esos signos, es desproporcionado, porque la adrenalina se reserva para la emergencia real. Los corticoides intravenosos son un tratamiento de segunda línea o para casos más severos, excesivo para una urticaria leve que responde a los antihistamínicos orales. Solicitar estudios antes de iniciar el tratamiento no tiene sentido: el diagnóstico de la urticaria es clínico y el desencadenante es evidente, así que retrasar el alivio del paciente para pedir análisis es innecesario; lo correcto es dar el antihistamínico y evitar el alimento.

VILLAPEPA ENAM: Urticaria aguda (habones fugaces y pruriginosos) por un alimento, sin dificultad respiratoria

ni compromiso hemodinámico = antihistamínico oral y evitar el alimento sospechoso. La adrenalina se reserva para la anafilaxia (compromiso de vía aérea, respiración o circulación), que aquí no existe.

160. Varón de 38 años presenta lesiones cutáneas crónicas, asintomáticas. Examen: placas eritematosas bien delimitadas, cubiertas por escamas gruesas, nacaradas y secas, localizadas en codos, rodillas y cuero cabelludo. El raspado de Brocq evidencia el signo de la vela y el signo de Auspitz. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Dermatitis atópica
- B. Dermatitis seborreica
- C. Pityriasis rosada
- D. Psoriasis vulgar

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Cada rasgo de este caso es un signo de psoriasis. Las lesiones son placas rojas bien delimitadas cubiertas de escamas gruesas, secas y de aspecto nacarado o plateado, y se ubican en las localizaciones típicas: los codos, las rodillas y el cuero cabelludo, que son las zonas de extensión donde la psoriasis se asienta con preferencia. Pero lo que confirma el diagnóstico es la maniobra del raspado de Brocq, que consiste en rascar suavemente la placa y observar dos fenómenos sucesivos. Primero aparece el signo de la vela: al raspar se desprenden escamas blanquecinas como las que deja una vela de cera, por el desprendimiento de la capa córnea engrosada. Y si se sigue raspando aparece el signo de Auspitz: un puntilleo de pequeñas gotas de sangre, porque bajo la placa los capilares dilatados están muy cerca de la superficie y se rompen. Esos dos signos juntos son característicos de la psoriasis. Por eso el diagnóstico es la psoriasis vulgar. La dermatitis atópica da eccema pruriginoso en los pliegues de flexión, no placas plateadas en las superficies de extensión ni los signos del raspado. La dermatitis seborreica produce escamas grasas y amarillentas en zonas seborreicas, distintas de las escamas secas y nacaradas de la psoriasis. La pitiriasis rosada tiene una placa heráldica y un brote en árbol de Navidad de curso agudo y autolimitado, sin las placas crónicas gruesas ni el signo de Auspitz; la combinación de escamas nacaradas en codos y rodillas con signo de la vela y de Auspitz es exclusiva de la psoriasis.

VILLAPEPA ENAM: Placas eritematosas con escamas gruesas nacaradas en codos, rodillas y cuero cabelludo + signo de la vela y signo de Auspitz al raspado = psoriasis vulgar. El signo de Auspitz (puntilleo hemorrágico) y el de la vela son característicos; la seborreica da escamas grasas amarillas y la atópica eccema en pliegues.

161. Secundigesta de 39 semanas, hace 2 años cesárea segmentaria transversa. A la fecha parto vaginal sin complicaciones aparentes. Minutos después del alumbramiento de placenta íntegra, presenta sangrado vaginal rojo rutilante abundante. A la palpación, útero contraído a nivel de la cicatriz umbilical. Hemodinamia estable. ¿Cuál es la conducta inmediata?

- A. Laparotomía exploratoria de emergencia
- B. Revisión manual de cavidad uterina y canal del parto
- C. Colocar de inmediato un balón intrauterino
- D. Administrar una dosis adicional de oxitocina intravenosa

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La clave está en dos datos del enunciado que permiten descartar las otras causas. Hay una hemorragia posparto, pero antes de tratarla hay que averiguar de dónde sangra, y para eso están las llamadas cuatro T: el tono, el tejido, el trauma y la trombina. El enunciado ya cierra dos puertas. Dice que el útero está contraído,

firme, a la altura del ombligo: eso descarta la atonía uterina, que es la causa más frecuente pero que se manifiesta con un útero blando y relajado; aquí el músculo está bien contraído. Y dice que la placenta salió íntegra, completa: eso descarta la retención de restos placentarios, es decir el tejido. Entonces, si el útero está bien contraído y no hay restos, pero sigue saliendo sangre roja rutilante y abundante, la causa que queda es el trauma: un desgarro del cuello o de las paredes de la vagina, o una laceración del canal del parto. Por eso la conducta inmediata es la revisión manual de la cavidad uterina y del canal del parto, para localizar la lesión que sangra y repararla. Administrar otra dosis de oxitocina intravenosa trataría una atonía que aquí no existe, porque el útero ya está contraído, y no detendría el sangrado de un desgarro. Colocar un balón intrauterino también es un recurso para la atonía, para taponar una cavidad que no se contrae, no para un desgarro del canal. La laparotomía exploratoria de emergencia es una medida mayor, reservada para cuando falla el manejo o se sospecha una rotura uterina con inestabilidad; esta paciente está hemodinámicamente estable y primero corresponde el paso lógico y menos invasivo, que es revisar el canal para encontrar y reparar el desgarro.

VILLAPEPA ENAM: Hemorragia posparto con útero bien contraído (descarta atonía) y placenta íntegra (descarta restos) = trauma del canal del parto. La conducta es la revisión manual de la cavidad y del canal para localizar y reparar el desgarro; la oxitocina y el balón tratan la atonía, que aquí no existe.

162. Varón de 45 años, con diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica secundaria a hipertensión arterial. En tratamiento con Losartan, hidroclorotiazida, bisoprolol, y espironolactona. Desde hace 02 meses nota aumento de volumen de región mamaria y disminución de la libido. El manejo a seguir consiste en reemplazar uno de los fármacos con.....

- A. enalapril.
- B. furosemida.
- C. eplerenona.
- D. metoprolol.

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Primero hay que identificar cuál de los cuatro fármacos está causando el efecto adverso, y luego reemplazarlo por otro que haga el mismo trabajo sin ese problema. El paciente desarrolló crecimiento de las mamas, la ginecomastia, y disminución de la libido. De su tratamiento, el responsable clásico de esto es la espironolactona: es un antagonista de la aldosterona útil en la insuficiencia cardíaca, pero tiene una acción antiandrogénica, es decir bloquea también los receptores de las hormonas masculinas, y por eso produce ginecomastia y baja de la libido. Entonces hay que quitar la espironolactona, pero sin perder el beneficio de bloquear la aldosterona, que mejora el pronóstico en la insuficiencia cardíaca. La solución es la eplerenona, que es también un antagonista de la aldosterona pero mucho más selectivo: hace el mismo efecto sobre el corazón sin ese bloqueo antiandrogénico, de modo que no causa ginecomastia. Por eso el reemplazo correcto es la eplerenona. El enalapril es un IECA y el paciente ya recibe losartán, que es un ARA-II con el mismo mecanismo sobre el sistema renina-angiotensina; cambiar a enalapril no sustituye el bloqueo de la aldosterona que se está retirando ni corrige nada. La furosemida es un diurético de asa que ayuda a la congestión, pero no reemplaza el efecto de la espironolactona sobre la aldosterona ni tiene su beneficio pronóstico. El metoprolol es un betabloqueador, del mismo grupo que el bisoprolol que ya toma, así que no tiene relación con la ginecomastia ni con la aldosterona; el fármaco que hay que sustituir es la espironolactona y su reemplazo lógico es la eplerenona.

VILLAPEPA ENAM: Ginecomastia y baja de la libido en un paciente que toma espironolactona = efecto antiandrogénico de la espironolactona. Se reemplaza por eplerenona, un antagonista de la aldosterona selectivo que conserva el beneficio cardíaco sin producir ginecomastia.

163. Varón de 55 años con baja de peso, anemia ferropénica y saciedad precoz. Endoscopia: lesión ulcerosa infiltrante en cuerpo gástrico. Biopsia: adenocarcinoma gástrico tipo Borrmann III. Gastrectomía subtotal: tumor 4,5 cm, invasión hasta serosa (T4a), borde profundo libre, metaplasia

intestinal adyacente, compromiso ganglionar 2/20 (N1). ¿Cuál hallazgo histopatológico influye más en el pronóstico y en la necesidad de tratamiento adyuvante?

- A. Metaplasia intestinal por *H. pylori*
- B. Localización en cuerpo gástrico
- C. Profundidad de invasión tumoral hasta serosa (T4a)
- D. Tamaño tumoral >4 cm

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Entre todos los datos del informe de patología, hay que reconocer cuál pesa más en el pronóstico, y para eso se piensa en el sistema de estadificación TNM, donde lo que más manda es la T, es decir hasta dónde ha invadido el tumor en la pared. Aquí el tumor llega hasta la serosa, la capa más externa del estómago, lo que se clasifica como T4a. Esa profundidad es un marcador de enfermedad avanzada: cuanto más atraviesa la pared el tumor, mayor es el riesgo de que las células hayan alcanzado la superficie del órgano y se diseminen por el abdomen, y peor es el pronóstico. Por eso la profundidad de invasión hasta la serosa es el hallazgo que más influye, y además, al indicar enfermedad localmente avanzada, es lo que justifica dar tratamiento adyuvante, la quimioterapia complementaria tras la cirugía. El tamaño del tumor, mayor de cuatro centímetros, se correlaciona en general con más agresividad, pero no es un criterio pronóstico tan determinante como la profundidad de invasión ni entra en el estadiaje con el mismo peso que la T. La localización en el cuerpo gástrico describe dónde está el tumor, pero por sí sola no define el pronóstico ni la necesidad de adyuvancia. La metaplasia intestinal es una lesión de la mucosa que representa un factor de riesgo previo, un terreno predisponente al cáncer, pero es un antecedente del tejido vecino, no una característica del tumor que marque su pronóstico; lo que gobierna el pronóstico y la decisión de tratar después de operar es la profundidad de invasión hasta la serosa.

VILLAPEPA ENAM: En el cáncer gástrico, el factor pronóstico que más pesa es la profundidad de invasión en la pared (la T del TNM); llegar hasta la serosa (T4a) marca enfermedad avanzada y justifica la quimioterapia adyuvante. El tamaño y la metaplasia intestinal son factores secundarios frente a la profundidad de invasión.

164. Varón de 45 años, conductor interprovincial, desde hace 6 meses presenta dolor urente epigástrico, que aparece en ayunas, mejora con alimentos y lo despierta en la noche. Refiere consumo crónico de AINE por lumbalgia, fuma 10 cigarrillos/día. No refiere baja de peso ni hematemesis. Examen: dolor epigástrico leve, sin signos de irritación peritoneal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Enfermedad por reflujo gastroesofágico
- B. Gastritis erosiva aguda
- C. Úlcera péptica duodenal
- D. Dispepsia funcional

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El ritmo del dolor con las comidas es la pista que orienta el diagnóstico. Este paciente tiene un dolor ardoroso en la boca del estómago que aparece cuando está en ayunas, se calma cuando come y lo despierta por la noche. Ese patrón, dolor con el estómago vacío que mejora al comer, es el sello de la úlcera duodenal: cuando el estómago está vacío, el ácido cae directamente sobre la úlcera del duodeno y duele; al comer, el alimento amortigua y neutraliza el ácido, y el dolor cede. El despertar nocturno se explica igual, porque de madrugada hay un pico de secreción ácida sobre el estómago vacío. Además tiene dos factores de riesgo que dañan la mucosa y favorecen la úlcera: el consumo crónico de antiinflamatorios y el tabaquismo. Por eso el diagnóstico más probable es la úlcera péptica duodenal. Conviene contrastarlo con la úlcera gástrica, que tiene el ritmo inverso: el dolor empeora al comer, no mejora. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se manifiesta con

ardor que sube hacia el pecho, la pirosis, y regurgitación, típicamente peor al acostarse o tras comidas, no con este patrón de dolor en ayunas que calma con el alimento. La gastritis erosiva aguda suele ser un cuadro más agudo, ligado a un daño reciente, y no da este dolor rítmico de meses que mejora al comer. La dispepsia funcional es un diagnóstico de descarte, sin lesión y sin este patrón tan característico ni los factores de riesgo tan marcados; el dolor en ayunas que mejora con alimentos y despierta de noche, en un consumidor de antiinflamatorios y fumador, es una úlcera duodenal.

VILLAPEPA ENAM: Dolor epigástrico urente que aparece en ayunas, mejora al comer y despierta de noche = úlcera péptica duodenal (el alimento amortigua el ácido). La úlcera gástrica tiene el ritmo inverso: empeora con la comida. Los AINE y el tabaco refuerzan el diagnóstico.

165. El proceso salud-enfermedad se concibe actualmente como un fenómeno dinámico que involucra múltiples dimensiones de la persona y su entorno. ¿Cuál de las opciones define mejor este proceso?

- A. Es un estado en el que la persona se siente bien y su organismo funciona adecuadamente, sin presentar alteraciones objetivables
- B. Es cambiante y continuo a lo largo de la vida, resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales en la persona y su entorno
- C. Es un completo estado de bienestar físico, mental y social de la persona, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia
- D. Es la ausencia de enfermedad, acompañada de la capacidad del organismo para adaptarse a los cambios del medio ambiente que lo rodea

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La pregunta pide reconocer una idea concreta: que la salud y la enfermedad no son un punto fijo sino un proceso, algo que se mueve. Las mismas palabras del enunciado lo adelantan al decir fenómeno dinámico y múltiples dimensiones de la persona y su entorno. La opción que recoge exactamente eso es la que describe la salud como algo cambiante y continuo a lo largo de la vida, que resulta de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales en la persona y su entorno. Ahí están las dos ideas que se piden: lo dinámico, porque es cambiante y continuo, y lo multidimensional, porque integra lo biológico, lo psicológico y lo social, el llamado modelo biopsicosocial. Por eso es la mejor definición. Las otras opciones describen la salud como un estado, algo estático, que es justo lo contrario del enfoque de proceso. La que habla de un completo estado de bienestar físico, mental y social es la definición clásica de la Organización Mundial de la Salud: es correcta históricamente, pero describe un estado ideal y fijo, no el carácter dinámico y continuo que la pregunta busca. La que dice que es sentirse bien y funcionar sin alteraciones también plantea un estado puntual, sin la idea de proceso ni de interacción de factores. Y la que define la salud como ausencia de enfermedad con capacidad de adaptación se queda en una visión negativa, centrada en la falta de enfermedad, más limitada que el modelo dinámico y multidimensional; la respuesta que mejor captura el proceso salud-enfermedad es la de un fenómeno cambiante y continuo, fruto de la interacción biológica, psicológica y social.

VILLAPEPA ENAM: El proceso salud-enfermedad es dinámico y continuo, resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales (modelo biopsicosocial). La definición de la OMS (completo estado de bienestar) describe un estado ideal y estático, no el carácter de proceso que se pide.

166. Varón de 60 años, previamente sano, acude al servicio de urgencias por 24 horas de dolor en fosa ilíaca izquierda. Examen: T 38,5 °C, hemodinamia estable, dolor localizado en fosa ilíaca izquierda, no signos de irritación peritoneal generalizada. Leucocitosis de 15 000/mm³. TC abdominal con contraste muestra engrosamiento de la pared del sigmoides y grasa pericolónica inflamada, sin líquido libre ni colecciones. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

- A. Lavado peritoneal diagnóstico para descartar perforación de víscera hueca

- B. Laparotomía exploratoria inmediata con resección de colon sigmoides
- C. Manejo conservador con antibióticos intravenosos y reposo digestivo
- D. Colonoscopia diagnóstica urgente para confirmar diverticulitis aguda

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Lo primero es poner nombre al cuadro y luego graduar su gravedad, porque de eso depende el tratamiento. El dolor en la fosa ilíaca izquierda con fiebre y elevación de los glóbulos blancos, junto con la tomografía que muestra la pared del sigmoides engrosada y la grasa de alrededor inflamada, es una diverticulitis aguda. Ahora, la clave está en lo que la tomografía descarta: no hay líquido libre ni colecciones, es decir no hay absceso ni signos de perforación, y el paciente está estable, sin irritación peritoneal generalizada. Eso la define como una diverticulitis no complicada, y ese tipo se trata de forma médica, con reposo del intestino y antibióticos, sin operar. Por eso el manejo inicial correcto es el conservador, con antibióticos intravenosos y reposo digestivo. La laparotomía con resección del sigmoides se reserva para las formas complicadas, con perforación, peritonitis generalizada o fracaso del tratamiento médico, nada de lo cual está presente aquí, así que operar de entrada sería excesivo. El lavado peritoneal diagnóstico es un recurso antiguo para sospecha de sangrado o perforación en el trauma, sin papel en el manejo de una diverticulitis ya diagnosticada por tomografía. Y la colonoscopia urgente está contraindicada en la fase aguda, porque insuflar aire y manipular un colon inflamado aumenta el riesgo de perforarlo; el estudio del colon se hace después, semanas más tarde, cuando la inflamación ha cedido, para descartar otras lesiones. Lo adecuado ahora es el tratamiento conservador con antibióticos y reposo digestivo.

VILLAPEPA ENAM: Diverticulitis aguda sin absceso, líquido libre ni perforación (no complicada) y paciente estable = manejo conservador con antibióticos intravenosos y reposo digestivo. La cirugía se reserva para las formas complicadas; la colonoscopia en fase aguda está contraindicada por riesgo de perforación.

167. Primigesta de 39 semanas, en trabajo de parto inducido con oxitocina. Examen: Tacto vaginal: D 5 cm, B: 90% AP: -2, dinámica uterina: 5 contracciones en 10 minutos. En el registro cardiotocográfico se observa, desaceleraciones tardías recurrentes y variabilidad mínima de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cuáles son las medidas iniciales?

- A. Deambulación, cristaloides IV y acelerar trabajo de parto con más oxitocina IV
- B. Decúbito lateral, administrar oxígeno, cristaloides IV y suspender oxitócicos
- C. Decúbito dorsal, amnioinfusion y modificar el trabajo de parto a espontáneo
- D. Decúbito lateral, monitorización intermitente, cristaloides IV y corticoides

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que leer el registro fetal y reconocer que está avisando de un problema, para actuar en consecuencia. Aparecen desaceleraciones tardías recurrentes, esas caídas de la frecuencia cardíaca que ocurren después de la contracción, y variabilidad mínima: ambos signos indican que el feto está sufriendo, que no le está llegando bien el oxígeno a través de la placenta. Y hay una causa clara y corregible: la inducción con oxitocina está produciendo demasiadas contracciones, cinco en diez minutos, una taquisistolia; cuando el útero se contrae en exceso no alcanza a relajarse entre contracciones y la placenta no logra reoxigenar al feto. La respuesta es la reanimación intrauterina, un conjunto de medidas para devolverle oxígeno al bebé. Lo primero y más importante es suspender la oxitocina, para cortar el exceso de contracciones que causa el problema. Luego, colocar a la madre en decúbito lateral, de costado, para quitar el peso del útero sobre los grandes vasos y mejorar el flujo de sangre a la placenta; administrar oxígeno a la madre y pasar líquidos intravenosos para optimizar la perfusión. Todo eso está en la opción correcta. La opción de deambular y poner más oxitocina hace exactamente lo contrario de lo que se necesita: aumentar la oxitocina agravaría la taquisistolia y el sufrimiento fetal. El decúbito dorsal, de espaldas, es la peor posición, porque el útero comprime los vasos y reduce aún más el flujo; además la amnioinfusión sirve para las desaceleraciones variables por compresión del cordón, no

para estas tardías. Y mantener solo una monitorización intermitente ante un feto que está sufriendo es inaceptable, porque justo ahora se necesita vigilancia continua, y los corticoides no tienen ningún papel en esta urgencia; lo indicado es suspender la oxitocina, decúbito lateral, oxígeno y líquidos.

VILLAPEPA ENAM: Desaceleraciones tardías recurrentes con variabilidad mínima durante inducción con taquisistolia = sufrimiento fetal por hiperestimulación. La reanimación intrauterina consiste en suspender la oxitocina, decúbito lateral, oxígeno y cristaloides. Dar más oxitocina o poner a la madre en decúbito dorsal empeora el cuadro.

168. Varón de 38 años, agricultor de la sierra central del Perú (zona endémica de neurocisticercosis), presenta primera crisis convulsiva tónico-clónica. Refiere cefalea intermitente de meses, sin fiebre ni baja de peso. Consume carne de cerdo de crianza familiar. Examen: estable, afebril, sin rigidez de nuca ni déficit neurológico. ¿Cuál es la actitud diagnóstica inicial?

- A. TC cerebral sin contraste
- B. Punción lumbar inmediata
- C. Iniciar albendazol y corticoides
- D. Serología para *Taenia solium*

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Ante una primera crisis convulsiva, la regla es mirar el cerebro antes que nada, es decir obtener una imagen que muestre si hay una lesión que la esté provocando. En este paciente, además, el contexto orienta con fuerza hacia una causa concreta: es agricultor de una zona endémica de neurocisticercosis, consume carne de cerdo de crianza familiar y tiene cefalea de meses; todo apunta a que la crisis se debe a quistes del parásito alojados en el cerebro. Por eso la primera actitud diagnóstica es una tomografía cerebral, que en la neurocisticercosis es especialmente útil porque muestra muy bien las calcificaciones, esos quistes calcificados que son la huella de la enfermedad. La tomografía sin contraste es un buen primer paso, rápido y disponible, para localizar la lesión que explica la convulsión. La punción lumbar inmediata sería un error y hasta un peligro: antes de puncionar hay que descartar con una imagen que exista una lesión que ocupe espacio o una presión intracraneal elevada, porque extraer líquido en ese escenario puede provocar una herniación cerebral; por eso la neuroimagen va primero. Iniciar albendazol con corticoides es el tratamiento de la neurocisticercosis, pero no se trata a ciegas: primero hay que confirmar con la imagen que hay quistes, ver cuántos son y en qué estado están, porque tratar sin ese dato puede incluso empeorar la inflamación; el tratamiento viene después del diagnóstico. La serología para *Taenia solium* puede apoyar el diagnóstico, pero es un complemento que puede dar falsos negativos y no localiza la lesión cerebral; lo que define la conducta inicial ante esta primera crisis es la tomografía cerebral.

VILLAPEPA ENAM: Primera crisis convulsiva en zona endémica de neurocisticercosis = tomografía cerebral (sin contraste) como paso inicial, porque muestra los quistes calcificados y localiza la lesión. La punción lumbar está contraindicada antes de descartar una lesión ocupante; el tratamiento y la serología van después de la imagen.

169. Primigesta de 29 semanas acude por dinámica uterina y pérdida de tapón mucoso. Examen: Tacto vaginal: D 5 cm B: 80%, membranas íntegras, feto único en presentación cefálica. Con el objetivo de disminuir el riesgo de parálisis cerebral infantil. ¿Cuál es la intervención farmacológica prioritaria que el médico debe indicar de manera inmediata, además del manejo tocolítico y antibiótico?

- A. Indicar nifedipino oral
- B. Iniciar sulfato de magnesio IV
- C. Administrar metformina oral

D. Administrar un esquema completo de betametasona

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Aquí hay que leer con cuidado el objetivo exacto que plantea la pregunta, porque en un parto pretérmino se dan varios fármacos a la vez, cada uno con una finalidad distinta, y se pregunta por uno en concreto. La paciente está en franco trabajo de parto pretérmino a las veintinueve semanas, con dilatación avanzada. El objetivo que se pide es preciso: disminuir el riesgo de parálisis cerebral infantil. El fármaco que cumple específicamente esa función es el sulfato de magnesio intravenoso, que actúa como neuroprotector del cerebro fetal y ha demostrado reducir la parálisis cerebral en los niños nacidos prematuros; por eso, ante un parto pretérmino inminente, iniciarlo de inmediato con ese fin es la respuesta. La trampa está en la betametasona: es un fármaco fundamental que también se administra en este contexto, pero su objetivo es otro, madurar los pulmones del feto para disminuir el distrés respiratorio del prematuro; reduce complicaciones respiratorias, no la parálisis cerebral, así que no responde al objetivo específico de la pregunta. El nifedipino es un tocolítico, sirve para frenar las contracciones, y el enunciado ya lo considera aparte al mencionar el manejo tocolítico; su función es ganar tiempo, no proteger el cerebro. La metformina es un antidiabético oral sin ningún papel en la amenaza de parto pretérmino ni en la neuroprotección. Como lo que se pide es prevenir la parálisis cerebral, la intervención prioritaria es el sulfato de magnesio.

VILLAPEPA ENAM: En el parto pretérmino, el fármaco que reduce el riesgo de parálisis cerebral es el sulfato de magnesio intravenoso (neuroprotección fetal). La betametasona también se indica, pero madura el pulmón y disminuye el distrés respiratorio, no la parálisis cerebral; hay que leer el objetivo exacto de la pregunta.

170. Niña de 7 años, previamente sana, presenta episodios bruscos de desconexión del entorno, que duran menos de 10 segundos y se repiten varias veces al día, no hay pérdida del tono postural ni movimientos tónico-clónicos. Durante la consulta, el médico reproduce una crisis mediante hiperventilación, confirmando el diagnóstico de epilepsia con crisis de ausencia típica. De acuerdo con las recomendaciones terapéuticas actuales, ¿cuál es el fármaco de primera elección en este cuadro?

A. Valproato de sodio por vía oral

B. Etosuximida por vía oral

C. Fenitoína por vía oral

D. Carbamazepina por vía oral

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El enunciado ya entrega el diagnóstico y hasta lo confirma con una maniobra: una niña con episodios brevísimos de desconexión, sin caídas ni sacudidas, que se reproducen al hacerla hiperventilar, son crisis de ausencia típicas, la epilepsia de ausencia infantil. Entonces la pregunta es directa: cuál es el fármaco de elección en las ausencias puras. La respuesta es la etosuximida, un antiepiléptico que actúa de forma específica sobre el mecanismo de las ausencias, en los circuitos del tálamo que las generan, y que por eso es el de primera línea cuando el cuadro son solo ausencias, sin crisis convulsivas generalizadas asociadas. Por eso la etosuximida es la respuesta. El valproato de sodio también es eficaz en las ausencias y es la alternativa principal, sobre todo si además hubiera crisis tónico-clónicas generalizadas, porque cubre ambas; pero cuando el cuadro es de ausencias puras, como este, se prefiere la etosuximida por su perfil más específico y favorable en la niña. La fenitoína y la carbamazepina, en cambio, no solo no sirven para las ausencias sino que están contraindicadas, porque pueden agravarlas: son útiles para las crisis focales y las tónico-clónicas, pero empeoran las ausencias y provocarían más episodios; ese es el error clásico que hay que evitar. Ante una epilepsia de ausencia típica, el fármaco de primera elección es la etosuximida.

VILLAPEPA ENAM: Crisis de ausencia típicas (desconexión breve, sin caída ni sacudidas, provocadas por

hiperventilación) = etosuximida como primera elección. El valproato es la alternativa (útil si coexisten crisis tónico-clónicas); la carbamazepina y la fenitoína están contraindicadas porque agravan las ausencias.

171. Mujer de 24 años, cursa con embarazo de 12 semanas. Refiere antecedente de aborto espontáneo a las 8 semanas de gestación hace dos años. En la historia clínica respecto a su capacidad reproductiva se considera como

- A. nuligesta.
- B. primigesta.
- C. primípara.
- D. nulípara.

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que separar dos conceptos que suelen confundirse: cuántas veces ha estado embarazada, que es la gestación, y cuántas veces ha dado a luz, que es la paridad. Son cosas distintas y aquí se pregunta por la segunda. Contemos las gestaciones: esta paciente tiene ahora un embarazo en curso y, además, tuvo antes otro embarazo que terminó en aborto a las ocho semanas. Son dos gestaciones, así que es segundigesta; por eso no es nuligesta, que sería no haberse embarazado nunca, ni primigesta, que sería estar en su primer embarazo. Ahora la paridad, que es lo que pide la pregunta: parir se refiere a haber tenido un parto de un producto que alcanzó la viabilidad, alrededor de las veintidós semanas o más. Su único embarazo anterior se perdió a las ocho semanas, es decir un aborto muy temprano, que no cuenta como parto. Y el embarazo actual todavía está en curso, en la semana doce, sin haber parido. Por lo tanto, no ha tenido ningún parto: es nulípara. Esa es la respuesta. Primípara sería haber tenido un parto, y ella no ha llegado nunca a parir, así que no lo es. Nuligesta y primigesta se refieren al número de gestaciones, no a los partos, y además son incorrectas porque ella ya lleva dos gestaciones. La clave está en entender que un aborto suma como gestación pero no como paridad; por eso, con dos embarazos y ningún parto, la mujer es nulípara.

VILLAPEPA ENAM: Un aborto cuenta como gestación pero no como paridad. Con un embarazo actual más un aborto previo son dos gestaciones (segundigesta), pero como nunca ha tenido un parto de producto viable, la paciente es nulípara. Gestación y paridad se cuentan por separado.

172. Varón de 62 años se encuentra en paro cardiorrespiratorio en la sala de espera de un hospital de nivel III. Se inicia de inmediato RCP de alta calidad. Al conectar el monitor desfibrilador, se observa un patrón de fibrilación ventricular. Según las guías de reanimación avanzada en adultos. ¿Cuál es la intervención más adecuada a realizar a continuación?

- A. Realizar desfibrilación con 200 J bifásico
- B. Administrar Adrenalina 1 mg EV
- C. Colocar acceso intraóseo
- D. Administrar Amiodarona 300mg EV

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

En un paro cardíaco, lo primero que se hace tras iniciar las compresiones es mirar el monitor y clasificar el ritmo en dos grandes grupos, porque de eso depende toda la conducta: ritmos que responden a la descarga eléctrica y ritmos que no. La fibrilación ventricular es el ejemplo por excelencia de un ritmo desfibrilable: el corazón tiembla de forma caótica, sin bombear, y la única cosa capaz de reordenar esa actividad eléctrica es la descarga del desfibrilador. Por eso, apenas se identifica una fibrilación ventricular, la intervención inmediata y prioritaria es desfibrilar, aplicar la descarga, en este caso con doscientos julios en un equipo bifásico. Cada minuto de

retraso en la descarga reduce las posibilidades de recuperar al paciente, así que nada debe anteponerse a ella. La adrenalina sí forma parte de la reanimación, pero su momento es después de la primera descarga; en un ritmo desfibrilable la secuencia es descargar primero y luego, si persiste, administrar la adrenalina, no al revés. La amiodarona es un antiarrítmico que también se usa en la fibrilación ventricular, pero aún más tarde: se reserva para cuando la fibrilación resiste varias descargas, típicamente tras la tercera, de modo que tampoco va ahora. Colocar un acceso intraóseo es útil para poder administrar los fármacos cuando no hay una vía venosa, pero es un paso de soporte que jamás debe retrasar la desfibrilación; conseguir un acceso puede hacerse en paralelo, mientras lo prioritario, ante una fibrilación ventricular, es aplicar de inmediato la descarga.

VILLAPEPA ENAM: La fibrilación ventricular es un ritmo desfibrilable: la intervención inmediata es la desfibrilación, sin anteponer nada. La adrenalina se administra tras la primera descarga y la amiodarona tras la tercera; conseguir el acceso venoso o intraóseo no debe retrasar la descarga.

173. Primigesta de 35 semanas de gestación acude por prurito palmo-plantar que se intensifica en las noches. Examen: PA 100/60 mmHg, FC 72x', altura uterina 30 cm, frecuencia cardíaca fetal 138 x'. Laboratorio: ácidos biliares séricos de 110 $\mu\text{mol/L}$ y transaminasas moderadamente elevadas. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para mejorar el pronóstico fetal en esta paciente?

- A. Sulfato de magnesio
- B. Betametasona
- C. Ácido ursodesoxicólico
- D. Metformina

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Primero hay que reconocer la enfermedad por su cuadro tan característico. Una embarazada del tercer trimestre con picazón intensa en las palmas de las manos y las plantas de los pies, que empeora de noche, junto con los ácidos biliares muy elevados en la sangre y las transaminasas altas, tiene una colestasis intrahepática del embarazo: la bilis no fluye bien y los ácidos biliares se acumulan, y son esos ácidos los que producen el prurito. Lo importante es que esos ácidos biliares elevados no solo molestan a la madre, sino que son tóxicos para el feto y aumentan el riesgo de complicaciones e incluso de muerte fetal. Entonces, para mejorar el pronóstico del bebé hay que bajar esos ácidos biliares, y el fármaco que hace precisamente eso es el ácido ursodesoxicólico: mejora el flujo de la bilis, disminuye la concentración de ácidos biliares en la sangre materna, alivia el prurito y reduce el riesgo fetal. Por eso es la respuesta. El sulfato de magnesio es neuroprotector fetal y anticonvulsivante en la preeclampsia, no tiene nada que ver con la colestasis ni con bajar los ácidos biliares. La betametasona sirve para madurar los pulmones del feto ante un parto pretérmino; podría usarse si se adelantara el nacimiento, pero no trata la colestasis ni mejora el pronóstico por el mecanismo de la enfermedad, que es el exceso de ácidos biliares. La metformina es un antidiabético, útil en la diabetes o la resistencia a la insulina, sin ningún papel en este cuadro; lo que mejora el pronóstico fetal en la colestasis del embarazo es el ácido ursodesoxicólico.

VILLAPEPA ENAM: Prurito palmo-plantar de predominio nocturno en el tercer trimestre con ácidos biliares elevados = colestasis intrahepática del embarazo. El ácido ursodesoxicólico baja los ácidos biliares, alivia el prurito y mejora el pronóstico fetal. El sulfato de magnesio y la betametasona tienen otras indicaciones.

174. Mujer de 49 años con enfermedad renal crónica en programa de hemodiálisis, acude al servicio de urgencias por palpitaciones y mareos, luego de haberse ausentado a tres sesiones consecutivas de diálisis. EKG: bradicardia, ensanchamiento del complejo QRS y ondas T altas y picudas. ¿Qué alteración explica con mayor probabilidad este cuadro?

- A. Hipomagnesemia
- B. Hiperkalemia

C. Hipernatremia

D. Hipercalcemia

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Hay que unir tres cosas: la enfermedad de base, lo que pasó, y lo que muestra el electrocardiograma. La paciente tiene enfermedad renal crónica y está en diálisis, es decir sus riñones no eliminan el potasio y depende de la máquina para depurarlo; y faltó a tres sesiones seguidas, con lo cual el potasio se le fue acumulando en la sangre sin poder eliminarse. Eso ya orienta con fuerza a una hiperkalemia, un potasio elevado. Y el electrocardiograma lo confirma, porque el potasio alto tiene un patrón muy característico que va apareciendo por etapas: primero las ondas T altas y picudas, como en pico, que son el signo más temprano; luego, al subir más, el ensanchamiento del complejo QRS y la bradicardia, que anuncian que el corazón está en peligro de una arritmia grave. Ese conjunto, ondas T picudas más QRS ancho y bradicardia, en una paciente que dejó de dializarse, es la firma de la hiperkalemia. Por eso es la respuesta, y además una emergencia. La hipomagnesemia se asocia más bien a otras arritmias y no produce este patrón de T picudas con QRS ancho por acumulación. La hipernatremia, el sodio elevado, da sobre todo síntomas neurológicos por deshidratación de las células, no este cuadro electrocardiográfico. La hipercalcemia acorta el intervalo QT y produce síntomas digestivos y neurológicos, pero no las ondas T picudas ni el ensanchamiento del QRS; lo que explica este cuadro en una paciente que faltó a la diálisis es la hiperkalemia.

VILLAPEPA ENAM: Paciente en diálisis que falta a sus sesiones + ondas T altas y picudas con QRS ancho y bradicardia = hiperkalemia. Las T picudas son el signo electrocardiográfico más temprano del potasio elevado; el ensanchamiento del QRS anuncia riesgo de arritmia grave. Es una emergencia.

175. Varón de 35 años, acude al servicio de emergencia por quemadura debido a llama directa hace 30 minutos. Examen: lesión térmica en cara, cuello y parte anterior del tórax, con voz ronca, estridor laríngeo audible y taquipnea. ¿Cuál es la prioridad en el manejo inicial?

A. Realizar lavado con solución salina

B. Administrar líquidos intravenosos

C. Aplicar apósitos estériles en las áreas quemadas

D. Asegurar la vía aérea mediante intubación

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

En todo paciente grave el orden de prioridades es siempre el mismo, la secuencia vital que empieza por la vía aérea, y este caso es el ejemplo perfecto de por qué. El paciente tiene quemaduras en la cara y el cuello por llama directa y, sobre todo, tres signos de alarma que hay que saber leer: la voz ronca, el estridor laríngeo, ese silbido audible al respirar, y la taquipnea. Esos signos indican que el calor ha lesionado la vía aérea y que la laringe se está empezando a cerrar. El problema es que una quemadura de la vía aérea produce un edema que progresa rápidamente en las siguientes horas, y ese edema puede hinchar tanto la garganta que la cierre por completo y el paciente ya no pueda respirar ni se pueda intubar. Por eso la prioridad absoluta es asegurar la vía aérea intubando de forma precoz, ahora que todavía se puede, antes de que el edema la obstruya; intubar tarde, cuando la vía aérea ya está cerrada, puede ser imposible. Administrar líquidos intravenosos es fundamental en el quemado para prevenir el shock y forma parte del manejo, pero corresponde al paso siguiente, a la circulación; primero la vía aérea, porque de nada sirve reponer volumen si el paciente no puede respirar. Aplicar apósitos estériles en las quemaduras es parte del cuidado local de las lesiones, pero no atiende el peligro inmediato que es la obstrucción de la vía aérea. El lavado con solución salina tampoco resuelve lo urgente. Ante los signos de quemadura de la vía aérea, la prioridad es intubar para asegurarla antes de que el edema la cierre.

VILLAPEPA ENAM: Quemadura en cara y cuello con voz ronca, estridor y taquipnea = lesión de la vía aérea con edema progresivo. La prioridad es intubar precozmente para asegurar la vía aérea antes de que el edema la obstruya y la intubación se vuelva imposible; la reposición de líquidos es el paso siguiente.

176. Varón 30 años, presenta desde hace 3 meses tos productiva, sudoración nocturna y pérdida de 8 kg de peso. Vive en un distrito con alta incidencia de TB. Rx. tórax: cavidad en lóbulo superior derecho. Xpert MTB/RIF en esputo: M. tuberculosis positivo, sin resistencia a rifampicina. ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?

- A. Iniciar esquema RHZE y notificar obligatoriamente el caso
- B. Derivar a tercer nivel y hacer estudio de inmunodeficiencia
- C. Tratar síntomas y repetir Xpert en 3 meses
- D. Solicitar TC de tórax contrastada y descartar neoplasia

RESPUESTA: A

COMENTARIO VILLAMEDIC:

El caso ya está diagnosticado, así que la pregunta es qué hacer con un diagnóstico de tuberculosis en la mano. El paciente tiene el cuadro clásico, tos de meses, sudoración nocturna y baja de peso, una caverna en la radiografía, y una prueba molecular, el Xpert, que confirma la presencia del bacilo de la tuberculosis y añade un dato clave: sin resistencia a la rifampicina, es decir, es una tuberculosis sensible a los fármacos de primera línea. Con eso, la conducta correcta tiene dos partes que van juntas. La primera es iniciar de inmediato el tratamiento con el esquema de primera línea, las cuatro drogas conocidas por sus siglas RHZE, que son rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol, el esquema estándar para la tuberculosis sensible. La segunda parte es la notificación obligatoria del caso, porque la tuberculosis es una enfermedad de declaración obligatoria por su importancia para la salud pública: notificarla permite iniciar el estudio de los contactos y cortar la cadena de transmisión. Por eso la respuesta reúne ambas acciones. Repetir el Xpert en tres meses tratando solo los síntomas es peligroso e inaceptable: retrasar el tratamiento de una tuberculosis ya confirmada deja avanzar la enfermedad y contagiar a otros. Derivar al tercer nivel y estudiar una inmunodeficiencia no es el paso inicial en un caso de tuberculosis sensible sin datos que sugieran inmunosupresión; puede manejarse en el primer nivel según la norma. Pedir una tomografía para descartar un cáncer no tiene sentido cuando ya hay confirmación microbiológica de tuberculosis; lo que corresponde es iniciar el esquema RHZE y notificar el caso.

VILLAPEPA ENAM: Tuberculosis confirmada por Xpert sin resistencia a rifampicina = iniciar de inmediato el esquema de primera línea RHZE y notificar obligatoriamente el caso. La tuberculosis es de declaración obligatoria para estudiar contactos; retrasar el tratamiento de un caso confirmado es inaceptable.

177. Mujer de 82 años, acude por dolor abdominal tipo cólico, náuseas y distensión abdominal y dolor irradiado a cara interna del muslo derecho. Examen: adelgazada, abdomen: distendido, RHA incrementados, signo de Howship-Romberg (+). Tacto vaginal: masa dolorosa en pared anterolateral. ¿A qué tipo de hernia corresponde?

- A. Inguinal directa
- B. Obturatriz
- C. Femoral
- D. Inguinal indirecta

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La pista que resuelve el caso es un signo con nombre propio que casi nadie más produce. La paciente tiene un cuadro de obstrucción intestinal, con dolor cólico, náuseas, distensión y ruidos aumentados, pero lo que orienta al tipo de hernia es el dolor irradiado a la cara interna del muslo y, sobre todo, el signo de Howship-Romberg positivo. Ese signo, el dolor en la cara interna del muslo que empeora al extender o rotar la cadera, se produce porque una hernia atrapa y comprime el nervio obturador al pasar por el agujero obturador de la pelvis. Es prácticamente exclusivo de la hernia obturatriz. Además, el perfil encaja a la perfección: una mujer muy anciana y delgada, porque la pérdida de la grasa que normalmente taponaba ese orificio deja el camino libre para que se forme la hernia; por eso se la llama la hernia de las viejas flacas. Y el tacto que palpa una masa dolorosa en la pared lateral de la pelvis termina de confirmarlo. Por eso la respuesta es la hernia obturatriz. La hernia femoral también es más frecuente en mujeres y puede obstruir, pero se presenta como un bulto por debajo del ligamento inguinal, en la raíz del muslo, y no produce el signo de Howship-Romberg por compresión del nervio obturador. Las hernias inguinales, tanto la directa como la indirecta, aparecen por encima del ligamento inguinal y son más típicas del varón, sin el dolor característico en la cara interna del muslo; el conjunto de obstrucción intestinal con signo de Howship-Romberg en una anciana delgada es la hernia obturatriz.

VILLAPEPA ENAM: Obstrucción intestinal con dolor irradiado a la cara interna del muslo y signo de Howship-Romberg positivo en una anciana delgada = hernia obturatriz (comprime el nervio obturador). Es la hernia de las mujeres ancianas y delgadas; la femoral da un bulto en la raíz del muslo sin ese signo.

178. Se requiere administrar un fármaco muy hidrofílico, pero fuertemente irritante para la mucosa gastrointestinal, necesario para alcanzar concentraciones plasmáticas rápidas y seguras. ¿Cuál es la vía de administración sistémica alternativa?

- A. Oral mediante comprimidos o cápsulas recubiertas
- B. Intramuscular profunda en músculo grande
- C. Inhalatoria mediante aerosol dosificado
- D. Endovenosa en infusión controlada

RESPUESTA: D

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La estrategia es leer cada propiedad del fármaco como un requisito que va descartando vías hasta dejar una sola. Son tres exigencias. Primera, es muy hidrofílico, es decir se disuelve bien en agua pero atraviesa mal las membranas, que son grasas; por eso se absorbe de forma pobre e irregular cuando hay que cruzar barreras, como en el intestino. Segunda, es fuertemente irritante para la mucosa gastrointestinal, lo que hace peligrosa o mal tolerada la vía oral. Y tercera, se necesita alcanzar concentraciones en sangre rápidas y seguras. Si vamos descartando: la vía oral queda eliminada por partida doble, porque el fármaco irrita el tubo digestivo y además, al ser tan hidrofílico, se absorbería mal; ni siquiera las cápsulas recubiertas resuelven la mala absorción ni garantizan rapidez. La vía inhalatoria sirve para gases y fármacos volátiles que se absorben por el pulmón, no para cualquier fármaco hidrofílico, y no aplica aquí. La intramuscular podría evitar el estómago, pero un fármaco fuertemente irritante también dañaría el músculo y produciría dolor y lesión en el sitio de inyección, y la absorción desde el músculo no es tan inmediata ni tan predecible como se exige. La única vía que cumple las tres condiciones es la endovenosa: al inyectar directamente en la sangre se evita por completo el tubo digestivo irritable, no importa que el fármaco sea hidrofílico porque no tiene que atravesar ninguna membrana para absorberse, y se consiguen concentraciones plasmáticas inmediatas; además, administrarla en infusión controlada permite hacerlo de forma segura, dosificando la velocidad. Por eso la vía endovenosa en infusión controlada es la respuesta.

VILLAPEPA ENAM: Un fármaco muy hidrofílico (mala absorción), irritante para la mucosa digestiva (descarta la vía oral) y que requiere niveles plasmáticos rápidos y seguros = vía endovenosa en infusión controlada. La vía intravenosa evita el tubo digestivo, no depende de atravesar membranas y logra concentraciones inmediatas.

179. Un médico observa que en el centro de salud A hay mayor tendencia a la obesidad que el centro de salud B. Para corroborar sus sospechas ha comparado el Índice de Masa Corporal de 30 personas tanto del grupo A como del B. Considerando una distribución normal en los datos obtenidos y homocedasticidad en las varianzas. ¿Qué prueba estadística es la más adecuada a usarse para ver si hay diferencias significativas?

- A. Prueba de Kolmogorov Smirnov
- B. T de Student para muestras independientes
- C. Chi Cuadrado
- D. Análisis multivariado

RESPUESTA: B

COMENTARIO VILLAMEDIC:

Para elegir una prueba estadística hay que responder tres preguntas sobre los datos, y el enunciado da las tres respuestas. Primera pregunta: qué tipo de variable se compara. Aquí es el índice de masa corporal, que es una variable numérica, cuantitativa, y lo que en realidad se comparan son sus promedios entre los dos centros. Segunda: cuántos grupos y cómo se relacionan. Son dos grupos, el A y el B, y son independientes, formados por personas distintas sin relación entre sí. Tercera: se cumplen los supuestos para usar una prueba paramétrica. El enunciado lo dice expresamente: los datos siguen una distribución normal y hay homocedasticidad, es decir las varianzas de ambos grupos son parecidas. Cuando se comparan los promedios de una variable numérica entre dos grupos independientes, con normalidad y varianzas homogéneas, la prueba indicada es la t de Student para muestras independientes. Por eso es la respuesta. La prueba de Kolmogorov-Smirnov no compara grupos: sirve para evaluar si unos datos siguen una distribución normal, es decir es una de las pruebas que se usaría antes, para comprobar el supuesto que el enunciado ya da por cumplido. El Chi cuadrado se emplea para variables cualitativas, categóricas, por ejemplo comparar proporciones de obesos y no obesos, pero no para comparar promedios de una variable numérica como el índice de masa corporal. El análisis multivariado se reserva para cuando intervienen varias variables a la vez, mucho más complejo de lo que este problema requiere; para comparar la media del índice de masa corporal entre dos grupos independientes normales, la prueba correcta es la t de Student.

VILLAPEPA ENAM: Comparar el promedio de una variable numérica (índice de masa corporal) entre dos grupos independientes, con distribución normal y varianzas homogéneas = t de Student para muestras independientes. El Chi cuadrado es para variables categóricas y Kolmogorov-Smirnov evalúa la normalidad, no compara grupos.

180. Escolar de 8 años, previamente sano, es traído por fiebre de hasta 39 °C y dolor abdominal de 5 días. Examen: múltiples lesiones ampollares con áreas de descamación en pies y antebrazos. Se inicia oxacilina intravenosa por sospecha de infección estafilocócica de piel. Al tercer día de hospitalización la fiebre cede, pero persiste decaído. Exámenes: leucocitos 2 000/mm³ (segmentados 86%), plaquetas 40 000/mm³, hemoglobina 11 g/dL, AST (TGO) 660 U/L, ALT (TGP) 730 U/L, triglicéridos 300 mg/dL. No hay sangrado activo ni visceromegalias evidentes. Ante este cuadro, ¿Qué diagnóstico es el más probable?

- A. Leucemia linfoblástica aguda
- B. Aplasia medular adquirida
- C. Síndrome hemofagocítico secundario
- D. Hepatitis viral aguda

RESPUESTA: C

COMENTARIO VILLAMEDIC:

La clave es no quedarse en la infección de la piel y reconocer que los exámenes dibujan un síndrome muy concreto. Reunamos las alteraciones de este niño que tuvo una infección: tiene los glóbulos blancos bajos y las plaquetas bajas, es decir dos líneas de la sangre disminuidas, lo que se llama citopenias; tiene las transaminasas muy elevadas, o sea el hígado inflamado; y tiene los triglicéridos altos. Fiebre prolongada, más citopenias en dos o tres líneas, más transaminasas altas, más triglicéridos elevados, todo desencadenado por una infección, es el patrón del síndrome hemofagocítico, en su forma secundaria, gatillada por un proceso infeccioso. Es una respuesta inmune descontrolada en la que las células defensoras se activan de forma exagerada y empiezan a devorar las células de la sangre, lo que explica la caída de las series y el compromiso del hígado. Por eso es el diagnóstico más probable. La leucemia linfoblástica aguda también puede dar citopenias, pero típicamente se acompaña de células inmaduras, los blastos, en la sangre, y no explica de forma característica esta combinación con triglicéridos altos y transaminasas tan elevadas en el contexto de una infección reciente. La aplasia medular produce el descenso de las tres series por una médula que deja de producir, pero no da la hipertrigliceridemia ni el compromiso hepático que definen este síndrome. La hepatitis viral aguda explicaría las transaminasas altas, pero no las citopenias ni los triglicéridos elevados; lo que reúne todos los hallazgos, fiebre, citopenias, hígado comprometido y triglicéridos altos tras una infección, es el síndrome hemofagocítico secundario.

VILLAPEPA ENAM: Fiebre persistente + citopenias en dos o más líneas + transaminasas muy elevadas + hipertrigliceridemia, desencadenados por una infección, = síndrome hemofagocítico secundario (activación inmune descontrolada que fagocita las células sanguíneas). La leucemia mostraría blastos y la aplasia no da hipertrigliceridemia ni compromiso hepático.

